Optimal Untuk Negeri

optimal

Buku Ajar

MANAJEMEN NYERI DAN KENYAMANAN PERSALINAN

Nonfarmakologi dan Farmakologi Dasar

Yeni Fitrianingsih • Ekta Puspita Sari • Dede Waslia • Nova Avianti Rahayu

Editor : Prof. Dr. Bdn. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb.



Buku Ajar :

Manajemen Nyeri dan Kenyamanan Persalinan: Nonfarmakologi dan Farmakologi Dasar

Penulis:
Dr. Yeni Fitrianingsih, SST, MKes.
Ekta Puspita Sari, S.ST., M.Kes.
Bdn. Dede Waslia, SST, MKM.
Bdn. Nova Avianti Rahayu, S.Tr.Keb., M.Keb.

Editor : Prof. Dr. Bdn. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb.

Optimal
Untuk
Negeri

Buku Ajar:

Manajemen Nyeri dan Kenyamanan Persalinan: Nonfarmakologi dan Farmakologi Dasar

Penulis:
Dr. Yeni Fitrianingsih, SST, MKes.
Ekta Puspita Sari, S.ST., M.Kes.
Bdn. Dede Waslia, SST, MKM.
Bdn. Nova Avianti Rahayu, S.Tr.Keb., M.Keb.

Editor :
Prof. Dr. Bdn. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb.

Desain Sampul: Ivan Zumarano
Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7756-89-3

Cetakan Pertama: September, 2026
Hak Cipta 2026
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2026
by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Website : optimaluntuknegeri.com
Instagram : @bimbel.optimal
Tiktok : @maskokooo

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta
Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar berjudul Manajemen Nyeri dan Kenyamanan Persalinan: Nonfarmakologi dan Farmakologi Dasar ini dapat disusun dengan baik. Buku ajar ini disusun sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan, keperawatan, tenaga kesehatan, serta pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap pelayanan persalinan yang aman, nyaman, humanis, dan berbasis evidence-based practice.

Nyeri persalinan merupakan pengalaman fisiologis yang kompleks dan bersifat individual. Setiap ibu dapat memiliki respons yang berbeda terhadap nyeri, baik secara fisik, psikologis, emosional, maupun sosial. Oleh karena itu, tenaga kesehatan dituntut untuk mampu memahami konsep nyeri persalinan secara menyeluruh, melakukan pengkajian yang tepat, memberikan dukungan emosional, serta menerapkan intervensi manajemen nyeri yang sesuai dengan kondisi ibu dan janin. Manajemen nyeri yang baik tidak hanya bertujuan mengurangi keluhan nyeri, tetapi juga meningkatkan rasa nyaman, rasa aman, kepercayaan diri ibu, serta keselamatan selama proses persalinan.

Buku ajar ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab. Bab 1 membahas konsep dasar nyeri persalinan dan kenyamanan ibu, meliputi prinsip, tujuan, serta aspek keselamatan dalam pelayanan persalinan. Bab 2 menguraikan fisiologi nyeri persalinan, termasuk sumber nyeri, jalur penghantaran nyeri, serta respons fisiologis ibu dan janin. Bab 3 membahas pengkajian nyeri dan kenyamanan, meliputi penggunaan skala nyeri, pengenalan tanda klinis, serta pentingnya dokumentasi yang akurat. Bab 4 mengkaji dukungan emosional dan pendampingan persalinan, khususnya dalam aspek komunikasi terapeutik, teknik relaksasi, dan peningkatan kontrol diri ibu selama persalinan.

Melalui buku ajar ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai manajemen nyeri dan kenyamanan persalinan, baik melalui pendekatan nonfarmakologi maupun pemahaman dasar farmakologi. Materi yang disajikan diharapkan dapat membantu mahasiswa dan tenaga kesehatan dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan klinis, sikap empatik, serta kemampuan berpikir kritis dalam memberikan asuhan kepada ibu bersalin.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan motivasi dalam proses penyusunan buku ajar ini. Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi cakupan materi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya.

Akhir kata, semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan praktik pelayanan persalinan yang aman, nyaman, bermartabat, dan berorientasi pada kebutuhan ibu serta keselamatan ibu dan bayi.

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar ..... **iii**
Daftar Isi ..... **v**

BAB 1 KONSEP DASAR NYERI PERSALINAN DAN KENYAMANAN IBU: PRINSIP, TUJUAN, DAN KESELAMATAN **1**
A. Pendahuluan 6
B. Konsep Dasar Nyeri Persalinan dan Kenyamanan Ibu: Prinsip, Tujuan, dan Keselamatan dalam Asuhan Kebidanan 8
C. Contoh Kasus Penerapan Dokumentasi Asuhan Kebidanan (Nyeri Persalinan). 14
D. Rangkuman Materi 19
Glosarium **21**
Referensi **24**

BAB 2 FISIOLOGI NYERI PERSALINAN: SUMBER NYERI, JALUR NYERI, DAN RESPONS FISIOLOGIS IBU–JANIN **26**
A. Pendahuluan 30
B. Sumber Nyeri Persalinan 33
C. Jalur Nyeri Persalinan 33
D. Respon Fisiologis Ibu dan Janin 37
E. Rangkuman 42
Glosarium **44**
Referensi **47**

BAB 3 PENGKAJIAN NYERI DAN KENYAMANAN : SKALA NYERI, TANDA KLINIS, DAN DOKUMENTASI **48**
A. Aktifitas Belajar (Scaffolding) 52
B. Ringkasan 73
Referensi **78**

BAB 4 DUKUNGAN EMOSIONAL DAN PENDAMPINGAN PERSALINAN: KOMUNIKASI, RELAKSASI, DAN KONTROL DIRI **80**
A. Pendahuluan 84
B. Faktor Psikologis, Sosial, dan Budaya dalam Persepsi Nyeri Persalinan 86
C. Dukungan Emosional dalam Persalinan 87
D. Komunikasi terapeutik dalam asuhan persalinan 89

E. Informed choice dalam pelayanan kebidanan 91
F. Peran Pendamping Persalinan 93
G. Strategi Relaksasi dan Coping dalam Persalinan 94
H. Pendokumentasian Asuhan Nyeri Persalinan 95
I. Ringkasan 111
Referensi 117

Profil Penulis 119

BAB 1

KONSEP DASAR NYERI PERSALINAN DAN KENYAMANAN IBU: PRINSIP, TUJUAN, DAN KESELAMATAN

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan sensitivitas budaya dalam pengelolaan nyeri dan kenyamanan persalinan.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik, informed choice, dan kolaborasi dengan ibu, keluarga, dan tim kesehatan.	CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan keselamatan pasien, PPI, K3, dan manajemen risiko dalam intervensi manajemen nyeri persalinan.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-4	Melakukan pengkajian komprehensif dan clinical reasoning berbasis data untuk menentukan rencana manajemen nyeri dan kenyamanan ibu–janin.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-7
CPL-5	Melaksanakan intervensi nonfarmakologi dan mendukung manajemen farmakologi dasar sesuai kewenangan secara aman dan bermutu.	CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Melakukan edukasi, dokumentasi terstandar, dan pemanfaatan bukti ilmiah dasar untuk evaluasi hasil dan peningkatan mutu asuhan.	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Mengevaluasi prinsip, tujuan, dan aspek keselamatan manajemen nyeri persalinan yang berpusat pada ibu–janin.
CPMK-2	Menganalisis fisiologi nyeri persalinan (sumber, jalur, respons ibu–janin) sebagai dasar pemilihan intervensi dan pemantauan.
CPMK-3	Menganalisis faktor psikologis, sosial, budaya, dan pengalaman melahirkan serta implikasinya terhadap persepsi nyeri dan kenyamanan.
CPMK-4	Melaksanakan pengkajian nyeri/kenyamanan, interpretasi tanda klinis, serta pendokumentasian terstandar untuk pemantauan berkelanjutan.
CPMK-5	Merancang dan menerapkan strategi nonfarmakologi serta dukungan emosional dengan komunikasi terapeutik dan prinsip keamanan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-6	Mengintegrasikan farmakologi dasar analgesia persalinan dengan kolaborasi, pemantauan, dan kewaspadaan efek samping sesuai kewenangan.
CPMK-7	Menyusun rencana manajemen nyeri pada kondisi khusus, mengevaluasi hasil (kepuasan/outcome), dan merancang edukasi tindak lanjut berbasis bukti.

C. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Konsep Dasar Nyeri Persalinan dan Kenyamanan Ibu: Prinsip, Tujuan, dan Keselamatan	1.1 Menjelaskan tujuan, prinsip, dan batas kewenangan dalam manajemen nyeri serta kenyamanan persalinan	1.2 Mengidentifikasi risiko/kontraindikasi umum dan langkah pencegahan untuk keselamatan ibu–janin	CPMK-1	CPMK-3; CPMK-5

D. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis berbasis kasus (CBT/SAQ)	Menetapkan tujuan manajemen nyeri dan langkah keselamatan prioritas; mengidentifikasi kontraindikasi/batas kewenangan pada skenario	10	Lembar jawaban ujian
CPMK-3	Analisis skenario + refleksi terstruktur	Mengidentifikasi faktor psikososial-budaya yang relevan; merumuskan pendekatan komunikasi yang sensitif dan realistis	10	Tugas refleksi & analisis skenario
CPMK-5	OSCE keterampilan nonfarmakologi (simulasi)	Melakukan coaching dukungan emosional/pernapasan/relaksasi; menerapkan teknik fisik/lingkungan dengan keamanan dan evaluasi respons	25	Checklist OSCE + catatan evaluasi respons

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Identifikasi tujuan dan prinsip keselamatan pada skenario	Tujuan tidak jelas/keliru; aspek keselamatan terabaikan	Tujuan cukup jelas; keselamatan disebut umum namun belum memprioritaskan risiko utama	Tujuan tepat; keselamatan diprioritaskan, ada kekurangan minor	Tujuan sangat tepat; keselamatan komprehensif, proaktif, berbasis risiko ibu–janin
1.2 Penetapan intervensi awal sesuai kondisi & kewenangan	Pilihan tidak sesuai kondisi/kewenangan; berpotensi tidak aman	Pilihan sebagian sesuai; mitigasi risiko/kontraindikasi belum lengkap	Pilihan sesuai; mitigasi risiko jelas, masih ada detail minor yang kurang	Pilihan paling sesuai; mitigasi risiko lengkap dan disertai alasan yang kuat

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Pemetaan sumber & jalur nyeri sesuai kala	Banyak konsep salah; tidak dapat mengaitkan dengan kala	Sebagian benar; masih ada kekeliruan pada pemetaan/urutan	Hampir seluruhnya benar; ada kekeliruan minor	Akurat dan lengkap; mampu mengaitkan pola nyeri dengan proses persalinan
2.2 Interpretasi respons ibu–janin dan implikasi pemantauan	Salah menafsir respons; rekomendasi pemantauan tidak tepat	Menafsir sebagian; rekomendasi pemantauan masih umum	Menafsir tepat; rekomendasi pemantauan relevan dan aman	Menafsir sangat tepat; rekomendasi pemantauan spesifik, antisipatif, dan rasional

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Identifikasi faktor psikologis–sosial–budaya	Faktor kunci tidak teridentifikasi; asumsi tidak berdasar	Faktor teridentifikasi sebagian; masih ada bias/kurang lengkap	Faktor teridentifikasi baik dan relevan; bias minimal	Faktor lengkap, relevan, dan berimbang; menunjukkan sensitivitas budaya yang kuat
3.2 Rekomendasi pendekatan	Pendekatan tidak sesuai; berpotensi	Pendekatan cukup sesuai namun generik; kurang	Pendekatan sesuai; menyesuaikan	Pendekatan sangat sesuai; empatik, trauma-informed,

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
komunikasi & dukungan	meningkatkan distres	menyesuaikan konteks ibu	konteks dan mendukung coping	dan memfasilitasi kontrol diri ibu

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Pengukuran nyeri/kenyamanan (pemilihan skala & konsistensi)	Skala/teknik tidak tepat; pengukuran tidak konsisten	Skala cukup tepat; konsistensi dan waktu pengukuran belum optimal	Skala tepat; pengukuran konsisten sesuai kebutuhan pemantauan	Skala sangat tepat; pengukuran konsisten, responsif terhadap perubahan kondisi
4.2 Dokumentasi temuan–tindakan–respons	Catatan tidak lengkap/tidak runtut; sulit ditindaklanjuti	Catatan cukup lengkap; masih ada bagian penting yang hilang	Catatan lengkap dan runtut; mudah ditelusuri	Catatan sangat lengkap, jelas, standar; mendukung pengambilan keputusan dan continuity of care

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Coaching dukungan emosional/pernapasan/relaksasi	Komunikasi tidak terapeutik; instruksi tidak dipahami; tidak aman	Komunikasi cukup; instruksi dipahami sebagian; perlu banyak arahan	Komunikasi terapeutik; instruksi jelas; aman dengan koreksi minor	Komunikasi sangat efektif; memberdayakan ibu & pendamping; aman dan adaptif
5.2 Implementasi teknik fisik/lingkungan & evaluasi respons	Teknik tidak sesuai/berisiko; tidak mengevaluasi respons	Teknik cukup sesuai; evaluasi respons minim/umum	Teknik sesuai dan aman; evaluasi respons jelas dan berkelanjutan	Teknik sangat tepat; evaluasi respons terukur, adaptasi cepat, dan berorientasi kenyamanan

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Kesesuaian pemilihan analgesia dasar & identifikasi risiko	Pilihan tidak sesuai indikasi; risiko/kontraindikasi terlewat	Pilihan cukup sesuai; risiko/kontraindikasi disebut sebagian	Pilihan sesuai; risiko/kontraindikasi utama teridentifikasi	Pilihan paling sesuai; risiko/kontraindikasi lengkap dan disertai pertimbangan rasional
6.2 Pemantauan, tindak lanjut efek samping, dan komunikasi kolaboratif	Tidak memantau parameter kunci; tindak lanjut tidak tepat	Memantau sebagian; tindak lanjut dan komunikasi masih kurang terstruktur	Pemantauan tepat; tindak lanjut aman; komunikasi kolaboratif jelas	Pemantauan komprehensif; tindak lanjut antisipatif; komunikasi kolaboratif sangat efektif dan terdokumentasi

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Perencanaan manajemen nyeri pada kondisi khusus (prioritas, integrasi, eskalasi)	Rencana tidak sesuai risiko; prioritas/eskalasi tidak jelas	Rencana cukup sesuai; integrasi modalitas dan eskalasi belum mantap	Rencana sesuai; prioritas jelas; integrasi dan eskalasi aman	Rencana sangat kuat; prioritas tajam; integrasi komprehensif; eskalasi/rujukan tepat waktu dan berbasis risiko
7.2 Evaluasi hasil & rencana edukasi tindak lanjut	Tidak menetapkan indikator; edukasi tidak relevan/tidak dapat diterapkan	Indikator ada namun terbatas; edukasi umum	Indikator relevan; edukasi jelas dan dapat diterapkan	Indikator lengkap dan terukur; edukasi sangat personal, realistis, mendukung coping dan rencana lanjutan

A. Pendahuluan

Persalinan merupakan proses fisiologis yang ditandai dengan kontraksi uterus yang menyebabkan pembukaan serviks dan pengeluaran janin. Proses ini hampir selalu disertai dengan nyeri yang intensitasnya bervariasi pada setiap ibu. Nyeri persalinan tidak hanya berdampak pada kondisi fisik, tetapi juga mempengaruhi kondisi psikologis, seperti kecemasan, ketakutan, dan stres yang dapat memperburuk pengalaman persalinan. Nyeri ini bersifat unik dan subjektif, dipengaruhi oleh kondisi fisik, psikologis, budaya, serta pengalaman sebelumnya. Dalam praktik kebidanan, pemahaman terhadap konsep nyeri persalinan tidak hanya penting untuk mengurangi rasa sakit, tetapi juga untuk meningkatkan kenyamanan, rasa aman, serta kepuasan ibu terhadap proses persalinan.

Bab ini akan membahas tentang asuhan kebidanan pada pasien dengan pengalaman nyeri yang buruk menyebabkan trauma psikologis dan menurunkan kepercayaan ibu terhadap pelayanan kesehatan. Tujuan dari penulisan bab ini adalah peserta didik mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memahami serta mengelola nyeri persalinan secara efektif, aman, dan berfokus pada kenyamanan ibu. Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa program studi diploma tiga kebidanan.

Gambaran pembahasan pada Bab ini adalah konsep dasar nyeri persalinan dan kenyamanan ibu: Prinsip, Tujuan, dan Keselamatan. Pada Bab ini juga akan diuraikan beberapa prosedur asuhan kebidanan yang

harus dikuasai seperti menunjukkan sikap empati dan kepedulian terhadap ibu bersalin yang mengalami nyeri, menerapkan prinsip komunikasi terapeutik dalam memberikan asuhan kebidanan, menunjukkan komitmen dalam menjaga kenyamanan dan keselamatan ibu selama persalinan, melakukan pengkajian nyeri persalinan secara sistematis. Untuk memberikan gambaran lebih nyata terkait praktek keperawatan di lahan praktek, akan dilengkapi juga dengan

studi kasus singkat tentang asuhan kebidanan konsep dasar nyeri persalinan dan kenyamanan ibu: Prinsip, Tujuan, dan Keselamatan. Struktur Bab ini terdiri dari pendahuluan, tujuan instruksional dan capaian pembelajaran, materi yang diuraikan dalam beberapa sub bab, latihan studi kasus, Standar Prosedur Operasional (SPO) keterampilan terkait dan dilengkapi dengan rangkuman.

Oleh karena itu, buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif mengenai konsep dasar nyeri persalinan, prinsip kenyamanan ibu, serta pentingnya keselamatan dalam asuhan kebidanan. Buku ini diharapkan mampu menjadi panduan bagi mahasiswa dan

tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan berorientasi pada ibu (woman-centered care).

Tujuan Intruksional dan Capaian Pembelajaran

Tujuan Instruksional Umum

Mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan menerapkan konsep dasar nyeri persalinan serta memberikan asuhan kebidanan yang aman, efektif, dan berfokus pada kenyamanan ibu sesuai prinsip keselamatan pasien.

Tujuan Instruksional Khusus

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian nyeri persalinan dan menguraikan fisiologi dan mekanisme terjadinya nyeri persalinan secara tepat.
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis nyeri pada setiap tahap persalinan.
3. Mahasiswa mampu menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi nyeri ibu (fisik, psikologis, sosial, budaya).
4. Mahasiswa mampu menguraikan prinsip-prinsip manajemen nyeri persalinan berbasis evidence-based practice.
5. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap empati dan kepedulian terhadap ibu bersalin yang mengalami nyeri.
6. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip komunikasi terapeutik dalam memberikan asuhan kebidanan.
7. Mahasiswa mampu menunjukkan komitmen dalam menjaga kenyamanan dan keselamatan ibu selama persalinan.
8. Mahasiswa mampu melakukan pengkajian nyeri persalinan secara sistematis (skala nyeri, lokasi, intensitas).
9. Mahasiswa mampu menerapkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri (relaksasi, teknik napas, massage, posisi).
10. Mahasiswa mampu mengidentifikasi indikasi dan kontraindikasi tindakan farmakologis secara tepat (secara teoritis).
11. Mahasiswa mampu memberikan dukungan fisik dan psikologis untuk meningkatkan kenyamanan ibu.
12. Mahasiswa mampu mendokumentasikan asuhan nyeri persalinan sesuai standar pelayanan kebidanan.
13. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip keselamatan pasien dalam setiap tindakan kebidanan.

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini terdiri dari konsep dasar nyeri persalinan dan kenyamanan ibu: prinsip, tujuan, dan keselamatan dalam asuhan kebidanan, latihan studi kasus, Standar Prosedur Operasional (SPO) keterampilan terkait.

B. Konsep Dasar Nyeri Persalinan dan Kenyamanan Ibu: Prinsip, Tujuan, dan Keselamatan dalam Asuhan Kebidanan

Rencana asuhan kebidanan yang tepat harus disusun agar bidan dapat mengelola pasien dengan efektif**.**

1. Nyeri Persalinan
   a. Pengertian Nyeri Persalinan

      Manajemen nyeri dan kenyamanan persalinan merupakan bagian integral dari asuhan kebidanan yang bertujuan untuk memberikan pengalaman persalinan yang positif sekaligus menjamin keselamatan ibu dan janin.

      Nyeri persalinan adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang dialami oleh ibu selama proses persalinan, sebagai akibat dari kontraksi uterus, dilatasi serviks, serta peregangan jaringan jalan lahir akibat penurunan janin.

      Menurut *International Association for the Study of Pain*, nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial (IASP, 2020). Dalam konteks persalinan, nyeri tidak hanya berkaitan dengan proses fisiologis, tetapi juga dipengaruhi oleh kecemasan, budaya, dan pengalaman sebelumnya (Lowdermilk et al., 2014).

      Dalam praktik kebidanan, nyeri persalinan tidak hanya dipandang sebagai rasa sakit, tetapi juga sebagai bagian integral dari proses kelahiran yang menandakan kemajuan persalinan.

      Nyeri persalinan bukan hanya fenomena fisiologis, tetapi juga melibatkan aspek psikologis, emosional, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, pendekatan penanganannya harus bersifat holistic**,** setiap intervensi untuk mengurangi nyeri harus didasarkan pada identifikasi risiko dan kontraindikasi secara komprehensif agar tidak menimbulkan komplikasi yang merugikan (Marshall & Raynor, 2020; Varney et al., 2020).

      Menurut World Health Organization (WHO), manajemen nyeri merupakan bagian dari pelayanan persalinan yang berpusat pada perempuan (woman-centered care) dan harus disesuaikan dengan kebutuhan serta preferensi ibu. Pengelolaan nyeri persalinan yang tepat menjadi bagian penting dalam asuhan kebidanan untuk meningkatkan kenyamanan ibu serta menjamin keselamatan ibu dan bayi (WHO, 2018).

Nyeri persalinan bersifat:

1) Fisiologis (normal)
2) Progresif (meningkat seiring waktu)
3) Subjektif (berbeda pada setiap individu)

Karakteristik Nyeri Persalinan

1) Bersifat intermiten (datang saat kontraksi)
2) Intensitas semakin meningkat
3) Menjalar dari pinggang ke perut bagian bawah

Dipengaruhi oleh faktor:

1) Emosi (cemas, takut)
2) Lingkungan
3) Dukungan social

2. Tujuan Asuhan Kebidanan dalam Nyeri Persalinan dan Kenyamanan Ibu

Tujuan utama asuhan kebidanan meliputi :

a. Mengurangi Intensitas Nyeri
   Membantu ibu mengelola nyeri secara efektif tanpa meningkatkan risiko.
b. Meningkatkan Kenyamanan Ibu
   Secara fisik: posisi nyaman, lingkungan tenang
   Secara psikologis: rasa aman dan percaya diri
c. Meningkatkan Kepuasan Pengalaman Persalinan
   Persalinan menjadi pengalaman yang bermakna, bukan trauma.
d. Mencegah Komplikasi
   Nyeri berlebihan dapat menyebabkan:
   1) Stres
   2) Hiperventilasi
   3) Gangguan kontraksi
e. Mendukung Proses Persalinan Normal
   Nyeri yang terkontrol membantu ibu lebih kooperatif.
f. Memberikan Pengalaman Persalinan Positif
   Pengalaman yang baik berdampak pada kesehatan mental ibu.

3. Prinsip Manajemen nyeri persalinan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

a. *Woman-Centered Care*
   Pelayanan berfokus pada kebutuhan, nilai, budaya, dan pilihan ibu. Ibu berhak menentukan metode pengurangan nyeri yang diinginkan (WHO, 2018).
b. Keamanan (*Safety*)
   Setiap intervensi harus mempertimbangkan keselamatan ibu dan bayi serta meminimalkan risiko efek samping (Varney et al., 2020).
c. Pendekatan Non-Farmakologis sebagai Lini Pertama

Metode seperti teknik pernapasan, relaksasi, pijat, hidroterapi, aromaterapi, musik, dan dukungan emosional dianjurkan sebelum penggunaan metode farmakologis (Marshall & Raynor, 2020).

d. Kontinuitas Asuhan

Dukungan berkelanjutan dari bidan atau pendamping terbukti menurunkan kebutuhan analgesia dan meningkatkan kepuasan ibu (Bohren et al.,2017).

e. Informed Choice dan Informed Consent

Ibu harus mendapatkan informasi yang lengkap mengenai manfaat dan risiko setiap metode pengelolaan nyeri sebelum memberikan persetujuan (ACOG, 2019).

f. Pendekatan Holistik

Pengelolaan nyeri mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual ibu (Varney et al., 2020).

4. Batas Kewenangan dalam Manajemen Nyeri Persalinan

a. Kewenangan Bidan

Batas kewenangan bidan dalam manajemen nyeri diatur oleh standar praktik kebidanan dan regulasi nasional. Di Indonesia, kewenangan ini diatur dalam:

1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (dan regulasi penggantinya)

b. Lingkup Kewenangan Bidan

1) Metode Non-Farmakologis

Bidan memiliki kewenangan penuh untuk memberikan berbagai metode non-farmakologis, seperti:

a) Teknik pernapasan dan relaksasi
b) Pijat (massage)
c) Kompres hangat/dingin
d) Perubahan posisi
e) Hidroterapi
f) Aromaterapi
g) Dukungan emosional dan spiritual
h) Hypnobirthing dan musik terapi

2) Metode Farmakologis Terbatas

Bidan dapat memberikan obat-obatan tertentu sesuai dengan kewenangan dan standar operasional prosedur, seperti:

a) Analgesik ringan yang diizinkan
b) Inhalasi nitrous oxide (jika tersedia dan sesuai regulasi)

Namun, tindakan berikut bukan kewenangan mandiri bidan dan harus dilakukan oleh dokter spesialis anestesi atau obstetri:

a) Analgesia epidural atau spinal
b) Pemberian opioid kuat tertentu
c) Anestesi umum (ICM, 2019)

c. Indikasi Rujukan

Bidan harus melakukan rujukan apabila:

1) Nyeri tidak dapat dikendalikan dengan metode yang tersedia.
2) Diperlukan analgesia/anestesi tingkat lanjut.
3) Terjadi komplikasi obstetri.
4) Kondisi ibu atau janin menunjukkan tanda bahaya.

5. Pentingnya Identifikasi Risiko dalam Manajemen Nyeri Persalinan

Manajemen nyeri persalinan harus mempertimbangkan kondisi klinis ibu dan janin untuk mencegah komplikasi yang dapat membahayakan keselamatan keduanya. Identifikasi risiko sejak awal memungkinkan tenaga kesehatan memilih metode yang paling aman dan efektif.

Menurut *World Health Organization* (WHO), keselamatan ibu dan bayi merupakan prioritas utama dalam pelayanan intrapartum, dan setiap intervensi harus didasarkan pada penilaian risiko yang komprehensif (WHO, 2018). Selain itu, *International Confederation of Midwives* (ICM) menekankan bahwa bidan harus mampu mengenali kondisi yang memerlukan kewaspadaan atau rujukan untuk menjamin praktik yang aman (ICM, 2019).

a. Identifikasi Risiko pada Ibu

Identifikasi risiko maternal merupakan langkah awal yang penting sebelum menentukan metode manajemen nyeri. Kondisi seperti preeklamsia dan eklampsia dapat menyebabkan gangguan perfusi uteroplasenta dan meningkatkan risiko komplikasi serius, sehingga memerlukan pemantauan ketat terhadap tanda vital ibu serta kesejahteraan janin (WHO, 2018). Perdarahan antepartum, seperti plasenta previa atau solusio plasenta, merupakan kondisi gawat darurat obstetri yang memerlukan penanganan di fasilitas rujukan dan membatasi penggunaan metode tertentu, misalnya hidroterapi atau mobilisasi bebas (Marshall & Raynor, 2020).

Selain itu, penyakit jantung pada ibu dapat meningkatkan risiko dekompensasi selama persalinan akibat peningkatan beban kerja jantung, sehingga diperlukan pendekatan multidisiplin dalam penatalaksanaannya (Varney et al., 2020). Gangguan koagulasi menjadi kontraindikasi utama untuk analgesia regional seperti epidural atau spinal karena berisiko menyebabkan hematoma epidural (*Royal College of Obstetricians and Gynaecologists*, 2021).

Riwayat alergi obat juga harus diidentifikasi untuk mencegah reaksi hipersensitivitas yang dapat membahayakan ibu.

b. Identifikasi Risiko pada Janin

Keselamatan janin merupakan aspek penting dalam pemilihan metode manajemen nyeri. Gawat janin, yang ditandai dengan perubahan denyut jantung janin, memerlukan intervensi segera dan membatasi penggunaan analgesik tertentu yang dapat menekan sistem saraf pusat bayi (*American College of Obstetricians and Gynecologists*, 2019). Prematuritas juga meningkatkan kerentanan terhadap efek obat karena imaturitas organ, terutama sistem pernapasan dan saraf pusat (Marshall & Raynor, 2020).

Selain itu, Restriksi Pertumbuhan Intrauterin (IUGR) menunjukkan keterbatasan cadangan oksigen janin sehingga memerlukan pemantauan yang lebih intensif selama persalinan. Presentasi abnormal, seperti sungsang atau lintang, serta kehamilan ganda meningkatkan risiko komplikasi obstetri dan sering kali memerlukan persalinan di fasilitas dengan kemampuan obstetri dan neonatal yang lebih lengkap (Varney et al., 2020).

c. Kontraindikasi Metode Manajemen Nyeri

Pemilihan metode manajemen nyeri harus mempertimbangkan kontraindikasi yang ada, baik untuk metode non-farmakologis maupun farmakologis.

1) Metode Non-Farmakologis

Metode non-farmakologis seperti teknik pernapasan, relaksasi, mobilisasi, dan dukungan emosional umumnya aman dan direkomendasikan sebagai lini pertama dalam pengelolaan nyeri persalinan. Namun, beberapa metode memiliki kontraindikasi tertentu. Hidroterapi, misalnya, tidak dianjurkan pada kondisi perdarahan, infeksi intrauterin, ketuban pecah lama dengan risiko infeksi, atau gawat janin karena dapat menghambat pemantauan klinis (Smith et al., 2018). Aromaterapi perlu dihindari pada ibu dengan riwayat alergi atau asma, sedangkan pijat dan akupresur tidak dianjurkan pada area dengan infeksi atau gangguan perdarahan (Marshall & Raynor, 2020).

2) Metode Farmakologis

Metode farmakologis memiliki kontraindikasi yang lebih spesifik. Opioid, seperti petidin, dapat menyebabkan depresi pernapasan pada ibu dan bayi jika diberikan mendekati waktu kelahiran (ACOG, 2019). Nitrous oxide tidak dianjurkan pada ibu dengan gangguan kesadaran atau defisiensi vitamin B12 (RCOG, 2021). Analgesia epidural dan spinal merupakan metode yang efektif dalam mengurangi nyeri, namun kontraindikasi pada ibu dengan

gangguan koagulasi, infeksi di tempat penyuntikan, atau hipotensi berat (RCOG, 2021).

d. Langkah Pencegahan untuk Keselamatan Ibu–Janin

Untuk menjamin keselamatan ibu dan janin, diperlukan langkah-langkah pencegahan yang sistematis dan berbasis bukti.

1) Penilaian Antenatal dan Intrapartum

Penilaian komprehensif meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemantauan kesejahteraan janin melalui auskultasi denyut jantung janin atau kardiotokografi. Penggunaan partograf sangat dianjurkan untuk memantau kemajuan persalinan dan mendeteksi penyimpangan secara dini (WHO, 2018).

2) Informed Consent

Ibu harus memperoleh informasi yang jelas mengenai manfaat, risiko, dan alternatif metode manajemen nyeri sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan (ACOG, 2019).

3) Pemilihan Metode yang Tepat

Metode non-farmakologis diprioritaskan pada persalinan normal, sedangkan metode farmakologis digunakan secara selektif sesuai indikasi medis dan kewenangan tenaga kesehatan (ICM, 2019).

4) Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan tanda vital ibu dan kondisi janin sangat penting untuk mendeteksi efek samping dari intervensi yang diberikan serta memastikan kesejahteraan ibu dan bayi (Varney et al., 2020).

5) Pencegahan Infeksi

Penerapan teknik aseptik, pembatasan pemeriksaan vaginal yang tidak perlu, serta menjaga kebersihan lingkungan persalinan merupakan langkah penting dalam mencegah infeksi (WHO, 2018).

6) Sistem Rujukan yang Efektif

Bidan harus segera melakukan rujukan apabila ditemukan komplikasi yang berada di luar kewenangannya, seperti kebutuhan analgesia regional atau adanya tanda gawat janin (ICM, 2019).

C. Contoh Kasus Penerapan Dokumentasi Asuhan Kebidanan (Nyeri Persalinan)

Kasus

Seorang ibu, Ny. A, usia 25 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 39 minggu datang ke ruang bersalin dengan keluhan nyeri perut hilang timbul sejak 6 jam yang lalu. Nyeri dirasakan semakin kuat dan teratur. Ibu tampak meringis saat kontraksi dan mengatakan skala nyeri 7 dari 10.

Hasil pemeriksaan:

TD: 120/80 mmHg
Nadi: 88 x/menit
RR: 22 x/menit
Suhu: 36,7°C
DJJ: 140 x/menit
Kontraksi: 3x/10 menit, durasi 40 detik
Pembukaan serviks: 4 cm

Dokumentasi dengan Metode SOAP

S (Subjective / Data Subjektif)
Ibu mengeluh nyeri perut hilang timbul sejak 6 jam yang lalu
Nyeri semakin kuat dan sering
Skala nyeri 7/10
Ibu merasa cemas dan takut menghadapi persalinan

O (Objective / Data Objektif)
Keadaan umum: baik
Tanda vital dalam batas normal
DJJ: 140 x/menit (normal)
Kontraksi: 3x/10 menit, durasi 40 detik
Pembukaan serviks: 4 cm (fase aktif)
Ibu tampak meringis saat kontraksi

(Assessment / Analisa)
G1P0A0 usia kehamilan 39 minggu
Inpartu kala I fase aktif
Nyeri persalinan sedang (skala 7/10)
Disertai kecemasan

(Planning / Perencanaan)
Menjelaskan kepada ibu tentang proses persalinan
Mengajarkan teknik pernapasan saat kontraksi
Memberikan dukungan emosional
Menganjurkan posisi nyaman (miring kiri / duduk)
Melibatkan keluarga sebagai pendamping
Monitoring:
DJJ setiap 30 menit
Tanda vital
Kemajuan persalinan

Contoh Soal Studi Kasus

Seorang ibu, Ny. A, usia 23 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 39 minggu datang ke ruang bersalin dengan keluhan nyeri perut sejak 5 jam yang lalu. Nyeri dirasakan semakin kuat dan teratur. Ibu tampak cemas, meringis saat kontraksi, dan mengatakan skala nyeri 7/10. Hasil pemeriksaan: TD 120/80 mmHg, DJJ 140 x/menit, kontraksi 3x/10 menit, pembukaan 4 cm.

Pertanyaan:

Tindakan awal yang paling tepat dilakukan oleh bidan adalah…

A. Memberikan analgesik segera
B. Mengajarkan teknik pernapasan dan relaksasi
C. Melakukan rujukan
D. Menunda tindakan hingga pembukaan lengkap
E. Melakukan palpasi abdomen

Jawaban: B

Pembahasan: Pada kondisi normal, intervensi awal adalah metode non-farmakologi seperti teknik napas dan relaksasi.

Latihan Soal Diskusi Kelompok

Seorang ibu hamil, Ny. S, usia 32 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke Puskesmas pada pukul 10.00 WIB dengan keluhan mulas yang semakin sering sejak 6 jam yang lalu. Ibu tampak cemas dan mengeluh nyeri hebat pada setiap kontraksi.

Hasil anamnesis menunjukkan bahwa ibu memiliki riwayat preeklamsia pada kehamilan saat ini dan sedang mendapatkan terapi antihipertensi. Ibu juga menyampaikan keinginannya untuk menggunakan hidroterapi agar dapat mengurangi nyeri persalinan karena sebelumnya ia membaca bahwa metode tersebut dapat memberikan relaksasi.

Hasil Pemeriksaan : Tekanan darah: 160/100 mmHg, Nadi: 92 kali/menit, Respirasi: 22 kali/menit, Suhu: 36,8°C, Kontraksi uterus: 3 kali dalam 10 menit, durasi 40 detik, Denyut Jantung Janin (DJJ): 150 kali/menit, regular, Pembukaan serviks: 4 cm, Ketuban: Utuh, Protein urin: +2, Presentasi janin: Kepala, Perkiraan berat janin: 3200 gram.

Fasilitas kesehatan tempat ibu dirawat memiliki kemampuan pelayanan persalinan normal, namun tidak tersedia layanan analgesia epidural. Dokter spesialis obstetri berada di rumah sakit rujukan yang berjarak sekitar 30 menit dari Puskesmas.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa saja faktor risiko yang terdapat pada kasus Ny. S?
2. Apakah terdapat risiko terhadap janin? Jelaskan!
3. Apakah hidroterapi merupakan pilihan yang tepat pada kondisi ibu? Berikan alasan ilmiah!
4. Metode manajemen nyeri apa yang sebaiknya dihindari pada kasus ini?
5. Metode non-farmakologis apa yang paling aman untuk digunakan?
6. Apakah ibu memerlukan rujukan? Jelaskan dasar pertimbangannya?
7. Bagaimana peran bidan dalam batas kewenangannya pada kasus ini?
8. Tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan ibu dan janin?
9. Bagaimana pemantauan yang harus dilakukan selama persalinan?

Latihan Soal

1. Nyeri persalinan pada kala I terutama berasal dari…3
   A. Tekanan pada kandung kemih
   B. Peregangan perineum
   C. Dilatasi serviks dan kontraksi uterus
   D. Penurunan kepala janin
   E. Tekanan pada rectum

2. Karakteristik nyeri pada kala II persalinan adalah…
   A. Nyeri visceral
   B. Nyeri ringan
   C. Nyeri kronis
   D. Nyeri somatik
   E. Nyeri neuropatik

3. Prinsip asuhan yang memperhatikan seluruh aspek ibu disebut…
   A. Individualisasi
   B. Holistik
   C. Legalitas
   D. Efisiensi
   E. Supervisi

4. Tujuan utama penatalaksanaan nyeri persalinan adalah…
   A. Menghilangkan nyeri sepenuhnya
   B. Mengurangi nyeri dan meningkatkan kenyamanan
   C. Mempercepat proses persalinan
   D. Menghentikan kontraksi
   E. Menghindari pembukaan serviks

5. Melibatkan ibu dalam memilih metode pengurangan nyeri merupakan prinsip…
   A. Legalitas
   B. Empowerment
   C. Supervisi
   D. Efisiensi
   E. Akuntabilitas

Studi Kasus

6. Perempuan usia 24 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 39 minggu datang ke ruang bersalin dengan keluhan nyeri perut yang semakin kuat sejak 4 jam yang lalu. Ibu tampak cemas dan mengatakan nyeri skala 7/10. Hasil pemeriksaan: TD 120/80 mmHg, DJJ 140 x/menit, kontraksi 3x/10 menit, pembukaan 4 cm.
   Intervensi awal yang paling tepat dilakukan oleh bidan adalah…
   A. Memberikan analgesik kuat
   B. Melakukan rujukan segera
   C. Mengajarkan teknik relaksasi dan pernapasan
   D. Menunggu pembukaan lengkap
   E. Memberikan sedative

7. Perempuan usia 30 tahun, multipara, pembukaan 6 cm, mengeluh nyeri hebat, tampak gelisah dan kelelahan. Tanda vital normal, DJJ 138 x/menit.
   Pendekatan asuhan kebidanan yang paling tepat pada kasus tersebut adalah…
   A. Memberikan analgesik tanpa edukasi
   B. Mengabaikan keluhan ibu
   C. Menggunakan pendekatan holistik
   D. Menunda tindakan
   E. Melakukan tindakan invasive

8. Seorang ibu bersalin mengalami nyeri hebat disertai tekanan darah meningkat. Bidan melakukan pemantauan ketat.
   Tindakan tersebut merupakan penerapan…
   A. Kenyamanan
   B. Keselamatan
   C. Efisiensi
   D. Legalitas
   E. Administrasi

9. Seorang ibu primigravida tampak takut menghadapi persalinan. Bidan memberikan dukungan emosional dan edukasi.
   Tujuan tindakan tersebut adalah…
   A. Menghentikan kontraksi
   B. Mengurangi nyeri dan kecemasan
   C. Mempercepat persalinan
   D. Mengurangi pembukaan
   E. Menghindari komplikasi saja

10. Seorang ibu bersalin diberikan penjelasan manfaat dan risiko tindakan sebelum dilakukan intervensi.
    Tindakan tersebut merupakan bagian dari…
    A. Diagnosis
    B. Informed consent
    C. Evaluasi
    D. Prognosis
    E. Dokumentasi

Kunci Jawaban

1. C
2. D
3. B
4. B
5. B
6. C
7. C
8. B
9. B
10. B

D. Rangkuman Materi

Nyeri persalinan merupakan proses fisiologis yang terjadi akibat kontraksi uterus, dilatasi serviks, dan penurunan kepala janin. Nyeri ini bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh faktor fisik, psikologis, sosial, dan budaya, sehingga penanganannya harus dilakukan secara komprehensif.

Dalam asuhan kebidanan, terdapat beberapa prinsip utama yang harus diterapkan, yaitu pendekatan individualisasi (sesuai kebutuhan ibu), holistik (meliputi aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual), non-maleficence (tidak membahayakan), beneficence (memberikan manfaat), evidence-based practice (berdasarkan bukti ilmiah), empowerment (melibatkan ibu dalam pengambilan keputusan), serta continuity of care (asuhan berkesinambungan).

Tujuan asuhan kebidanan dalam nyeri persalinan adalah untuk mengurangi intensitas nyeri, meningkatkan kenyamanan dan relaksasi ibu, mencegah komplikasi, mendukung proses persalinan fisiologis, serta memberikan pengalaman persalinan yang positif.

Aspek keselamatan menjadi prioritas utama, meliputi keselamatan ibu melalui pemantauan tanda vital dan kondisi umum, keselamatan janin melalui pemantauan denyut jantung janin, serta keselamatan tindakan dengan penerapan prosedur yang sesuai standar dan prinsip aseptik. Selain itu, komunikasi efektif dan informed consent juga merupakan bagian penting dalam menjamin keselamatan pelayanan.

Penatalaksanaan nyeri persalinan dapat dilakukan dengan metode non-farmakologi seperti teknik relaksasi, pernapasan, massage, dan dukungan emosional, serta metode farmakologi seperti analgesik dan anestesi yang diberikan sesuai indikasi medis.

Identifikasi risiko dan kontraindikasi dalam manajemen nyeri serta kenyamanan persalinan merupakan langkah esensial untuk menjamin keselamatan ibu dan janin. Penilaian komprehensif terhadap kondisi maternal dan fetal memungkinkan tenaga kesehatan memilih metode pengurangan nyeri yang paling aman dan efektif. Dengan menerapkan prinsip asuhan berbasis bukti, pemantauan berkelanjutan, serta sistem rujukan yang efektif, diharapkan dapat tercapai pengalaman persalinan yang positif tanpa mengabaikan aspek keselamatan.

Dokumentasi asuhan kebidanan yang sistematis, seperti metode SOAP, sangat penting untuk menjamin kesinambungan pelayanan, sebagai alat komunikasi antar tenaga kesehatan, serta sebagai bukti hukum dalam praktik kebidanan.

Secara keseluruhan, asuhan kebidanan pada nyeri persalinan harus dilakukan secara profesional, aman, dan berorientasi pada kebutuhan ibu, sehingga dapat mendukung proses persalinan yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan ibu serta bayi.

Glosarium

Akupresur: Teknik non-farmakologis yang menggunakan tekanan pada titik-titik tertentu di tubuh untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan relaksasi selama persalinan (Smith et al., 2018).
Analgesia: Pengurangan atau penghilangan rasa nyeri tanpa menyebabkan hilangnya kesadaran.
Analgesia Epidural: Metode farmakologis untuk mengurangi nyeri dengan menyuntikkan obat anestesi ke dalam ruang epidural di tulang belakang, biasanya dilakukan oleh dokter anestesi.
Aromaterapi: Penggunaan minyak esensial dari tanaman untuk meningkatkan relaksasi dan mengurangi kecemasan serta nyeri selama persalinan (Smith et al., 2018).
Asuhan Berpusat pada Perempuan (*Woman-Centered Care*): Pendekatan pelayanan kebidanan yang menghormati kebutuhan, nilai, budaya, dan preferensi perempuan dalam proses persalinan.
Aseptik: Teknik yang dilakukan untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh guna menghindari infeksi.

Batas Kewenangan Bidan: Ruang lingkup praktik bidan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan standar profesi, termasuk dalam pemberian manajemen nyeri persalinan.
Beneficence: Prinsip etika yang menekankan tindakan untuk memberikan manfaat terbaik bagi pasien.

Continuity of Care: Pelayanan kebidanan yang dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan, persalinan, hingga nifas.

Dilatasi Serviks: Proses pembukaan leher rahim sebagai bagian dari persalinan.
Dokumentasi SOAP: Metode pencatatan asuhan kebidanan yang terdiri dari Subjective, Objective, Assessment, dan Planning.
Denyut Jantung Janin (DJJ): Frekuensi detak jantung janin yang digunakan untuk menilai kondisi kesejahteraan janin.

Empowerment: Upaya pemberdayaan ibu dengan melibatkan dalam pengambilan keputusan terkait asuhan.
Epidural: Metode anestesi regional untuk mengurangi nyeri persalinan dengan menyuntikkan obat pada ruang epidural.

Evidence-Based Practice: Praktik pelayanan kesehatan yang didasarkan pada bukti ilmiah terkini.

Holistik: Pendekatan menyeluruh yang mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.

Informed Consent: Persetujuan tindakan medis yang diberikan oleh pasien setelah mendapatkan penjelasan lengkap.
Infeksi Intrauterin (Korioamnionitis): Infeksi pada selaput ketuban dan cairan amnion yang dapat meningkatkan risiko komplikasi pada ibu dan janin.
International Confederation of Midwives **(ICM):** Organisasi internasional yang menetapkan standar kompetensi dan praktik kebidanan di seluruh dunia.

Kala I Persalinan: Tahap persalinan dari awal kontraksi hingga pembukaan lengkap (10 cm).
Kala II Persalinan: Tahap persalinan dari pembukaan lengkap hingga lahirnya bayi.
Kenyamanan Persalinan: Kondisi kesejahteraan fisik dan psikologis ibu selama proses persalinan yang dicapai melalui pengelolaan nyeri yang efektif dan dukungan emosional (WHO, 2018).
Kontraindikasi: Kondisi atau faktor yang menyebabkan suatu tindakan atau terapi tidak boleh dilakukan karena berpotensi menimbulkan bahaya (RCOG, 2021).
Kontraksi Uterus: Pengerutan otot rahim yang berfungsi untuk membuka serviks dan mendorong janin keluar.

Manajemen Nyeri Persalinan: Serangkaian intervensi, baik non-farmakologis maupun farmakologis, yang bertujuan mengurangi nyeri dan meningkatkan kenyamanan ibu selama persalinan.
Massage (Pijat): Teknik sentuhan untuk membantu mengurangi nyeri dan meningkatkan relaksasi.

Non-Farmakologi: Metode pengelolaan nyeri tanpa menggunakan obat-obatan.
Non-maleficence: Prinsip etika yang menekankan untuk tidak menimbulkan bahaya bagi pasien.
Nyeri Persalinan: Sensasi tidak nyaman yang terjadi selama proses persalinan akibat kontraksi dan perubahan pada jalan lahir.

Partograf: Alat bantu untuk memantau kemajuan persalinan dan kondisi ibu serta janin.

Relaksasi: Teknik untuk mengurangi ketegangan fisik dan mental.
Somatik: Jenis nyeri yang berasal dari jaringan tubuh seperti otot dan kulit, biasanya terasa tajam dan terlokalisasi.

Visceral: Jenis nyeri yang berasal dari organ dalam, biasanya terasa tumpul dan sulit dilokalisasi.

Tanda Vital: Parameter dasar kondisi tubuh meliputi tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu.

Referensi

Abdolalipour, S., Abbasalizadeh, S., Mohammad-Alizadeh-Charandabi, S., et al. (2024). Effect of implementation of the WHO intrapartum care model on maternal and neonatal outcomes: A randomized controlled trial. BMC Pregnancy and Childbirth, 24, 283. https://doi.org/10.1186/s12884-024-06449-4

American College of Obstetricians and Gynecologists. (2024). First and second stage labor management (Clinical Practice Guideline No. 8). ACOG.

Blackburn, R., Mehmeti, A., Russell, S., Rivers, F., & Blott, M. (2024). Intrapartum care: Updated summary of NICE guidance. BMJ, 384, p2885. https://doi.org/10.1136/bmj.p2885

Bohren, M. A., Berger, B. O., Munthe-Kaas, H., & Tunçalp, Ö. (2019). Perceptions and experiences of labour pain relief: A qualitative systematic review. Cochrane Database of Systematic Reviews, (3), CD009251. https://doi.org/10.1002/14651858.CD009251.pub2

Downe, S., Finlayson, K., Oladapo, O. T., Bonet, M., & Gülmezoglu, A. M. (2018). What matters to women during childbirth: A systematic qualitative review. PLoS ONE, 13(4), e0194906. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194906

International Confederation of Midwives. (2019). Essential competencies for midwifery practice. The Hague: ICM.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Pedoman pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Kemenkes RI.

Lally, J. E., Murtagh, M. J., Macphail, S., & Thomson, R. G. (2021). More in hope than expectation: A systematic review of women's expectations and experience of pain relief in labour. BMC Medicine, 19, 16. https://doi.org/10.1186/s12916-021-01928-7

Marshall, J. E., & Raynor, M. D. (2020). Myles Textbook for Midwives (17th ed.). Elsevier.

Meler, K. M., & Çankaya, S. (2025). The effect of intrapartum care model based on WHO recommendations on labor pain and comfort: A randomized controlled trial. Postgraduate Medicine, 137(5), 379–395. https://doi.org/10.1080/00325481.2025.2501943

National Institute for Health and Care Excellence. (2025). Intrapartum care (NICE Guideline NG235). NICE.

National Institute for Health and Care Excellence. (2023). Intrapartum care: Evidence update and recommendations. NICE.

Oladapo, O. T., Souza, J. P., Fawole, B., et al. (2018). Progression of the first stage of spontaneous labour: A prospective cohort study. The Lancet, 391(10123), 693–704. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30184-2

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. (2021). Intrapartum care guidelines. London: RCOG.

Sharma, S., & McIntire, D. D. (2022). Nonpharmacologic management of labor pain: A review of current evidence. Obstetrics & Gynecology Clinics of North America, 49(2), 245–259. https://doi.org/10.1016/j.ogc.2022.02.003

Smith, C. A., Levett, K. M., Collins, C. T., & Jones, L. (2018). Relaxation techniques for pain management in labour. Cochrane Database of Systematic Reviews, (3), CD009514.

Varney, H., Kriebs, J. M., & Gegor, C. L. (2020). Varney's Midwifery (6th ed.). Jones & Bartlett Learning.

World Health Organization. (2023). WHO Labour Care Guide: User's manual. WHO.

World Health Organization. (2022). Recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience. WHO.

World Health Organization. (2018). WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience. WHO.

BAB 2

FISIOLOGI NYERI PERSALINAN: SUMBER NYERI, JALUR NYERI, DAN RESPONS FISIOLOGIS IBU–JANIN

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan sensitivitas budaya dalam pengelolaan nyeri dan kenyamanan persalinan.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik, informed choice, dan kolaborasi dengan ibu, keluarga, dan tim kesehatan.	CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan keselamatan pasien, PPI, K3, dan manajemen risiko dalam intervensi manajemen nyeri persalinan.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-4	Melakukan pengkajian komprehensif dan clinical reasoning berbasis data untuk menentukan rencana manajemen nyeri dan kenyamanan ibu–janin.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-7
CPL-5	Melaksanakan intervensi nonfarmakologi dan mendukung manajemen farmakologi dasar sesuai kewenangan secara aman dan bermutu.	CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Melakukan edukasi, dokumentasi terstandar, dan pemanfaatan bukti ilmiah dasar untuk evaluasi hasil dan peningkatan mutu asuhan.	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Mengevaluasi prinsip, tujuan, dan aspek keselamatan manajemen nyeri persalinan yang berpusat pada ibu–janin.
CPMK-2	Menganalisis fisiologi nyeri persalinan (sumber, jalur, respons ibu–janin) sebagai dasar pemilihan intervensi dan pemantauan.
CPMK-3	Menganalisis faktor psikologis, sosial, budaya, dan pengalaman melahirkan serta implikasinya terhadap persepsi nyeri dan kenyamanan.
CPMK-4	Melaksanakan pengkajian nyeri/kenyamanan, interpretasi tanda klinis, serta pendokumentasian terstandar untuk pemantauan berkelanjutan.
CPMK-5	Merancang dan menerapkan strategi nonfarmakologi serta dukungan emosional dengan komunikasi terapeutik dan prinsip keamanan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-6	Mengintegrasikan farmakologi dasar analgesia persalinan dengan kolaborasi, pemantauan, dan kewaspadaan efek samping sesuai kewenangan.
CPMK-7	Menyusun rencana manajemen nyeri pada kondisi khusus, mengevaluasi hasil (kepuasan/outcome), dan merancang edukasi tindak lanjut berbasis bukti.

D. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 2. Fisiologi Nyeri Persalinan: Sumber Nyeri, Jalur Nyeri, dan Respons Fisiologis Ibu–Janin	2.1 Membedakan sumber dan pola nyeri sesuai kala persalinan dan proses fisiologis	2.2 Menafsir respons fisiologis ibu–janin terhadap nyeri untuk menentukan kebutuhan pemantauan	CPMK-2	CPMK-4; CPMK-6

E. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	Ujian analisis (diagram/SAQ)	Memetakan sumber & jalur nyeri sesuai kala; menafsir respons ibu–janin dan kebutuhan pemantauan	10	Lembar analisis/diagram fisiologi
CPMK-4	OSCE pengkajian + audit dokumentasi	Mengukur nyeri/kenyamanan dengan skala yang tepat dan konsisten; mencatat temuan–tindakan–respons lengkap dan kronologis	15	Checklist OSCE + lembar dokumentasi
CPMK-6	Simulasi kolaborasi analgesia (OSCE + checklist)	Menentukan opsi analgesia sesuai indikasi/risiko; melakukan pemantauan ibu–janin dan tindak lanjut efek samping secara kolaboratif	15	Checklist OSCE + lembar pemantauan

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Identifikasi tujuan dan prinsip keselamatan pada skenario	Tujuan tidak jelas/keliru; aspek keselamatan terabaikan	Tujuan cukup jelas; keselamatan disebut umum namun belum memprioritaskan risiko utama	Tujuan tepat; keselamatan diprioritaskan, ada kekurangan minor	Tujuan sangat tepat; keselamatan komprehensif, proaktif, berbasis risiko ibu–janin
1.2 Penetapan intervensi awal sesuai kondisi & kewenangan	Pilihan tidak sesuai kondisi/kewenangan; berpotensi tidak aman	Pilihan sebagian sesuai; mitigasi risiko/kontraindikasi belum lengkap	Pilihan sesuai; mitigasi risiko jelas, masih ada detail minor yang kurang	Pilihan paling sesuai; mitigasi risiko lengkap dan disertai alasan yang kuat

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Pemetaan sumber & jalur nyeri sesuai kala	Banyak konsep salah; tidak dapat mengaitkan dengan kala	Sebagian benar; masih ada kekeliruan pada pemetaan/urutan	Hampir seluruhnya benar; ada kekeliruan minor	Akurat dan lengkap; mampu mengaitkan pola nyeri dengan proses persalinan
2.2 Interpretasi respons ibu–janin dan implikasi pemantauan	Salah menafsir respons; rekomendasi pemantauan tidak tepat	Menafsir sebagian; rekomendasi pemantauan masih umum	Menafsir tepat; rekomendasi pemantauan relevan dan aman	Menafsir sangat tepat; rekomendasi pemantauan spesifik, antisipatif, dan rasional

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Identifikasi faktor psikologis–sosial–budaya	Faktor kunci tidak teridentifikasi; asumsi tidak berdasar	Faktor teridentifikasi sebagian; masih ada bias/kurang lengkap	Faktor teridentifikasi baik dan relevan; bias minimal	Faktor lengkap, relevan, dan berimbang; menunjukkan sensitivitas budaya yang kuat
3.2 Rekomendasi pendekatan	Pendekatan tidak sesuai; berpotensi	Pendekatan cukup sesuai namun generik; kurang	Pendekatan sesuai; menyesuaikan	Pendekatan sangat sesuai; empatik, trauma-informed,

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
komunikasi & dukungan	meningkatkan distres	menyesuaikan konteks ibu	konteks dan mendukung coping	dan memfasilitasi kontrol diri ibu

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Pengukuran nyeri/kenyamanan (pemilihan skala & konsistensi)	Skala/teknik tidak tepat; pengukuran tidak konsisten	Skala cukup tepat; konsistensi dan waktu pengukuran belum optimal	Skala tepat; pengukuran konsisten sesuai kebutuhan pemantauan	Skala sangat tepat; pengukuran konsisten, responsif terhadap perubahan kondisi
4.2 Dokumentasi temuan–tindakan–respons	Catatan tidak lengkap/tidak runtut; sulit ditindaklanjuti	Catatan cukup lengkap; masih ada bagian penting yang hilang	Catatan lengkap dan runtut; mudah ditelusuri	Catatan sangat lengkap, jelas, standar; mendukung pengambilan keputusan dan continuity of care

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Coaching dukungan emosional/pernapasan/relaksasi	Komunikasi tidak terapeutik; instruksi tidak dipahami; tidak aman	Komunikasi cukup; instruksi dipahami sebagian; perlu banyak arahan	Komunikasi terapeutik; instruksi jelas; aman dengan koreksi minor	Komunikasi sangat efektif; memberdayakan ibu & pendamping; aman dan adaptif
5.2 Implementasi teknik fisik/lingkungan & evaluasi respons	Teknik tidak sesuai/berisiko; tidak mengevaluasi respons	Teknik cukup sesuai; evaluasi respons minim/umum	Teknik sesuai dan aman; evaluasi respons jelas dan berkelanjutan	Teknik sangat tepat; evaluasi respons terukur, adaptasi cepat, dan berorientasi kenyamanan

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Kesesuaian pemilihan analgesia dasar & identifikasi risiko	Pilihan tidak sesuai indikasi; risiko/kontraindikasi terlewat	Pilihan cukup sesuai; risiko/kontraindikasi disebut sebagian	Pilihan sesuai; risiko/kontraindikasi utama teridentifikasi	Pilihan paling sesuai; risiko/kontraindikasi lengkap dan disertai pertimbangan rasional
6.2 Pemantauan, tindak lanjut efek samping, dan komunikasi kolaboratif	Tidak memantau parameter kunci; tindak lanjut tidak tepat	Memantau sebagian; tindak lanjut dan komunikasi masih kurang terstruktur	Pemantauan tepat; tindak lanjut aman; komunikasi kolaboratif jelas	Pemantauan komprehensif; tindak lanjut antisipatif; komunikasi kolaboratif sangat efektif dan terdokumentasi

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Perencanaan manajemen nyeri pada kondisi khusus (prioritas, integrasi, eskalasi)	Rencana tidak sesuai risiko; prioritas/eskalasi tidak jelas	Rencana cukup sesuai; integrasi modalitas dan eskalasi belum mantap	Rencana sesuai; prioritas jelas; integrasi dan eskalasi aman	Rencana sangat kuat; prioritas tajam; integrasi komprehensif; eskalasi/rujukan tepat waktu dan berbasis risiko
7.2 Evaluasi hasil & rencana edukasi tindak lanjut	Tidak menetapkan indikator; edukasi tidak relevan/tidak dapat diterapkan	Indikator ada namun terbatas; edukasi umum	Indikator relevan; edukasi jelas dan dapat diterapkan	Indikator lengkap dan terukur; edukasi sangat personal, realistis, mendukung coping dan rencana lanjutan

A. Pendahuluan

Persalinan atau kelahiran merupakan proses alamiah dan fisiologis dimana terjadi dilatasi servik, serta lahirnya bayi dan plasenta dari rahim ibu. Persalinan normal terjadi pada kehamilan cukup bulan 37-42 minggu, lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam tanpa komplikasi ibu dan janin(Cunningham FG,Leveno KJ, Bloom SL,Haunth JC, Gilstrap LC, 2018).. Salah satu komponen utama dalam proses tersebut adalah nyeri persalinan. Nyeri ini bukan sekadar pengalaman subjektif, tetapi merupakan hasil dari mekanisme

neurofisiologis yang terorganisasi dan memiliki implikasi langsung terhadap kondisi ibu maupun janin. Persalinan dapat berjalan normal didukung oleh 4 faktor penting ("4 P") yaitu *Powers* (kekuatan kontraksi), *Passage* (bagian panggul dan jalan lahir), *Passenger* (janin) dan *Psyche* (respon wanita)(Durham, 2019)

Secara fisiologis, nyeri persalinan muncul akibat kontraksi uterus, dilatasi dan penipisan serviks, serta peregangan jaringan jalan lahir. Rangsangan tersebut diterima oleh reseptor nyeri (nociceptor), ditransmisikan melalui serabut saraf perifer menuju medula spinalis, dan selanjutnya dipersepsikan di korteks serebri. Proses ini tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor hormonal, emosional, lingkungan, serta pengalaman sebelumnya. Nyeri persalinan menempati skor 30-40 dari 50 skor. Skor tersebut lebih tinggi dibandingkan sindrom nyeri punggung kronik, nyeri akibat kanker, nyeri tungkai dan lainnya(santi, 2015). Oleh karena itu, pemahaman mengenai sumber nyeri dan jalur transmisi nyeri menjadi dasar penting dalam praktik kebidanan.

Selain berdampak pada ibu, nyeri persalinan juga memicu respons fisiologis sistemik berupa aktivasi sistem saraf simpatis dan peningkatan hormon stres seperti katekolamin dan kortisol. Respons ini dapat memengaruhi perfusi uteroplasenta, pola kontraksi uterus, serta kesejahteraan janin. 27% persalinan di Indonesia mengalami komplikasi dan 53% kelahiran dengan riwayat gelisah atau kesakitan yang hebat serta persalinan yang lama (BKKBN, 2019). Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara nyeri dan respons ibu–janin sangat diperlukan untuk mendukung asuhan persalinan yang aman dan berbasis bukti.

Dalam praktik kebidanan modern, bidan tidak hanya dituntut untuk memahami proses persalinan secara klinis, tetapi juga harus mampu menjelaskan mekanisme fisiologis yang mendasari setiap respons tubuh ibu. Pendekatan ilmiah terhadap fisiologi nyeri persalinan memungkinkan tenaga kesehatan memberikan manajemen nyeri yang rasional, efektif, serta tetap menghormati proses fisiologis alami.

Buku ini disusun untuk memberikan landasan teoretis yang kuat mengenai fisiologi nyeri persalinan, meliputi sumber nyeri pada setiap kala persalinan, jalur transmisi nyeri, serta respons fisiologis ibu dan janin. Dengan memahami mekanisme tersebut secara sistematis, diharapkan pembaca mampu mengintegrasikan ilmu dasar dengan praktik klinis kebidanan secara lebih kritis, reflektif, dan profesional.

Pemahaman yang mendalam terhadap fisiologi nyeri persalinan bukan hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan kebidanan dan keselamatan ibu serta bayi.

Tujuan Intruksional dan Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari buku ajar ini, mahasiswa mampu memahami secara komprehensif fisiologi nyeri persalinan meliputi sumber nyeri, jalur transmisi nyeri, serta respons fisiologis ibu dan janin, dan mampu mengintegrasikannya dalam praktik kebidanan berbasis bukti dan berorientasi pada keselamatan ibu–janin.

Tujuan Intruksional:

Buku ajar Fisiologi Nyeri Persalinan: Sumber Nyeri, Jalur Nyeri, dan Respons Fisiologis Ibu–Janin ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif mengenai mekanisme fisiologis nyeri persalinan, mulai dari sumber nyeri, jalur transmisi saraf, hingga respons fisiologis ibu dan janin. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis proses nyeri secara ilmiah, mengaitkannya dengan perubahan klinis selama persalinan, serta menjadikannya sebagai dasar rasional dalam memberikan asuhan kebidanan yang aman, humanis, dan berbasis bukti.

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu mejelaskan Sumber Nyeri, Jalur Nyeri, dan Respons Fisiologis Ibu–Janin
2. Mampu membedakan sumber dan pola nyeri sesuai kala persalinan dan proses fisiologis
3. Mampu Menafsir respons fisiologis ibu–janin terhadap nyeri untuk menentukan kebutuhan pemantauan
4. Mampu Mengukur nyeri/kenyamanan dengan skala yang tepat dan konsisten; mencatat temuan–tindakan–respons lengkap dan kronologis
5. Menentukan opsi analgesia sesuai indikasi/risiko; melakukan pemantauan ibu–janin dan tindak lanjut efek samping secara kolaboratif
6. Mampu menganalisis fisiologi nyeri persalinan (sumber, jalur, respons ibu–janin) sebagai dasar pemilihan intervensi dan pemantauan.

Uraian Materi

Uraian materi dalam buku ajar adalah deskripsi atau penjelasan tentang topik atau subjek tertentu yang disusun secara sistematis dan terstruktur. Materi tersebut dapat mencakup konsep, teori, prinsip, fakta, contoh, dan aplikasi dari subjek yang dibahas. Uraian materi dalam buku ajar biasanya disesuaikan dengan target audiens dan tujuan pembelajaran, serta disusun dengan cara yang mudah dipahami oleh pembaca. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, dan terorganisir sehingga pembaca dapat memahami dan menguasai materi yang diajarkan.

B. Sumber Nyeri Persalinan

1. Definisi Nyeri persalinan

   adalah sensasi nyeri yang dirasakan ibu selama proses persalinan yang merupakan bagian fisiologis dari mekanisme kelahiran bayi. Nyeri ini bersifat kompleks karena melibatkan aspek fisiologis, neurofisiologis, dan psikososial serta berbeda-beda pada setiap individu.

   The International Association for The Study of Pain (IASP) menyepakati definisi nyeri adalah "Pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan karena kerusakan jaringan aktual atau potensial, atau digambarkan dalam istilah kerusakan jaringan. Rasa nyeri lebih dari sensasi atau kesadaran fisik nyeri; juga termasuk persepsi, penafsiran subjektif dari ketidaknyamanan. Persepsi memberikan informasi tentang lokasi rasa sakit , intensitas, dan sesuatu tentang alam. Berbagai tanggapan sadar dan bawah sadar untuk kedua sensasi dan persepsi, termasuk respons emosional. Dari pernyataan diatas menunjukan bahwa nyeri mempunyai komponen subyektif, setiap orang membangun kontruksi internal dalam dirinya mengenai dalam bereaksi terhadap cidera atau kerusakan jaringan.Pada kehamilan dan persalinan rasa nyeri diartikan sebagai sebuah "sinyal" sebagai pemberitahuan kepada ibu bahwa dirinya telah memasuki tahapan proses persalinan. Nyeri sendiri merupakan bagian integral dari proses persalinan (Mander, 2004).

2. Sumber Nyeri Persalinan

   Nyeri persalinan tidak diketahui secara pasti, tetapi dapat diduga dari beberapa kemungkinan diantaranya 1:

   a. Hipoksia pada miometrium yang berkontraksi (seperti pada angina pektoris)
   b. Penekanan ganglia syaraf di serviks dan uterus bagian bawah oleh berkas berkas otot yang saling bertautan
   c. Peregangan serviks sewaktu dilatasi
   d. Peregangan peritonium yang terletak diatas fundus

C. Jalur Nyeri Persalinan

Nyeri persalinan merupakan pengalaman kompleks yang melibatkan proses fisiologis, neurofisiologis, dan psikososial. Menurut International Association for the Study of Pain (IASP), nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang terkait jaringan nyata atau potensial rusak. Nyeri persalinan sebagai akibat dari kontraksi dari myometrium yang fisiologis dengan intensitas yang berbeda-beda pada tiap individu(Andarmoyo, 2013). Dalam persalinan, nyeri muncul dari kontraksi uterus, dilatasi serviks, peregangan jalan lahir, dan tekanan

kepala janin pada jaringan maternal, yang semuanya memicu aktivasi nociceptor dan penghantaran impuls nyeri ke sistem saraf pusat (Indonesia et al., 1994)

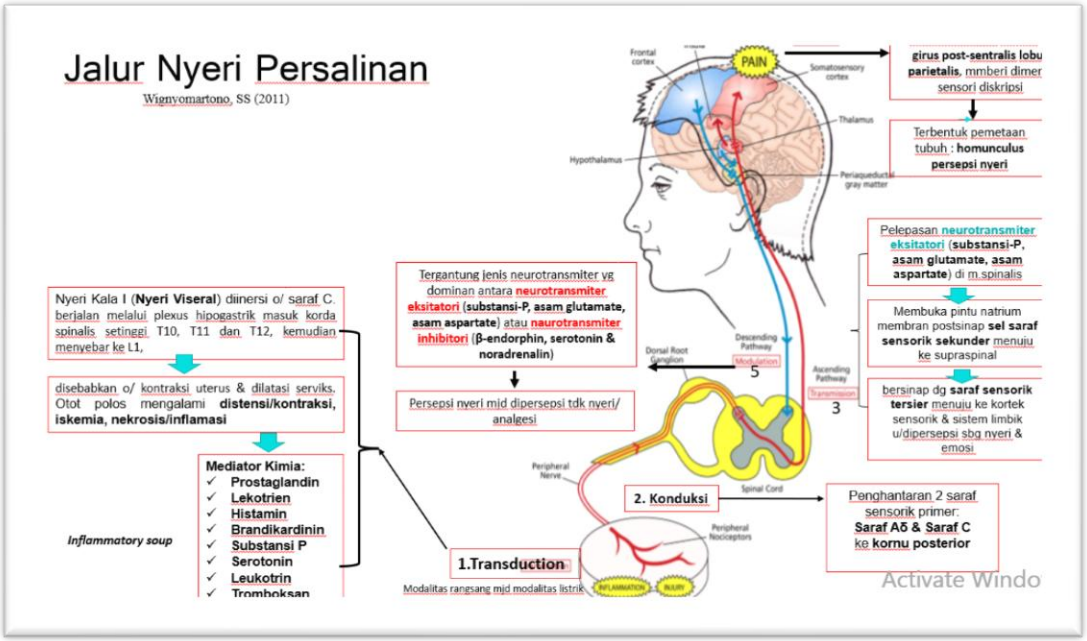
Nyeri persalinan merupakan fenomena fisiologis kompleks yang melibatkan interaksi antara proses mekanik, neurofisiologis, biokimia, dan psikologis. Nyeri ini timbul sebagai respons terhadap aktivitas kontraksi uterus, dilatasi serviks, serta peregangan jaringan jalan lahir yang terjadi selama proses persalinan. Jalur nyeri persalinan mencakup beberapa tahapan utama, yaitu transduksi, konduksi, transmisi, persepsi, dan modulasi nyeri, yang berlangsung secara berkesinambungan dari perifer hingga sistem saraf pusat. Secara anatomi, jalur nyeri persalinan dibedakan menurut fase persalinan. Pada kala I, nyeri bersumber dari kontraksi uterus dan dilatasi serviks. Kontraksi uterus menyebabkan iskemia miometrium dan pelepasan mediator inflamasi seperti prostaglandin, bradikinin, dan substansi P yang mengaktivasi nociceptor. Impuls nyeri dihantarkan oleh serabut aferen (terutama serabut C) melalui pleksus Frankenhäuser menuju medula spinalis segmen T10–L1 (2,3). Dari medula, impuls naik melalui traktus spinotalamikus ke talamus dan diproyeksikan ke korteks somatosensorik untuk persepsi sadar nyeri (Wright et al., 2017)(CRAIG, 1948)

Memasuki kala II, sumber nyeri bergeser ke peregangan vagina, dasar panggul, perineum, serta tekanan kepala janin. Nyeri pada fase ini lebih bersifat somatik dan tajam, disebabkan oleh stimulasi nociceptor di jaringan superfisial dan dalam yang dihantarkan melalui nervus pudendus ke medula spinalis segmen S2–S4. Jalur ini kemudian meneruskan impuls ke thalamus dan korteks serebri . Mekanisme neurofisiologis nyeri persalinan mengikuti tahapan transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Pada transduksi, rangsangan mekanik diubah menjadi impuls listrik oleh nociceptor. Transmisi adalah penghantaran impuls melalui serabut A-delta dan C ke dorsal horn medula spinalis. Modulasi nyeri terjadi di tingkat spinal dan desenden melalui sistem inhibitorik yang melibatkan neurotransmiter seperti endorfin dan enkefalin. Tahap terakhir, persepsi, terjadi di korteks serebri dan dipengaruhi oleh faktor psikologis dan pengalaman sebelumnya. Faktor psikologis memainkan peran kunci dalam persalinan dan perkembangan setiap gangguan nyeri maka diperlukan komunikasi yang efektif antara akademisi, dokter, peneliti, dan pasien(Kumar et al., 2016). Stimulus yang menimbulkan rasa nyeri akan mengakibatkan terjadinya insiden sensorik(Bobak, I.M, Lowdermilk D.I & Jensen, 2004).

Teori Gate Control yang dikemukakan oleh Ronald Melzack dan Patrick Wall menjelaskan bahwa sinyal nyeri dapat difasilitasi atau dihambat di dorsal horn medula spinalis. Stimulasi serabut non-nociceptif (misalnya A-beta melalui tekanan atau sentuhan) dapat menutup "gerbang" nyeri dan menurunkan persepsi nyeri.

Selain itu, konsep neuromatrix menyatakan bahwa persepsi nyeri dipengaruhi oleh pengalaman emosional, budaya, dan konteks psikososial ibu . Nyeri juga dapat didefinisikan sebagai suatu sensasi tunggal yang disebabkan oleh stimulus spesifik bersifat subyektif dan berbeda antara masing-masing individu karena dipengaruhi oleh faktor psikososial, kultur dan endorphine seseorang, sehingga orang tersebut lebih merasakan nyeri(Potter, P.A. Perry, 2005).

Pemahaman jalur nyeri persalinan memiliki implikasi klinis penting dalam menentukan strategi manajemen nyeri, baik non-farmakologis maupun farmakologis seperti analgesia sistemik dan regional (misalnya epidural), yang disesuaikan dengan tahapan dan jalur nyeri yang dominan .



Gambar 2. 1 diagram jalur fisiologi nyeri persalinan

a. Tahap Transduksi

Transduksi merupakan proses awal dalam jalur nyeri, yaitu perubahan rangsangan mekanik dan kimia menjadi impuls listrik pada ujung saraf sensorik. Aktivasi nociceptor di uterus dan serviks terjadi akibat kontraksi, distensi jaringan, serta paparan mediator inflamasi. Impuls listrik yang terbentuk selanjutnya dihantarkan melalui serabut saraf aferen menuju medula spinalis.

b. Tahap Konduksi

Impuls nyeri dari uterus dan serviks dihantarkan melalui serabut saraf aferen primer, terutama: serabut A-delta, yang menghantarkan nyeri tajam dan cepat, serta serabut C, yang menghantarkan nyeri tumpul, difus, dan

berlangsung lebih lama. Impuls berjalan melalui pleksus hipogastrikus menuju medula spinalis dan memasuki segmen torakal bawah hingga lumbal atas, terutama pada tingkat T10, T11, T12, dan L1, melalui kornu posterior medula spinalis.

c. Tahap Transmisi di Medula Spinalis

Pada tingkat medula spinalis terjadi proses transmisi sinaptik antara neuron aferen primer dan neuron sekunder. Pada tahap ini dilepaskan neurotransmiter eksitatorik, seperti substansi P, glutamat, dan aspartat. Neurotransmiter tersebut meningkatkan permeabilitas membran postsinaptik terhadap ion natrium sehingga memperkuat propagasi impuls nyeri. Impuls kemudian diteruskan melalui jalur ascending, terutama traktus spinotalamikus, menuju struktur otak yang lebih tinggi.

d. Persepsi Nyeri di Sistem Saraf Pusat

Persepsi nyeri terjadi ketika impuls mencapai pusat-pusat sensorik di otak. Thalamus berperan sebagai pusat relay yang meneruskan impuls menuju korteks serebri. Selanjutnya, korteks somatosensorik di lobus parietalis memproses informasi mengenai lokasi, intensitas, dan kualitas nyeri. Pada tahap ini terbentuk representasi tubuh atau homunculus sensorik, yang memungkinkan individu mengidentifikasi sumber nyeri secara spesifik. Selain itu, aktivasi sistem limbik memberikan komponen emosional terhadap pengalaman nyeri, seperti kecemasan, ketakutan, dan respons stres selama persalinan. Oleh karena itu, nyeri persalinan merupakan pengalaman multidimensional yang melibatkan aspek sensorik dan afektif.

e. Modulasi Nyeri (Descending Control System)

Sistem saraf pusat memiliki kemampuan untuk memodulasi atau mengontrol impuls nyeri melalui jalur desenden dari otak menuju medula spinalis. Mekanisme ini melibatkan pelepasan neurotransmiter inhibitor, seperti β-endorfin, serotonin, dan noradrenalin, yang berfungsi menghambat transmisi impuls nyeri pada tingkat spinal. Aktivasi sistem modulasi ini dapat menurunkan persepsi nyeri secara alami (endogenous analgesia). Mekanisme tersebut menjadi dasar ilmiah berbagai pendekatan nonfarmakologis dalam manajemen nyeri persalinan, seperti teknik relaksasi, pengaturan napas, dukungan emosional, hipnobirthing, dan stimulasi kenyamanan ibu.

f. Implikasi Klinis dalam Praktik Kebidanan

Pemahaman mengenai jalur nyeri persalinan menunjukkan bahwa nyeri tidak hanya dipengaruhi oleh stimulus fisiologis, tetapi juga oleh faktor neurokimia dan psikologis. Oleh karena itu, penatalaksanaan nyeri persalinan memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek biologis, psikologis,

dan sosial. Intervensi kebidanan yang efektif meliputi edukasi antenatal, dukungan berkelanjutan selama persalinan, teknik coping nyeri, serta penciptaan lingkungan persalinan yang aman dan nyaman. Pendekatan ini berperan dalam mengoptimalkan sistem modulasi nyeri alami sehingga pengalaman persalinan menjadi lebih positif bagi ibu.

D. Respon Fisiologis Ibu dan Janin

Nyeri persalinan memicu respons tubuh yang kompleks dan terkoordinasi, melibatkan sistem saraf, kardiovaskular, endokrin, dan hemodinamik pada ibu serta berdampak pada keseimbangan fisiologis janin. Proses ini bukan sekadar sensasi nyeri semata, tetapi bagian dari respons tubuh terhadap stres akut selama kontraksi uterus, perubahan perfusi darah, dan adaptasi terhadap persalinan. Nyeri persalinan yang berat dan lama ini merupakan salah satu bentuk mekanisme pertahanan diri untuk menjaga *homeostasis*, tetapi nyeri persalinan yang berat dan lama dapat memengaruhi ventilasi, sirkulasi, metabolisme dan sirkulasi uterus (Andarmoyo, 2013).

1. Respon Fisiologis pada Ibu

   Ketika nyeri persalinan dirasakan, sistem saraf simpatis maternal diaktifkan sebagai respons terhadap rangsangan stres. Aktivasi ini menyebabkan pelepasan katekolamin seperti epinefrin dan norepinefrin ke dalam sirkulasi darah, yang merupakan bagian dari respons "fight-or-flight". Peningkatan katekolamin tersebut kemudian meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan curah jantung ibu sebagai respon kompensatorik untuk menghadapi stres persalinan. Peningkatan tekanan darah yang bersifat intermiten ini sering kali terlihat selama kontraksi uterus yang intens (Rachmawati, 2025) .

   Aktivasi sistem saraf simpatis juga mempengaruhi sistem respirasi. Nyeri persalinan dapat merangsang hiperventilasi, di mana ibu mengambil napas lebih cepat untuk merespons stres sakit. Hiperventilasi ini dapat menyebabkan perubahan gas darah seperti penurunan karbon dioksida (CO_2) dan alkalosis respiratorik, yang bila tidak diatasi dapat mengganggu perfusi uteroplasenta. Selain itu, ketegangan otot yang terus-menerus akibat kontraksi kuat juga meningkatkan konsumsi oksigen ibu secara keseluruhan. Nyeri dan kecemasan yang menyertai persalinan dapat menyebabkan kelambatan pengosongan lambung(Mander, 2004)

   Selain itu, sistem endokrin ibu turut terlibat. Rangsangan nyeri yang berkepanjangan mengaktifkan poros hipotalamus–hipofisis–adrenal (HPA), yang selanjutnya meningkatkan produksi kortisol sebagai bagian dari respons stres.

Kortisol berkaitan erat dengan adaptasi terhadap stres fisiologis dan membantu tubuh memobilisasi energi. Stateful peningkatan hormon stres ini juga dapat menghambat kerja oksitosin jika kadar epinefrin terlalu tinggi, sehingga kontraksi uterus menjadi kurang efektif dan meningkatkan risiko persalinan yang lebih lama atau disfungsional.

Akumulasi stres fisiologis ini berdampak pada metabolisme ibu. Peningkatan konsumsi energi dan akumulasi metabolit seperti asam laktat terjadi akibat kontraksi uterus yang intens dan aktivitas fisik ibu yang meningkatkan metabolisme sel. Jika nyeri tidak tertangani dengan efektif, respon metabolik ini bisa mempercepat kelelahan maternal dan mempengaruhi progres persalinan. Peningkatan konsumsi oksigen, kehilangan natrium bikarbonat melalui ginjal untuk mengompensasi alkalosis respiratorik yang disebabkan nyeri persalinan dan penurunan asupan karbohidrat (akibat kebijakan restriksi diet selama persalinan) semuanya berperan dalam status asidosis metabolik yang kemudian juga akan dialami oleh janin(Andarmoyo, 2013).

2. Respon Fisiologis pada Janin

Janin tidak merasakan nyeri persalinan secara sadar seperti ibu, tetapi fisiologinya sangat dipengaruhi oleh perubahan hemodinamik dan oksigenasi maternal. Selama kontraksi uterus, perfusi uteroplasenta berkurang sementara karena kompresi arteri uterina, yang menyebabkan penurunan sementara pasokan oksigen ke janin. Penurunan ini adalah fenomena normal yang dimitigasi oleh mekanisme kompensasi janin, seperti redistribusi aliran darah ke organ penting termasuk jantung dan otak — dikenal sebagai efek brain-sparing.

Namun, bila kontraksi terlalu intens atau terlalu sering disertai respon katekolamin maternal yang tinggi, perfusi plasenta dapat menurun secara substansial, sehingga janin mengalami hipoksia ringan sampai sedang. Hipoksia ini dapat memicu respons neuroendokrin janin sendiri, termasuk peningkatan pelepasan katekolamin dan kortisol janin, yang merupakan bagian dari adaptasi terhadap lingkungan intrauterin yang berubah selama persalinan. Respon hormonal ini merupakan bagian dari persiapan janin untuk hidup extrauterin, terutama mempengaruhi perkembangan paru dan metabolisme energi (Tomoo Yuba , Yoshihisa Koyama, 2024)

Perubahan keseimbangan oksigenasi juga mempengaruhi denyut jantung janin, yang tercatat melalui monitor kardiotokografi (CTG). Hipoksia dapat menghasilkan pola denyut jantung yang berupa deselerasi atau variabilitas yang berubah, yang merupakan refleksi hemodinamik janin atas turunnya suplai oksigen sementara selama kontraksi.

3. Interaksi Respon Ibu–Janin

Respon fisiologis ibu terhadap nyeri persalinan dan stres memiliki hubungan langsung dengan kondisi janin. Aktivasi sistem saraf simpatis dan HPA ibu tidak hanya mengubah tekanan darah dan perfusi plasenta, tetapi juga berpotensi mempengaruhi tekanan perfusi fetoplacental dan pertukaran gas antar kedua sirkulasi. Peningkatan kadar stress hormone maternal dapat menyebabkan vasokonstriksi pada pembuluh darah plasenta, yang pada akhirnya mengurangi aliran darah dan oksigen ke janin, sehingga janin harus mengaktifkan mekanisme adaptifnya.

Dalam konteks klinis, pengelolaan nyeri persalinan yang adekuat baik dengan pendekatan farmakologis seperti analgesia epidural maupun intervensi non-farmakologis dapat meminimalkan respons stres ibu, menstabilkan hemodinamika, dan menurunkan dampak negatif pada perfusi uteroplasenta serta kesehatan janin

Latihan

1. Nyeri persalinan mengaktivasi sistem saraf simpatis yang menyebabkan peningkatan pelepasan hormon tertentu. Hormon yang paling berperan dalam respon "fight-or-flight" pada ibu adalah…
   A. Oksitosin
   B. Prolaktin
   C. Katekolamin
   D. Endorfin
   E. Progesteron

2. Hiperventilasi akibat nyeri persalinan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kondisi berikut pada ibu, yaitu…
   A. Asidosis metabolik
   B. Alkalosis respiratorik
   C. Hiperkapnia
   D. Bradikardia
   E. Hipoglikemia

3. Peningkatan kadar epinefrin yang berlebihan selama persalinan dapat berdampak pada kontraksi uterus karena…
   A. Meningkatkan sensitivitas reseptor oksitosin
   B. Menghambat pelepasan prostaglandin
   C. Menghambat kerja oksitosin
   D. Meningkatkan produksi endorfin
   E. Mempercepat dilatasi serviks

4. Selama kontraksi uterus, penurunan sementara aliran darah uteroplasenta terutama disebabkan oleh…
   A. Vasodilatasi arteri uterina
   B. Kompresi arteri uterina oleh miometrium
   C. Penurunan kadar oksitosin
   D. Peningkatan aliran vena umbilikalis
   E. Penurunan tekanan intrauterin

5. Mekanisme adaptasi janin terhadap penurunan oksigen selama kontraksi dikenal sebagai…
   A. Fetal tachycardia reflex
   B. Placental autoregulation
   C. Brain-sparing effect

D. Fetal distress response
E. Umbilical compensation

6. Akumulasi asam laktat pada ibu selama persalinan yang lama terutama disebabkan oleh…
   A. Penurunan kadar katekolamin
   B. Hiperventilasi berkepanjangan
   C. Aktivitas otot uterus yang intens
   D. Peningkatan kadar progesteron
   E. Penurunan kadar kortisol

7. Perubahan denyut jantung janin berupa deselerasi selama kontraksi dapat mencerminkan…
   A. Adaptasi fisiologis tanpa perubahan perfusi
   B. Penurunan sementara oksigenasi janin
   C. Peningkatan kadar oksitosin
   D. Penurunan kadar hemoglobin ibu
   E. Hipertermia maternal

8. Aktivasi poros hipotalamus–hipofisis–adrenal (HPA) pada ibu selama nyeri persalinan meningkatkan sekresi hormon…
   A. Estrogen
   B. Prostaglandin
   C. Kortisol
   D. Relaksin
   E. Human placental lactogen

9. Vasokonstriksi uteroplasenta akibat peningkatan katekolamin maternal berisiko menyebabkan…
   A. Peningkatan perfusi janin
   B. Hipoksia janin
   C. Peningkatan cairan amnion
   D. Hiperglikemia janin
   E. Penurunan denyut jantung ibu

10. Manajemen nyeri persalinan yang adekuat secara fisiologis dapat memberikan manfaat berikut, kecuali…
    A. Menurunkan kadar hormon stres maternal
    B. Menstabilkan hemodinamika ibu
    C. Meningkatkan perfusi uteroplasenta

D. Menghilangkan seluruh respon adaptif janin
E. Mengurangi risiko hipoksia janin

Kunci Jawaban

1. c
2. b
3. c
4. b
5. c
6. c
7. b
8. c
9. b
10. d

E. Rangkuman

Nyeri persalinan merupakan nyeri akut fisiologis yang timbul akibat kontraksi uterus, dilatasi serviks, serta peregangan jalan lahir. Pada kala I, nyeri bersumber dari kontraksi miometrium dan dilatasi serviks, bersifat viseral, tumpul, dan sulit dilokalisasi. Impuls nyeri dihantarkan melalui serabut aferen menuju medula spinalis segmen T10–L1. Pada kala II, nyeri berasal dari peregangan vagina dan perineum, bersifat somatik dan lebih tajam, dengan jalur melalui nervus pudendus menuju segmen S2–S4.

Impuls nyeri diteruskan melalui traktus spinotalamikus ke talamus dan korteks serebri untuk dipersepsikan secara sadar. Proses ini melibatkan tahapan transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Intensitas nyeri tidak hanya dipengaruhi rangsangan fisik, tetapi juga faktor psikologis dan emosional ibu.

Nyeri memicu aktivasi sistem saraf simpatis dan poros stres, meningkatkan pelepasan katekolamin dan kortisol. Dampaknya meliputi peningkatan denyut jantung, tekanan darah, konsumsi oksigen, serta kemungkinan vasokonstriksi uteroplasenta. Hiperventilasi dan peningkatan metabolisme juga dapat terjadi, terutama pada persalinan yang lama atau nyeri tidak terkontrol.

Pada janin, kontraksi uterus menyebabkan penurunan sementara aliran darah plasenta. Janin beradaptasi melalui redistribusi aliran darah ke organ vital. Namun, stres maternal berlebihan dapat mengganggu perfusi dan memengaruhi kesejahteraan janin.

Secara keseluruhan, mekanisme sumber dan jalur nyeri serta respon fisiologis ibu–janin bersifat adaptif dalam persalinan normal, tetapi memerlukan manajemen yang tepat agar tidak berkembang menjadi respon maladaptif.

Glosarium

Istilah	Definisi
Alkalosis Respiratorik	Peningkatan pH darah akibat penurunan kadar CO_2 karena hiperventilasi.
Analgesia Epidural	Metode pengurangan nyeri melalui pemberian anestetik lokal di ruang epidural untuk menghambat transmisi impuls nyeri.
Asidosis Metabolik	Penurunan pH darah akibat peningkatan asam (misalnya asam laktat) atau kehilangan basa dalam tubuh.
Brain-Sparing Effect	Mekanisme adaptasi janin terhadap hipoksia dengan mengalihkan aliran darah ke organ vital seperti otak dan jantung.
Dilatasi Serviks	Proses pembukaan leher rahim selama persalinan hingga mencapai pembukaan lengkap.
Dorsal Horn (Tanduk Dorsal)	Bagian posterior medula spinalis tempat pertama kali impuls sensorik, termasuk nyeri, diproses.
Endorfin	Neurotransmiter endogen yang berfungsi sebagai analgesik alami tubuh dalam modulasi nyeri.
Gate Control Theory	Teori yang menyatakan bahwa transmisi nyeri dapat dimodulasi melalui mekanisme "gerbang" pada medula spinalis.
Hipoksia	Kondisi kekurangan oksigen pada jaringan tubuh.
Hipoksia Miometrium	Penurunan suplai oksigen pada otot rahim akibat kontraksi yang kuat dan berulang.
Hipotalamus–Hipofisis–Adrenal (HPA Axis)	Sistem neuroendokrin yang berperan dalam respons stres dengan meningkatkan sekresi kortisol.
Hiperventilasi	Peningkatan frekuensi dan kedalaman napas yang menyebabkan penurunan CO_2 dalam darah.
Iskemia	Berkurangnya aliran darah ke jaringan sehingga menurunkan suplai oksigen dan nutrisi.
Kala I Persalinan	Tahap persalinan dari awal kontraksi efektif hingga pembukaan serviks lengkap (10 cm).

Istilah	Definisi
Kala II Persalinan	Tahap persalinan dari pembukaan lengkap hingga lahirnya bayi.
Katekolamin	Hormon stres (epinefrin dan norepinefrin) yang dilepaskan saat aktivasi sistem saraf simpatis.
Kardiotokografi (CTG)	Metode pemantauan denyut jantung janin dan kontraksi uterus secara simultan.
Korteks Serebri	Bagian otak yang berperan dalam persepsi sadar, termasuk persepsi nyeri.
Kortisol	Hormon stres yang diproduksi oleh korteks adrenal sebagai bagian dari respons terhadap stres.
Medula Spinalis	Bagian sistem saraf pusat yang menjadi jalur penghantar impuls saraf antara tubuh dan otak.
Miometrium	Lapisan otot uterus yang berkontraksi selama persalinan.
Neuromatrix	Konsep bahwa pengalaman nyeri dipengaruhi oleh interaksi sistem saraf dengan faktor emosional dan psikososial.
Nociceptor	Reseptor saraf yang mendeteksi rangsangan nyeri akibat kerusakan atau ancaman kerusakan jaringan.
Nervus Pudendus	Saraf yang menghantarkan impuls nyeri dari perineum ke segmen sakral (S2–S4).
Oksitosin	Hormon yang merangsang kontraksi uterus selama persalinan.
Perfusi Uteroplasenta	Aliran darah dari ibu ke plasenta untuk pertukaran oksigen dan nutrisi dengan janin.
Perineum	Daerah antara vagina dan anus yang mengalami peregangan saat persalinan.
Pleksus Frankenhäuser	Jaringan saraf yang menghantarkan impuls nyeri dari uterus dan serviks ke medula spinalis.
Transduksi	Proses perubahan rangsangan mekanik menjadi impuls listrik pada reseptor nyeri.
Transmisi	Proses penghantaran impuls nyeri dari perifer menuju sistem saraf pusat.

Istilah	Definisi
Modulasi Nyeri	Proses penguatan atau penghambatan impuls nyeri pada tingkat spinal dan supraspinal.
Traktus Spinotalamikus	Jalur saraf ascenden yang menghantarkan impuls nyeri dari medula spinalis ke talamus.

Referensi

Andarmoyo, S. (2013). *Persalinan Tanpa Nyeri Berlebihan*. Yogyakarta:

BKKBN. (2019). Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017. In Sdki (Issue October). doi: 10.13140/RG.2.2.33616.46089

Bobak, I.M, Lowdermilk D.I & Jensen, M. D. (2004). *Buku Ajar Keperawatan Maternitas*. Jakarta: EGC.

CRAIG, J. D. (1948). The pain of labour. *British Medical Journal*, *1*(4553), 706. doi: 10.1136/bmj.1.4553.706-a

Cunningham FG,Leveno KJ, Bloom SL,Haunth JC, Gilstrap LC, W. K. (2018). *Williams Obstetrics*. New York : McGraw-Hill Inc.

Durham, L. C. and R. (2019). The Essense of Maternity-Newborn Nursing. In Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53, Issue 9). California United States of America.

Indonesia, P., Online, W., Online, W., & License, C. (1994). Classification of cronic pain at a multidisciplinary pain rehabilitation clinic. *IASP*, *2nd*. doi: 10.1155/1998/582810

Kumar, K. H., & Elavarasi, P. (2016). Definition of pain and classification of pain disorders. *Journal of Advanced Clinical & Research Insights*, *3*(June), 87–90. doi: 10.15713/ins.jcri.112

Mander. (2004). *Nyeri Persalinan*. Jakarta: EGC.

Potter, P.A. Perry, A. . (2005). *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses Dan Praktik* (EGC (ed.); Vols. 1, E/4). Jakarta.

Rachmawati, F. (2025). Birthing Ball Gymnastics Technique to Reduce Labor Pain. *PLACENTUM Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya*, *13*(1).

santi, L. S. (2015). *Perbedaan Efektivitas Massage Abdominal Lifting Dan Aroma Terapi Lavender (Lavandula Angustifolia) Terhadap Tingkat Nyeri Persalinan Kala I Fase aktif Pada Primigravida (Studi di Rumah Bersalin Kasih Ibu Kabupaten Kediri)*.

Tomoo Yuba , Yoshihisa Koyama, et all. (2024). Analysis of Maternal and Fetal Oxidative Stress During Delivery with Epidural Analgesia. *Springer*. Retrieved from https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11393216/?utm_source=chatgpt.com

Wright, C., & Geraghty, S. (2017). *Mind over Matter : Inside Hypnobirthing*. *19*(3), 54–60.

BAB 3

PENGKAJIAN NYERI DAN KENYAMANAN : SKALA NYERI, TANDA KLINIS, DAN DOKUMENTASI

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan sensitivitas budaya dalam pengelolaan nyeri dan kenyamanan persalinan.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik, informed choice, dan kolaborasi dengan ibu, keluarga, dan tim kesehatan.	CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan keselamatan pasien, PPI, K3, dan manajemen risiko dalam intervensi manajemen nyeri persalinan.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-4	Melakukan pengkajian komprehensif dan clinical reasoning berbasis data untuk menentukan rencana manajemen nyeri dan kenyamanan ibu–janin.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-7
CPL-5	Melaksanakan intervensi nonfarmakologi dan mendukung manajemen farmakologi dasar sesuai kewenangan secara aman dan bermutu.	CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Melakukan edukasi, dokumentasi terstandar, dan pemanfaatan bukti ilmiah dasar untuk evaluasi hasil dan peningkatan mutu asuhan.	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Mengevaluasi prinsip, tujuan, dan aspek keselamatan manajemen nyeri persalinan yang berpusat pada ibu–janin.
CPMK-2	Menganalisis fisiologi nyeri persalinan (sumber, jalur, respons ibu–janin) sebagai dasar pemilihan intervensi dan pemantauan.
CPMK-3	Menganalisis faktor psikologis, sosial, budaya, dan pengalaman melahirkan serta implikasinya terhadap persepsi nyeri dan kenyamanan.
CPMK-4	Melaksanakan pengkajian nyeri/kenyamanan, interpretasi tanda klinis, serta pendokumentasian terstandar untuk pemantauan berkelanjutan.
CPMK-5	Merancang dan menerapkan strategi nonfarmakologi serta dukungan emosional dengan komunikasi terapeutik dan prinsip keamanan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-6	Mengintegrasikan farmakologi dasar analgesia persalinan dengan kolaborasi, pemantauan, dan kewaspadaan efek samping sesuai kewenangan.
CPMK-7	Menyusun rencana manajemen nyeri pada kondisi khusus, mengevaluasi hasil (kepuasan/outcome), dan merancang edukasi tindak lanjut berbasis bukti.

E. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 3. Pengkajian Nyeri dan Kenyamanan: Skala Nyeri, Tanda Klinis, dan Dokumentasi	3.1 Memilih dan menerapkan skala nyeri/kenyamanan sesuai kondisi, komunikasi, dan kemampuan ibu	3.2 Menyusun dokumentasi temuan, intervensi, dan respons nyeri secara terstandar untuk continuity of care	CPMK-4	CPMK-5; CPMK-1

F. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis berbasis kasus (CBT/SAQ)	Menetapkan tujuan manajemen nyeri dan langkah keselamatan prioritas; mengidentifikasi kontraindikasi/batas kewenangan pada skenario	10	Lembar jawaban ujian
CPMK-4	OSCE pengkajian + audit dokumentasi	Mengukur nyeri/kenyamanan dengan skala yang tepat dan konsisten; mencatat temuan–tindakan–respons lengkap dan kronologis	15	Checklist OSCE + lembar dokumentasi
CPMK-5	OSCE keterampilan nonfarmakologi (simulasi)	Melakukan coaching dukungan emosional/pernapasan/relaksasi; menerapkan teknik fisik/lingkungan dengan keamanan dan evaluasi respons	25	Checklist OSCE + catatan evaluasi respons

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Identifikasi tujuan dan prinsip keselamatan pada skenario	Tujuan tidak jelas/keliru; aspek keselamatan terabaikan	Tujuan cukup jelas; keselamatan disebut umum namun belum memprioritaskan risiko utama	Tujuan tepat; keselamatan diprioritaskan, ada kekurangan minor	Tujuan sangat tepat; keselamatan komprehensif, proaktif, berbasis risiko ibu–janin
1.2 Penetapan intervensi awal sesuai kondisi & kewenangan	Pilihan tidak sesuai kondisi/kewenangan; berpotensi tidak aman	Pilihan sebagian sesuai; mitigasi risiko/kontraindikasi belum lengkap	Pilihan sesuai; mitigasi risiko jelas, masih ada detail minor yang kurang	Pilihan paling sesuai; mitigasi risiko lengkap dan disertai alasan yang kuat

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Pemetaan sumber & jalur nyeri sesuai kala	Banyak konsep salah; tidak dapat mengaitkan dengan kala	Sebagian benar; masih ada kekeliruan pada pemetaan/urutan	Hampir seluruhnya benar; ada kekeliruan minor	Akurat dan lengkap; mampu mengaitkan pola nyeri dengan proses persalinan
2.2 Interpretasi respons ibu–janin dan implikasi pemantauan	Salah menafsir respons; rekomendasi pemantauan tidak tepat	Menafsir sebagian; rekomendasi pemantauan masih umum	Menafsir tepat; rekomendasi pemantauan relevan dan aman	Menafsir sangat tepat; rekomendasi pemantauan spesifik, antisipatif, dan rasional

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Identifikasi faktor psikologis–sosial–budaya	Faktor kunci tidak teridentifikasi; asumsi tidak berdasar	Faktor teridentifikasi sebagian; masih ada bias/kurang lengkap	Faktor teridentifikasi baik dan relevan; bias minimal	Faktor lengkap, relevan, dan berimbang; menunjukkan sensitivitas budaya yang kuat
3.2 Rekomendasi pendekatan	Pendekatan tidak sesuai; berpotensi	Pendekatan cukup sesuai namun generik; kurang	Pendekatan sesuai; menyesuaikan	Pendekatan sangat sesuai; empatik, trauma-informed,

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
komunikasi & dukungan	meningkatkan distres	menyesuaikan konteks ibu	konteks dan mendukung coping	dan memfasilitasi kontrol diri ibu

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Pengukuran nyeri/kenyamanan (pemilihan skala & konsistensi)	Skala/teknik tidak tepat; pengukuran tidak konsisten	Skala cukup tepat; konsistensi dan waktu pengukuran belum optimal	Skala tepat; pengukuran konsisten sesuai kebutuhan pemantauan	Skala sangat tepat; pengukuran konsisten, responsif terhadap perubahan kondisi
4.2 Dokumentasi temuan–tindakan–respons	Catatan tidak lengkap/tidak runtut; sulit ditindaklanjuti	Catatan cukup lengkap; masih ada bagian penting yang hilang	Catatan lengkap dan runtut; mudah ditelusuri	Catatan sangat lengkap, jelas, standar; mendukung pengambilan keputusan dan continuity of care

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Coaching dukungan emosional/pernapasan/relaksasi	Komunikasi tidak terapeutik; instruksi tidak dipahami; tidak aman	Komunikasi cukup; instruksi dipahami sebagian; perlu banyak arahan	Komunikasi terapeutik; instruksi jelas; aman dengan koreksi minor	Komunikasi sangat efektif; memberdayakan ibu & pendamping; aman dan adaptif
5.2 Implementasi teknik fisik/lingkungan & evaluasi respons	Teknik tidak sesuai/berisiko; tidak mengevaluasi respons	Teknik cukup sesuai; evaluasi respons minim/umum	Teknik sesuai dan aman; evaluasi respons jelas dan berkelanjutan	Teknik sangat tepat; evaluasi respons terukur, adaptasi cepat, dan berorientasi kenyamanan

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Kesesuaian pemilihan analgesia dasar & identifikasi risiko	Pilihan tidak sesuai indikasi; risiko/kontraindikasi terlewat	Pilihan cukup sesuai; risiko/kontraindikasi disebut sebagian	Pilihan sesuai; risiko/kontraindikasi utama teridentifikasi	Pilihan paling sesuai; risiko/kontraindikasi lengkap dan disertai pertimbangan rasional
6.2 Pemantauan, tindak lanjut efek samping, dan komunikasi kolaboratif	Tidak memantau parameter kunci; tindak lanjut tidak tepat	Memantau sebagian; tindak lanjut dan komunikasi masih kurang terstruktur	Pemantauan tepat; tindak lanjut aman; komunikasi kolaboratif jelas	Pemantauan komprehensif; tindak lanjut antisipatif; komunikasi kolaboratif sangat efektif dan terdokumentasi

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Perencanaan manajemen nyeri pada kondisi khusus (prioritas, integrasi, eskalasi)	Rencana tidak sesuai risiko; prioritas/eskalasi tidak jelas	Rencana cukup sesuai; integrasi modalitas dan eskalasi belum mantap	Rencana sesuai; prioritas jelas; integrasi dan eskalasi aman	Rencana sangat kuat; prioritas tajam; integrasi komprehensif; eskalasi/rujukan tepat waktu dan berbasis risiko
7.2 Evaluasi hasil & rencana edukasi tindak lanjut	Tidak menetapkan indikator; edukasi tidak relevan/tidak dapat diterapkan	Indikator ada namun terbatas; edukasi umum	Indikator relevan; edukasi jelas dan dapat diterapkan	Indikator lengkap dan terukur; edukasi sangat personal, realistis, mendukung coping dan rencana lanjutan

A. Aktifitas Belajar (Scaffolding)

1. Landasan Teori: Pengkajian Nyeri dan Kenyamanan
   a. Hakikat Nyeri dalam Persalinan

      Nyeri persalinan adalah pengalaman sensorik dan emosional yang bersifat subjektif, unik, dan dipengaruhi oleh faktor fisiologis, psikologis, serta budaya. Berbeda dengan nyeri akibat penyakit, nyeri persalinan bersifat intermiten (hilang timbul seiring kontraksi) dan merupakan tanda kemajuan proses fisiologis. Dalam asuhan kebidanan, pengkajian nyeri yang akurat

menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis. Pengkajian nyeri persalinan dilakukan dengan pendekatan PQRST:

- P (Palliative/Provocative): Apa yang memperparah (kontraksi, posisi) atau mengurangi nyeri (pijatan, teknik napas).
- Q (Quality): Rasa nyeri seperti diremas, disayat, atau ditekan.
- R (Region): Area punggung bawah menjalar ke perut bawah.
- S (Severity): Tingkat keparahan menggunakan skala 0–10.
- T (Time)**:** Frekuensi dan durasi kontraksi.

b. Neurofisiologi Nyeri Persalinan

Bidan harus memahami asal nyeri untuk menentukan teknik pengkajian dan intervensi yang tepat:

1) Nyeri Visceral (Kala I): Muncul akibat dilatasi serviks dan peregangan segmen bawah rahim. Nyeri ini dihantarkan melalui serabut saraf simpatis T10 hingga L1, sering dirasakan sebagai mulas yang menjalar ke pinggang.
2) Nyeri Somatik (Kala II): Muncul akibat peregangan jaringan vagina, perineum, dan tekanan pada pleksus saraf sakralis saat janin turun. Nyeri ini bersifat tajam dan terlokalisasi di area dasar panggul.

c. Instrumen Pengkajian Skala Nyeri (Sub-CPMK 1)

Memilih instrumen yang tepat sangat krusial agar data yang didapat valid dan sesuai dengan kondisi komunikasi ibu:

1) Numeric Rating Scale (NRS): Digunakan untuk ibu yang kooperatif dan memiliki kemampuan kognitif yang baik di antara jeda kontraksi.

   Metode ini mengharuskan ibu untuk mengkuantifikasi rasa nyeri yang dirasakan ke dalam sebuah angka. Berikut adalah pembagian kategorinya:

   Skala 0 (Tidak Nyeri): Ibu merasa nyaman, tidak ada sensasi nyeri atau mulas yang dirasakan.

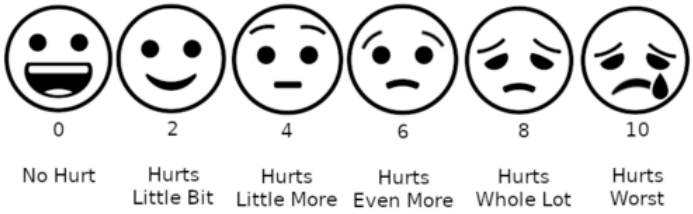
   Skala 1 – 3 (Nyeri Ringan): Ibu merasakan mulas, namun masih bisa berkomunikasi dengan sangat baik, dapat tersenyum, dan mampu melakukan teknik relaksasi secara mandiri. Nyeri tidak mengganggu aktivitas bicara.

   Skala 4 – 6 (Nyeri Sedang): Nyeri mulai mendominasi. Ibu tampak meringis, mendesis, atau memegang area yang nyeri. Ibu masih bisa menjawab pertanyaan, namun fokusnya mulai terpecah oleh kontraksi.

   Skala 7 – 9 (Nyeri Berat): Ibu sangat kesakitan, tidak dapat fokus pada hal lain selain nyerinya. Respon fisik terlihat jelas (nadi meningkat, keringat dingin, gelisah). Ibu mungkin sulit diajak berkomunikasi secara panjang lebar dan membutuhkan bantuan intensif untuk manajemen nyeri.

Skala 10 (Nyeri Sangat Berat/Tak Tertahankan): Nyeri pada tingkat tertinggi yang pernah dibayangkan. Ibu mungkin menjerit, kehilangan kontrol diri, atau bahkan tidak mampu merespon pertanyaan karena intensitas nyeri yang luar biasa.

2) Visual Analogue Scale (VAS): Menggunakan garis horizontal sepanjang 10 cm tanpa angka. Ibu diminta untuk memberikan tanda titik atau garis tegak lurus pada posisi di sepanjang garis tersebut yang menurutnya paling mewakili rasa nyerinya saat itu. Setelah ibu menandai garis, bidan menggunakan penggaris untuk mengukur jarak (dalam mm atau cm) dari ujung kiri ("Tidak Nyeri") ke tanda yang dibuat ibu. Jarak tersebutlah yang menjadi skor nyeri ibu.
   Ujung kiri (titik 0) diberi keterangan: "Tidak Nyaman / Tidak Nyeri".
   Ujung kanan (titik 10) diberi keterangan: "Nyeri Paling Hebat / Tidak Tertahankan".
3) Wong-Baker FACES Scale: Menggunakan ilustrasi wajah dari tersenyum hingga menangis. Sangat efektif untuk ibu yang mengalami kesulitan bahasa, literasi rendah, atau stres emosional berat yang menghambat pemikiran abstrak angka.



4) **FLACC Behavioral Scale (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability):** Digunakan melalui observasi bidan jika ibu tidak mampu berkomunikasi verbal (misal: saat sangat lelah atau dalam pengaruh obat).

Kategori	Skor 0	Skor 1	Skor 2
Face (Wajah)	Tersenyum, ekspresi rileks.	Kadang meringis atau mengerutkan kening, tampak tidak tertarik.	Sering mengerutkan dahi, rahang terkatup, dagu gemetar.
Legs (Kaki)	Posisi normal atau rileks.	Tidak tenang, gelisah, tegang.	Menendang, atau kaki tertekuk rapat ke arah perut.
Activity (Aktivitas)	Berbaring tenang, posisi normal,	Menggeliat, berpindah-pindah posisi, tegang.	Melengkungkan punggung, kaku, atau menghentak.

Kategori	Skor 0	Skor 1	Skor 2
	bergerak mudah.		
Cry (Tangisan)	Tidak menangis (terjaga atau tidur).	Merintih atau merengek, kadang-kadang mengeluh.	Menangis terus-menerus, berteriak atau terisak, sering mengeluh.
Consolability (Kemampuan Ditenangkan)	Tenang, rileks.	Dapat ditenangkan dengan sentuhan, pelukan, atau berbicara.	Sulit atau tidak dapat ditenangkan dengan kata-kata atau sentuhan.

Interpretasi Total Skor:

0: Nyaman/Tidak Nyeri.

1–3: Nyeri Ringan.

4–6: Nyeri Sedang.

7–10: Nyeri Berat / Ketidaknyamanan Luar Biasa.

d. Interpretasi Tanda Klinis dan Respon Tubuh

Selain laporan subjektif, bidan wajib memantau respon objektif sistem saraf otonom terhadap nyeri:

1) Respon Kardiovaskular: Peningkatan tekanan darah dan denyut nadi akibat pelepasan katekolamin.
2) Respon Respirasi: Perubahan pola napas menjadi lebih cepat (hiperventilasi) atau dangkal.
3) Respon Perilaku: Wajah meringis, mencengkeram tangan pendamping, gerakan gelisah, hingga penolakan terhadap tindakan medis.

e. Identifikasi Tanda Bahaya (*Red Flags*)

Pengkajian nyeri juga bertujuan untuk deteksi dini komplikasi:

1) Nyeri Menetap: Nyeri tajam yang terus-menerus tanpa relaksasi di antara kontraksi (waspada solusio plasenta atau ruptur uteri).
2) Perubahan Kesadaran: Ibu tampak sangat bingung atau mengalami penurunan kesadaran yang disertai nyeri hebat.

f. Dokumentasi Terstandar (Sub-CPMK 2)

Dokumentasi nyeri merupakan bagian penting dari *continuity of care* (asuhan berkelanjutan). Temuan nyeri, jenis skala yang digunakan, intervensi yang diberikan, serta respon ibu wajib dicatat secara sistematis (misalnya menggunakan format SOAP) yang dicatat pada lembar Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) untuk memastikan pemantauan berkelanjutan.

1) Prinsip Dokumentasi: Harus mencatat skor nyeri awal, alat ukur yang digunakan, lokasi nyeri, intervensi yang diberikan (misal: teknik napas atau pijat), dan evaluasi respon setelah intervensi.
2) Format SOAP: Temuan subjektif (skor nyeri) dan objektif (tanda vital/perilaku) menjadi dasar dalam merumuskan diagnose dan asuhan kebidanan dalam mengatasi nyeri persalinan.

Aktivitas 1 — *Knows How* (Mini-case)
Metode: Diskusi Kelompok Identifikasi Risiko dan Red Flags.

Skenario Kasus: Seorang Perempuan umur 28 tahun, G1P0A0 hamil 39 minggu, datang ke TPMB pukul 08.00 dengan keluhan mulas yang kencang menjalar sampai ke pinggang sejak pukul 02.00 WIB. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tampak wajah meringis serta memegang pinggang karena mulas, TD 135/85 mmHg, nadi 104 x/menit, suhu 36,8°C, his 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik, DJJ 146 x/menit. Pemeriksaan dalam diketahui pembukaan serviks 5 cm, ketuban utuh, tidak ada bagian yang menumbung, presentasi kepala, penurunan kepala Hodge 2. Pasien tampak meringis, dahi berkerut, dan mata terpejam saat kontraksi muncul. Saat ini pasien tampak sangat gelisah dan terus memegang pinggangnya.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa saja tanda klinis nyeri persalinan pada kasus diatas?
2. Apa instrument skala nyeri yang tepat berdasarkan kasus tersebut?
3. Apa saja tanda bahaya (*red flags*) yang harus diwaspadai jika respon nyeri pasien disertai dengan penurunan detak jantung janin atau perdarahan hebat?.

TEMPLATE SOAL OSCE KEBIDANAN

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Persalinan: Fisiologis
3	Kasus	Pengkajian Nyeri persalinan dan kenyamanan
4	Tujuan	Menilai peserta ujian melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik/penunjang, perumusan diagnosis dan/masalah kebidanan, prosedur tindakan klinis sesuai dignosis/masalah, dan perilaku profesional pada tindakan pengkajian nyeri persalinan.
5	Kompetensi	1**. Anamnesis** **2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana** **3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah** **4. Prosedur tindakan klinis** 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. **Perilaku profesional**
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang Perempuan umur 28 tahun, G1P0A0 hamil 39 minggu, datang ke TPMB pukul 08.00 dengan keluhan mulas yang kencang menjalar sampai ke pinggang sejak pukul 02.00 WIB. Ibu tampak gelisah, meringis, dan terus memegang pinggangnya. TUGAS 1. Lakukan anamnesis terfokus menggunakan pendekatan **PQRST!** 2. Lakukan pemeriksaan fisik/obstetri terfokus sesuai kasus! 3. Tentukan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh! 4. Lakukan tindakan pengkajian nyeri dengan skala yang tepat pada kasus tersebut!
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta

No.	Komponen	Isi
		b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikutkan kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. **INSTRUKSI KHUSUS UNTUK PENGUJI:** 1. Penguji menilai kemampuan anamnesa nyeri secara lengkap (P, Q, R, S, T) dengan sistematis. **Provocative (P)**: nyeri bertambah parah saat bergerak atau saat perut terasa kencang. **Quality (Q)**: Menjelaskan rasa nyeri seperti "diremas-remas" atau "disayat-sayat". **Region (R)**: Menunjuk area perut bawah yang menjalar hingga ke punggung. **Severity (S)**: Menyebutkan angka skala nyeri 7 dari 10 (nyeri berat terkontrol). **Time (T)**: Mengatakan mulas muncul sering (tiap 3 menit) dengan durasi yang lama. 2. Penguji menilai tindakan pemeriksaan fisik dengan hasil : keadaan umum baik, tampak wajah meringis serta memegang pinggang karena mulas, TD 135/85 mmHg, nadi 104 x/menit, suhu 36,8°C, his 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik, DJJ 146 x/menit. Pemeriksaan dalam : pembukaan serviks 5 cm, ketuban utuh, tidak ada bagian yang menumbung, presentasi kepala, penurunan kepala Hodge 2 3. Penguji menilai diagnosis yang ditulis oleh peserta yaitu: **G1P0A0 inpartu/parturient 39 minggu kala I Fase aktif Janin tunggal hidup intra uterin presentasi kepala**

No.	Komponen	Isi
		Masalah : Mulas yang semakin kencang 4. Penguji menilai ketepatan pengkajian skala nyeri dengan NRS skala 7 INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan PS	Instruksi PS: 1. PS berperan sebagai ibu inpartu kala I fase aktif. 2. PS duduk di kursi pemeriksaan dengan kondisi tampak cemas, lelah, sesekali meringis saat kontraksi, memegang perut bawah, dan berbicara terputus saat nyeri datang. 3. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif.
9	Instruksi PS	**Biodata:** Nama : Ny. D (sesuai nama PS) Umur : 28 tahun Agama : Islam Pekerjaan : IRT Pendidikan : D3 **Keluhan**: Mulas sejak tadi malam sekitar pukul 02.00 WIB, saat ini dirasakan setiap 3 menit sekali dan lamanya sekitar 45 detik, ada pengeluaran lendir bercampur darah yang bertambah banyak, belum ada pengeluaran air-air dari jalan lahir, gerakan janin masih dirasakan terakhir 30 menit yang lalu. **Peran yang wajib ditunjukkan oleh ibu bersalin:** • Ps berperan sebagai ibu hamil 9 bulan, kehamilan pertama, tidak pernah keguguran. Keluhannya sudah merasakan mulas yang semakin kuat • Pasien duduk di kursi pemeriksaan dengan ekspresi cemas dan gelisah, mengeluh mulas yang sangat kuat.

No.	Komponen	Isi
		• Jawablah pertanyaan peserta ujian sesuai skenario yang disediakan, bila peserta ujian bertanya tentang **hal di luar skenario**, jawablah: **tidak tahu atau saya tidak merasakan.** Peserta: Selamat pagi Bu. PS: Pagi Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS: Saya mulas kuat dari tadi malam sekitar jam 02.00 Bu. Peserta: bagaimana nyeri yang dirasakan ibu? PS : nyeri bertambah parah saat bergerak atau saat perut terasa kencang. Peserta : apakah nyerinya terasa sakit sekali seperti di remas-remas atau disayat? PS : ya betul bu, nyerinya seperti "diremas-remas" atau "disayat-sayat". Peserta : di daerah mana ibu merasakan nyerinya? PS : Menunjuk area perut bawah yang menjalar hingga ke punggung. Peserta : kalau saya menyebutkan angka nyeri dari 0 – 10, ada di angka berapa nyeri yang ibu rasakan? PS : angka 7 Peserta : setiap berapa menit sekali muncul mulas nya? PS : mulas muncul sering (tiap 3 menit) dengan durasi yang lama sekitar 45 detik. • Catatan: Jawablah pertanyaan peserta ujian sesuai skenario yang disediakan, bila peserta ujian bertanya tentang **hal di luar skenario**, jawablah: **tidak tahu atau saya tidak merasakan.**
10	Kebutuhan manikin	- Phantom abdomen hamil/manekin Leopold - Phantom panggul/serviks untuk simulasi pemeriksaan dalam - Lembar pengkajian skala nyeri NRS

No.	Komponen	Isi
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Mengganti lembar instruksi bila diperlukan - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. APD: • Celemek 1 buah • Kacamata 1 buah • Masker sesuai jumlah peserta • Penutup kepala 1-2 buah • Sepatu 1 pasang 2. Baki beralas 1 buah 3. Handuk besar 1 buah 4. Kain manajemen aktif 1 buah 5. Kain samping 1 buah 6. Underpad 1 buah 7. Pernel 1 buah 8. Baju Ibu 1 buah 9. Topi bayi 1 buah 10. Selimut 1 buah 11. Monoaural 1 buah 12. Baskom berisi larutan Klorin 0,5% 13. Tempat sampah 2 buah 14. Spuit 3 cc berisi Oksitosin sejumlah peserta 15. Partus Set (dalam keadaan steril) • Bak instrument 1 buah • Pemecah ketuban 1 buah • Gunting episiotomi 1 buah • Klem tali pusat 2 buah • Gunting tali pusat 1 buah • Benang tali pusat 2 buah • Kassa secukupnya • Handschoon 2 pasang 16. Air minum dalam gelas/botol air mineral untuk pasien 17. Lembar pengkajian nyeri NRS 18. Lembar jawaban peserta — 1 lembar 19. Pena — 1

No.	Komponen	Isi
13	Penulis	Bdn. Dede Waslia, SST., MKM
14	Referensi	1. International Confederation of Midwives (ICM). (2021). *Essential Competencies for Midwifery Practice*. The Hague: ICM. 2. JNPK-KR, Buku Acuan Pelatihan Klinik Asuhan Persalinan Normal, Jakarta, 2017. 3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan*. Jakarta: Kemenkes RI. 4. World Health Organization. (2020). *Pocket Book of Hospital Care for Mothers: Guidelines for the Management of Common Maternal Conditions*. Geneva: WHO. 5. Walsh, L. V. (2020). *Midwifery: Community-Based Care During the Childbearing Year*. Jones & Bartlett Learning.

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Pengkajian Nyeri dan Kenyamanan (Skala Nyeri, Tanda Klinis, dan Dokumentasi)

Komponen	**Deskripsi**	**Contoh pada Contoh pada Kasus Pengkajian Nyeri dan Kenyamanan**
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan peserta, lalu memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang lazim dinilai mencakup *informed consent*, persiapan pra-tindakan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan anamnesa nyeri menggunakan teknik PQRST, melakukan observasi tanda klinis nyeri, dan mendemonstrasikan penggunaan alat bantu skala nyeri (NRS/FACES) kepada pasien.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa melakukan pengkajian nyeri yang akurat, sistematis, dan empatik. Fokus utama adalah ketepatan menentukan skala nyeri untuk mengambil keputusan klinis yang aman bagi pasien	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang teori nyeri, tetapi dari kemampuannya memvalidasi antara laporan subjektif pasien (skala) dengan tanda klinis objektif (nadi, wajah) serta ketepatan dokumentasinya.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran, khususnya identifikasi intensitas nyeri, tanda klinis penyerta, dan kebutuhan intervensi	Seorang Perempuan umur 28 tahun, G1P0A0 hamil 39 minggu, datang ke TPMB pukul 08.00 dengan keluhan mulas yang kencang menjalar sampai ke pinggang sejak pukul 02.00 WIB. Ibu tampak gelisah, meringis, dan terus memegang perut sampai pinggangnya.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Contoh pada Kasus Pengkajian Nyeri dan Kenyamanan
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur pengkajian, bukan sekadar berdiskusi. Keterampilan yang relevan mencakup validasi identitas, penjelasan prosedur, anamnesa PQRST, penggunaan skala nyeri, dan observasi tanda vital.	Mahasiswa menyapa pasien, menjelaskan tujuan pengkajian, menanyakan karakteristik nyeri (PQRST), meminta pasien menunjuk angka pada skala nyeri, menghitung nadi, dan segera mencatat hasilnya pada lembar observasi.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pemahaman instrumen nyeri, persetujuan tindakan, kemampuan teknis skoring, komunikasi empatik, dan profesionalisme. Termasuk ketepatan mengenali tanda nyeri patologis (*red flags*)	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan antara skor nyeri yang tinggi dengan tanda klinis (meringis, takikardia) dan memberikan respon komunikasi yang menenangkan.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah mutu performa nyata mahasiswa saat berinteraksi dengan pasien. Pembimbing memperhatikan ketepatan penggunaan alat ukur dan kualitas komunikasi.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa sabar saat pasien kesakitan, tidak terburu-buru saat bertanya, dan memberikan edukasi teknik napas sebagai tindakan kenyamanan awal setelah pengkajian.
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form menekankan pada kekuatan, area pengembangan, dan rencana perbaikan.	Pembimbing menyampaikan bahwa mahasiswa sudah sangat baik dalam melakukan anamnesa PQRST, namun perlu lebih teliti dalam melakukan dokumentasi waktu munculnya nyeri secara spesifik.
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi	Mahasiswa kompeten jika mampu menentukan skala nyeri secara

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Contoh pada Kasus Pengkajian Nyeri dan Kenyamanan
	kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan didasarkan pada ketepatan langkah, keselamatan pasien, dan kemampuan mengambil keputusan.	akurat dan empatik. Remedial ditetapkan jika mahasiswa salah membaca skala atau gagal mengenali tanda bahaya yang menyertai nyeri.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does karena performanya diamati langsung saat melakukan tindakan klinik. Observasi langsung pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan DOPS sangat sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi.	Pada kasus nyeri, mahasiswa dinilai mampu menerapkan teori pengkajian ke dalam tindakan klinis yang nyata, memastikan pasien mendapatkan manajemen nyeri yang tepat berdasarkan data yang valid.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 3. 1 Portofolio pada Pengkajian Nyeri dan Kenyamanan (Skala Nyeri, Tanda Klinis, dan Dokumentasi)

Komponen	**Deskripsi**	**Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal**
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik pengkajian nyeri, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan anamnesis PQRST, menggunakan instrumen skala nyeri (NRS/FACES) secara tepat, mengobservasi tanda klinis (nadi, ekspresi), serta mendokumentasikannya secara akurat.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah mengkaji nyeri pada ibu bersalin, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	**OSCE:** Hasil ujian simulasi pengkajian PQRST dan penggunaan alat bantu skala nyeri. **DOPS:** Hasil observasi langsung oleh CI saat mahasiswa mengkaji nyeri pada pasien nyata di bangsal atau kamar

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
		bersalin, termasuk ketepatan menghitung nadi dan respirasi saat nyeri.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus Ny. S, G1P0A0 dengan nyeri persalinan skala 7 (NRS), data objektif (meringis, nadi 96x/mnt), tindakan kenyamanan awal yang diberikan, dan hasil evaluasi setelah intervensi.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya ketepatan skoring nyeri untuk mencegah kesalahan pemberian dosis analgesik, kewaspadaan terhadap *red flags* (nyeri patologis), dan pentingnya dokumentasi tepat waktu agar tidak terjadi tumpang tindih asuhan.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah sangat baik dan tenang dalam melakukan pengkajian PQRST, namun perlu meningkatkan ketelitian dalam mendokumentasikan durasi dan frekuensi nyeri secara periodik.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kali mengkaji nyeri, tetapi dari beberapa pengalaman klinis yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu memvalidasi nyeri subjektif dengan tanda klinis objektif secara akurat.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, dan catatan rekam medis, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu memilih instrumen nyeri yang sesuai (misal: menggunakan FACES untuk pasien yang kesulitan berkomunikasi) dan melakukan dokumentasi yang benar.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada topik nyeri dan kenyamanan, portofolio membuktikan bahwa mahasiswa tidak hanya hafal teori PQRST, tetapi secara nyata mampu memberikan asuhan yang berfokus pada kenyamanan pasien berdasarkan pengkajian yang tepat.

Tabel 3. 2 Case Report pada Pengkajian Nyeri dan Kenyamanan (Skala Nyeri, Tanda Klinis, dan Dokumentasi)

Komponen	**Deskripsi**	**Contoh pada Kasus Pengkajian Nyeri dan Kenyamanan**
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang Perempuan yang mengalami nyeri persalinan skala berat, menunjukkan tanda kompensasi fisiologis (takikardia), dan respon perilaku yang memerlukan intervensi kenyamanan segera.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan skor angka nyeri, tetapi menjelaskan kaitan antara kontraksi (P), kualitas nyeri (Q), lokasi (R), skala (S), dan durasi (T) dengan kondisi tanda vital ibu serta efektivitas teknik relaksasi yang diberikan.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Mahasiswa menuliskan: Keluhan mulas menjalar ke punggung, skala NRS 7, wajah meringis, nadi 104x/menit. Analisis: Nyeri persalinan hebat fase aktif. Implementasi: Pengaturan posisi miring kiri dan pijat *counter-pressure*. Evaluasi: Skala nyeri turun menjadi 5 dan pasien lebih tenang.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu memvalidasi data subjektif (skala nyeri) dengan data objektif (tanda klinis) serta ketepatan dalam

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pengkajian Nyeri dan Kenyamanan
		memilih instrumen pengkajian yang sesuai dengan kondisi pasien.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus nyeri ini, mahasiswa belajar bahwa pengkajian nyeri yang akurat (bukan sekadar asumsi) adalah kunci utama dalam menentukan keberhasilan asuhan sayang ibu dan manajemen nyeri yang tepat.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya hafal teori PQRST dan skala nyeri, tetapi mampu menyusun laporan yang menggambarkan kemampuannya dalam mengelola kenyamanan pasien secara utuh dan profesional.

Tabel 3. 3 Refleksi Patient Safety pada Pengkajian Nyeri dan Kenyamanan (Skala Nyeri, Tanda Klinis, dan Dokumentasi)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pengkajian Nyeri dan Kenyamanan
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada pengkajian nyeri, mahasiswa merefleksikan bahwa ketidakakuratan dalam menilai skala nyeri dapat menyebabkan kegagalan dalam memberikan intervensi asuhan pengurangan nyeri, yang berisiko pada kelelahan ibu dan gawat janin.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti mengabaikan kenaikan nadi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pengkajian Nyeri dan Kenyamanan
	pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	(takikardia) atau salah memilih instrumen skala nyeri pada pasien yang gelisah, dapat menunda penanganan nyeri yang seharusnya segera dilakukan.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama adalah nyeri patologis yang tidak terdeteksi, syok neurogenik akibat nyeri hebat, serta kesalahan dokumentasi yang mengakibatkan diskontinuitas asuhan.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang diidentifikasi meliputi: salah interpretasi skala nyeri (underestimating pain), gagal mengenali *red flags* (nyeri menetap di luar kontraksi), dan risiko jatuh pada pasien yang sangat gelisah karena menahan nyeri.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya validasi silang antara data subjektif (skala) dan objektif (tanda vital), melakukan pengkajian PQRST secara periodik, memastikan lingkungan aman (side rail terpasang), dan melakukan dokumentasi *real-time*.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pengkajian nyeri bukan sekadar menanyakan angka, melainkan proses klinis untuk memastikan kesejahteraan ibu-janin dan mencegah komplikasi persalinan akibat stres metabolik karena nyeri.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya mampu melakukan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pengkajian Nyeri dan Kenyamanan
	perkembangan sikap professional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	*skoring* nyeri, tetapi juga mampu mengevaluasi dampak nyeri terhadap keselamatan pasien secara menyeluruh dan mengambil keputusan klinis yang bertanggung jawab.

B. Ringkasan

Pengkajian nyeri dan kenyamanan merupakan komponen vital dalam asuhan kebidanan, terutama pada masa persalinan. Nyeri persalinan bersifat unik karena merupakan proses fisiologis, namun intensitasnya yang tinggi dapat memicu stres metabolik yang berdampak pada kondisi ibu dan janin. Penilaian nyeri tidak boleh hanya didasarkan pada asumsi bidan, melainkan harus dilakukan secara komprehensif menggunakan pendekatan PQRST (*Palliative/Provocative, Quality, Region, Severity, Time*) untuk mendapatkan gambaran yang akurat mengenai pengalaman subjektif pasien.

Skala nyeri seperti *Numeric Rating Scale* (NRS) atau *Wong-Baker FACES* digunakan untuk mengkuantifikasi rasa sakit, namun bidan harus tetap peka terhadap tanda klinis objektif. Respon simpatis akibat nyeri sering kali bermanifestasi pada peningkatan tekanan darah, takikardia (nadi cepat), pernapasan cepat (takipnea), serta perubahan perilaku seperti wajah meringis, gelisah, hingga kehilangan kontrol pernapasan. WHO menekankan bahwa asuhan yang bermartabat harus menghormati ambang nyeri setiap individu dan menyediakan dukungan kenyamanan baik farmakologis maupun non-farmakologis (seperti pijat *counter-pressure*, hidroterapi, atau teknik relaksasi).

Dokumentasi hasil pengkajian nyeri harus dilakukan secara sistematis dalam Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT). Pencatatan yang baik mencakup skor nyeri, lokasi, respon tanda vital, serta efektivitas intervensi yang telah diberikan. Bidan memiliki peran krusial dalam melakukan eskalasi tanpa tunda apabila ditemukan tanda bahaya (*red flags*), seperti nyeri patologis yang menetap di luar kontraksi atau nyeri hebat yang disertai gangguan denyut jantung janin (DJJ). Pengambilan keputusan yang cepat berdasarkan data pengkajian yang valid adalah kunci utama dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan ibu selama proses persalinan.

Alur asuhan singkat Ibu mengeluh nyeri/tidak nyaman → Lakukan pengkajian PQRST secara sistematis → Tentukan skor menggunakan skala nyeri (NRS/FACES) → Validasi dengan tanda klinis (TTV & perilaku) → Identifikasi adanya *red flags* → Lakukan intervensi kenyamanan → Evaluasi respon pasien → Dokumentasikan hasil dan rencana tindak lanjut secara akurat.

Tabel 3. 4 Red Flags & Eskalasi

Red flags	**Makna klinis**	**Tindakan eskalasi**
Skala nyeri menetap di angka 7 (NRS) meskipun sudah diberikan teknik relaksasi	Menunjukkan nyeri hebat yang mungkin bersifat patologis atau di luar ambang toleransi fisiologis ibu.	Lapor ke Pembimbing/DPJP, evaluasi ulang penyebab nyeri, pertimbangkan kolaborasi pemberian analgesik atau intervensi medis lainnya.
Nyeri abdomen bersifat menetap/kontinu (tidak hilang di antara kontraksi)	Curiga adanya komplikasi seperti solusio plasenta atau ancaman ruptur uteri (*Bandl's ring*).	Hentikan semua tindakan stimulasi, nilai cepat kondisi ibu dan janin, lapor segera, dan siapkan rujukan/tindakan emergensi.
Nadi ibu >100 x/menit (Takikardia) yang disertai tanda syok/pucat	Menunjukkan respon simpatis berlebih terhadap nyeri atau tanda awal syok neurogenik/hipovolemik.	Stabilisasi awal (posisi miring kiri, oksigenasi), pasang infus cairan kristaloid, pantau tanda vital ketat, dan panggil bantuan segera.
Skala nyeri tinggi (>7) disertai penurunan DJJ (<110 x/menit)	Menunjukkan stres maternal akibat nyeri yang berdampak pada gangguan sirkulasi uteroplasenta (gawat janin).	Lakukan resusitasi intrauterin (posisi, hidrasi), lapor segera, evaluasi kemajuan persalinan, dan percepat eskalasi rujukan.
Ibu tampak kehilangan kontrol, menjerit histeris, atau penurunan kesadaran	Menunjukkan keletihan mental/fisik yang ekstrem atau gangguan perfusi serebral.	Berikan dukungan emosional intensif, amankan lingkungan (cegah jatuh), nilai kesadaran, dan

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
		konsultasikan penanganan nyeri lebih lanjut.
Nyeri hebat pada area bekas luka operasi (Seksio Sesarea sebelumnya)	Curiga adanya dehisensi atau ruptur uteri pada jaringan parut lama.	Lakukan palpasi hati-hati pada segmen bawah rahim, lapor segera, puasakan pasien, dan siapkan tindakan bedah emergensi/rujukan.
Skala nyeri tidak sinkron dengan fase persalinan (misal: nyeri hebat pada pembukaan awal)	Kemungkinan adanya malposisi janin (seperti *occiput posterior*) atau ambang nyeri pasien yang sangat rendah.	Evaluasi ulang posisi janin, berikan edukasi dan dukungan mekanik (posisi tegak/miring), dan pantau kemajuan persalinan lebih ketat.
Dokumentasi menunjukkan kenaikan skala nyeri yang drastis dalam waktu singkat	Menunjukkan perubahan kondisi klinis yang cepat atau kemajuan persalinan yang sangat cepat (partus presipitatus).	Siapkan alat pertolongan persalinan, nilai ulang pembukaan serviks, dan pastikan pendampingan terus-menerus.
Keputusan manajemen nyeri sudah dibuat (misal: rujukan/epidural) tetapi tertunda	Meningkatkan risiko trauma psikologis bagi ibu dan stres pada janin.	Aktifkan rencana rujukan/tindakan tanpa tunda, lengkapi berkas dokumentasi (CPPT), dan komunikasikan secara jelas kepada keluarga.

Form Checklist

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian nyeri persalinan secara fisiologis dan psikologis	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menjelaskan mekanisme *gate control* dan dampaknya terhadap ambang nyeri	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa melakukan anamnesis nyeri secara sistematis menggunakan pendekatan PQRST	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa menentukan instrumen skala nyeri yang tepat (NRS/VDS/Wong-Baker) sesuai kondisi kognitif pasien	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa mengidentifikasi tanda klinis objektif dari respon simpatis terhadap nyeri (Nadi, TD, RR)	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa membedakan karakteristik nyeri persalinan normal dengan nyeri patologis	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa mengidentifikasi perilaku nyeri (meringis, gelisah, tegang) sebagai validasi data subjektif	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa mengenali tanda bahaya (*red flags*) yang menyertai nyeri hebat (misal: gawat janin atau tanda ruptur)	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa memberikan intervensi kenyamanan non-farmakologis awal (teknik napas/pijat) setelah pengkajian	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa mengevaluasi efektivitas tindakan kenyamanan melalui pengkajian nyeri ulang (re-assessment)	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa melakukan edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai cara mengungkapkan rasa nyeri	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
12	Saya sudah bisa menjelaskan hasil pengkajian nyeri kepada pasien dengan bahasa yang menenangkan	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa menentukan kapan tingkat nyeri pasien memerlukan kolaborasi medis atau pemberian analgesik	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa melaporkan (eskalasi) temuan nyeri yang abnormal kepada DPJP atau pembimbing secara sistematis	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa mendokumentasikan skor nyeri dan data PQRST ke dalam lembar CPPT/Rekam Medis secara tepat waktu	☐	☐	_____
16	Saya sudah bisa menjaga privasi, keselamatan, dan perilaku profesional selama tindakan	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

Referensi

Aitken, L. M., Marshall, A. P., & Chaboyer, W. (2023). *ACCCN's Critical Care Nursing* (5th ed.). Elsevier Health Sciences. (Membahas monitoring tanda klinis pada nyeri berat).

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2024). *Pharmacologic and Nonpharmacologic Pain Management in Labor*. Practice Bulletin No. 209 (Reaffirmed 2024).

Berman, A., Snyder, S. J., & Frandsen, G. (2021). *Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing: Concepts, Process, and Practice* (11th ed.). Pearson. (Sumber utama teori PQRST dan dokumentasi).

Bonica, J. J., & Rathmell, J. P. (2023). *Bonica's Management of Pain* (6th ed.). Lippincott Williams & Wilkins. (Referensi standar emas fisiologi nyeri).

D'Arcy, Y. (2022). *Pocket Guide to Pain Management*. Springer Publishing Company. (Fokus pada penggunaan skala nyeri NRS dan Wong-Baker).

Hani, U., Jiarti, C., & Kusuma, A. (2023). *Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta: EGC. (Implementasi pengkajian nyeri di lahan praktik).

International Association for the Study of Pain (IASP). (2021). *The Revised IASP Definition of Pain: Concepts and Implementation*. IASP Press.

Kemenkes RI. (2023). *Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK): Tata Laksana Nyeri*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Lowe, N. K., & Muirhead, R. J. (2022). The Nature and Management of Labor Pain. *Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing*, 51(3), 241-255.

Mander, R., & Marshall, J. E. (2023). *Pain in Childbirth: Linking Theory and Practice*. Routledge. (Integrasi kenyamanan dan keamanan pasien).

Nanayakkara, S., & Gynaecologists, R. C. O. O. (2024). *Non-pharmacological Pain Management in Labour*. Green-top Guideline.

Nystedt, A., & Hildingsson, I. (2022). Women's Experiences of Pain and Pain Management During Childbirth. *Sexual & Reproductive Healthcare*, 31, 100681.

Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2023). *Fundamentals of Nursing* (11th ed.). Elsevier. (Panduan terbaru dokumentasi keperawatan dan kebidanan).

PPNI. (2022). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI): Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan* (Edisi 1, Cetakan II). Jakarta: DPP PPNI.

Sarayani, A., dkk. (2023). Pengaruh Teknik Relaksasi Nafas Dalam terhadap Skala Nyeri Persalinan Kala I. *Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia*, 13(2).

Simkin, P., & Ancheta, R. (2023). *The Labor Progress Handbook: Early Interventions to Prevent and Treat Dystocia* (5th ed.). Wiley-Blackwell. (Kaitan nyeri dengan kemajuan persalinan).

Smith, C. A., dkk. (2021). Complementary and alternative therapies for pain management in labour. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (3).

Wahyuni, S., & Nurhayati. (2024). Akurasi Dokumentasi Skala Nyeri pada Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT). *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan*, 12(1).

World Health Organization. (2022). *WHO Labour Care Guide: User's Manual*. Geneva: WHO. (Panduan terbaru pemantauan nyeri dan kenyamanan dalam partograf).

Yuliawati, D., & Amelia, R. (2022). Hubungan Tanda Vital dengan Intensitas Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif. *Jurnal Kesehatan dan Kebidanan*, 11(2), 45-52.

BAB 4

DUKUNGAN EMOSIONAL DAN PENDAMPINGAN PERSALINAN: KOMUNIKASI, RELAKSASI, DAN KONTROL DIRI

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan sensitivitas budaya dalam pengelolaan nyeri dan kenyamanan persalinan.	CPMK-1; CPMK-3; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik, informed choice, dan kolaborasi dengan ibu, keluarga, dan tim kesehatan.	CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan keselamatan pasien, PPI, K3, dan manajemen risiko dalam intervensi manajemen nyeri persalinan.	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-4	Melakukan pengkajian komprehensif dan clinical reasoning berbasis data untuk menentukan rencana manajemen nyeri dan kenyamanan ibu–janin.	CPMK-1; CPMK-2; CPMK-3; CPMK-4; CPMK-7
CPL-5	Melaksanakan intervensi nonfarmakologi dan mendukung manajemen farmakologi dasar sesuai kewenangan secara aman dan bermutu.	CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-6	Melakukan edukasi, dokumentasi terstandar, dan pemanfaatan bukti ilmiah dasar untuk evaluasi hasil dan peningkatan mutu asuhan.	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Mengevaluasi prinsip, tujuan, dan aspek keselamatan manajemen nyeri persalinan yang berpusat pada ibu–janin.
CPMK-2	Menganalisis fisiologi nyeri persalinan (sumber, jalur, respons ibu–janin) sebagai dasar pemilihan intervensi dan pemantauan.
CPMK-3	Menganalisis faktor psikologis, sosial, budaya, dan pengalaman melahirkan serta implikasinya terhadap persepsi nyeri dan kenyamanan.
CPMK-4	Melaksanakan pengkajian nyeri/kenyamanan, interpretasi tanda klinis, serta pendokumentasian terstandar untuk pemantauan berkelanjutan.
CPMK-5	Merancang dan menerapkan strategi nonfarmakologi serta dukungan emosional dengan komunikasi terapeutik dan prinsip keamanan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-6	Mengintegrasikan farmakologi dasar analgesia persalinan dengan kolaborasi, pemantauan, dan kewaspadaan efek samping sesuai kewenangan.
CPMK-7	Menyusun rencana manajemen nyeri pada kondisi khusus, mengevaluasi hasil (kepuasan/outcome), dan merancang edukasi tindak lanjut berbasis bukti.

F. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 4. Dukungan Emosional dan Pendampingan Persalinan: Komunikasi, Relaksasi, dan Kontrol Diri	4.1 Menerapkan komunikasi terapeutik dan informed choice dalam dukungan emosional selama persalinan	4.2 Memfasilitasi peran pendamping serta strategi relaksasi/coping untuk meningkatkan kontrol diri ibu	CPMK-5	CPMK-3; CPMK-4

G. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-3	Analisis skenario + refleksi terstruktur	Mengidentifikasi faktor psikososial-budaya yang relevan; merumuskan pendekatan komunikasi yang sensitif dan realistis	10	Tugas refleksi & analisis skenario
CPMK-4	OSCE pengkajian + audit dokumentasi	Mengukur nyeri/kenyamanan dengan skala yang tepat dan konsisten; mencatat temuan–tindakan–respons lengkap dan kronologis	15	Checklist OSCE + lembar dokumentasi
CPMK-5	OSCE keterampilan nonfarmakologi (simulasi)	Melakukan coaching dukungan emosional/pernapasan/relaksasi; menerapkan teknik fisik/lingkungan dengan keamanan dan evaluasi respons	25	Checklist OSCE + catatan evaluasi respons

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Identifikasi tujuan dan prinsip keselamatan pada skenario	Tujuan tidak jelas/keliru; aspek keselamatan terabaikan	Tujuan cukup jelas; keselamatan disebut umum namun belum memprioritaskan risiko utama	Tujuan tepat; keselamatan diprioritaskan, ada kekurangan minor	Tujuan sangat tepat; keselamatan komprehensif, proaktif, berbasis risiko ibu–janin
1.2 Penetapan intervensi awal sesuai kondisi & kewenangan	Pilihan tidak sesuai kondisi/kewenangan; berpotensi tidak aman	Pilihan sebagian sesuai; mitigasi risiko/kontraindikasi belum lengkap	Pilihan sesuai; mitigasi risiko jelas, masih ada detail minor yang kurang	Pilihan paling sesuai; mitigasi risiko lengkap dan disertai alasan yang kuat

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Pemetaan sumber & jalur nyeri sesuai kala	Banyak konsep salah; tidak dapat mengaitkan dengan kala	Sebagian benar; masih ada kekeliruan pada pemetaan/urutan	Hampir seluruhnya benar; ada kekeliruan minor	Akurat dan lengkap; mampu mengaitkan pola nyeri dengan proses persalinan
2.2 Interpretasi respons ibu–janin dan implikasi pemantauan	Salah menafsir respons; rekomendasi pemantauan tidak tepat	Menafsir sebagian; rekomendasi pemantauan masih umum	Menafsir tepat; rekomendasi pemantauan relevan dan aman	Menafsir sangat tepat; rekomendasi pemantauan spesifik, antisipatif, dan rasional

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Identifikasi faktor psikologis–sosial–budaya	Faktor kunci tidak teridentifikasi; asumsi tidak berdasar	Faktor teridentifikasi sebagian; masih ada bias/kurang lengkap	Faktor teridentifikasi baik dan relevan; bias minimal	Faktor lengkap, relevan, dan berimbang; menunjukkan sensitivitas budaya yang kuat
3.2 Rekomendasi pendekatan	Pendekatan tidak sesuai; berpotensi	Pendekatan cukup sesuai namun generik; kurang	Pendekatan sesuai; menyesuaikan	Pendekatan sangat sesuai; empatik, trauma-informed,

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
komunikasi & dukungan	meningkatkan distres	menyesuaikan konteks ibu	konteks dan mendukung coping	dan memfasilitasi kontrol diri ibu

Rubrik CPMK-4

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Pengukuran nyeri/kenyamanan (pemilihan skala & konsistensi)	Skala/teknik tidak tepat; pengukuran tidak konsisten	Skala cukup tepat; konsistensi dan waktu pengukuran belum optimal	Skala tepat; pengukuran konsisten sesuai kebutuhan pemantauan	Skala sangat tepat; pengukuran konsisten, responsif terhadap perubahan kondisi
4.2 Dokumentasi temuan–tindakan–respons	Catatan tidak lengkap/tidak runtut; sulit ditindaklanjuti	Catatan cukup lengkap; masih ada bagian penting yang hilang	Catatan lengkap dan runtut; mudah ditelusuri	Catatan sangat lengkap, jelas, standar; mendukung pengambilan keputusan dan continuity of care

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Coaching dukungan emosional/pernapasan/relaksasi	Komunikasi tidak terapeutik; instruksi tidak dipahami; tidak aman	Komunikasi cukup; instruksi dipahami sebagian; perlu banyak arahan	Komunikasi terapeutik; instruksi jelas; aman dengan koreksi minor	Komunikasi sangat efektif; memberdayakan ibu & pendamping; aman dan adaptif
5.2 Implementasi teknik fisik/lingkungan & evaluasi respons	Teknik tidak sesuai/berisiko; tidak mengevaluasi respons	Teknik cukup sesuai; evaluasi respons minim/umum	Teknik sesuai dan aman; evaluasi respons jelas dan berkelanjutan	Teknik sangat tepat; evaluasi respons terukur, adaptasi cepat, dan berorientasi kenyamanan

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Kesesuaian pemilihan analgesia dasar & identifikasi risiko	Pilihan tidak sesuai indikasi; risiko/kontraindikasi terlewat	Pilihan cukup sesuai; risiko/kontraindikasi disebut sebagian	Pilihan sesuai; risiko/kontraindikasi utama teridentifikasi	Pilihan paling sesuai; risiko/kontraindikasi lengkap dan disertai pertimbangan rasional
6.2 Pemantauan, tindak lanjut efek samping, dan komunikasi kolaboratif	Tidak memantau parameter kunci; tindak lanjut tidak tepat	Memantau sebagian; tindak lanjut dan komunikasi masih kurang terstruktur	Pemantauan tepat; tindak lanjut aman; komunikasi kolaboratif jelas	Pemantauan komprehensif; tindak lanjut antisipatif; komunikasi kolaboratif sangat efektif dan terdokumentasi

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Perencanaan manajemen nyeri pada kondisi khusus (prioritas, integrasi, eskalasi)	Rencana tidak sesuai risiko; prioritas/eskalasi tidak jelas	Rencana cukup sesuai; integrasi modalitas dan eskalasi belum mantap	Rencana sesuai; prioritas jelas; integrasi dan eskalasi aman	Rencana sangat kuat; prioritas tajam; integrasi komprehensif; eskalasi/rujukan tepat waktu dan berbasis risiko
7.2 Evaluasi hasil & rencana edukasi tindak lanjut	Tidak menetapkan indikator; edukasi tidak relevan/tidak dapat diterapkan	Indikator ada namun terbatas; edukasi umum	Indikator relevan; edukasi jelas dan dapat diterapkan	Indikator lengkap dan terukur; edukasi sangat personal, realistis, mendukung coping dan rencana lanjutan

A. Pendahuluan

Persalinan merupakan proses fisiologis yang kompleks dan melibatkan interaksi antara faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya. Meskipun secara fisiologis persalinan merupakan proses alami dalam kehidupan seorang perempuan, pengalaman persalinan dapat menjadi peristiwa yang penuh tantangan baik secara fisik maupun emosional. Salah satu aspek yang paling dominan dalam pengalaman persalinan adalah persepsi nyeri yang muncul akibat kontraksi uterus, dilatasi serviks, serta tekanan pada jaringan panggul. Namun demikian, intensitas nyeri yang

dirasakan oleh setiap perempuan tidak selalu sama karena sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal.

Dukungan emosional dalam persalinan merupakan bentuk intervensi nonfarmakologis yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan psikologis ibu. Dukungan ini dapat diberikan oleh bidan, tenaga kesehatan lainnya, maupun pendamping persalinan seperti suami atau anggota keluarga. Kehadiran pendamping yang memberikan dorongan emosional, membantu ibu mengatasi kontraksi, serta memberikan rasa aman terbukti dapat meningkatkan kenyamanan ibu selama proses persalinan.

Komunikasi terapeutik merupakan salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki oleh bidan dalam memberikan dukungan emosional kepada ibu bersalin. Melalui komunikasi yang empatik, terbuka, dan menghargai pilihan ibu, bidan dapat membangun hubungan yang saling percaya sehingga ibu merasa lebih nyaman dan mampu berpartisipasi aktif dalam proses persalinan.

Selain komunikasi terapeutik, strategi relaksasi dan teknik coping juga berperan penting dalam membantu ibu mengelola nyeri persalinan. Teknik pernapasan, relaksasi otot, visualisasi, serta sentuhan terapeutik merupakan beberapa metode nonfarmakologis yang sering digunakan untuk membantu ibu menghadapi kontraksi persalinan. Strategi ini bertujuan untuk membantu ibu mempertahankan kontrol diri, mengurangi ketegangan otot, serta meningkatkan rasa percaya diri dalam menghadapi proses melahirkan.

Pendampingan persalinan juga menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi pengalaman melahirkan seorang perempuan. Kehadiran pendamping yang memberikan dukungan emosional, bantuan fisik, dan motivasi dapat membantu ibu merasa lebih tenang dan aman selama proses persalinan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang didampingi selama persalinan cenderung memiliki durasi persalinan yang lebih singkat, kebutuhan intervensi medis yang lebih rendah, serta tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap pengalaman melahirkan.

Dalam praktik kebidanan, bidan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap perempuan mendapatkan dukungan emosional yang memadai selama proses persalinan. Hal ini meliputi kemampuan untuk melakukan pengkajian kebutuhan emosional ibu, memberikan informasi yang jelas melalui prinsip *informed choice*, memfasilitasi keterlibatan pendamping persalinan, serta menerapkan berbagai strategi relaksasi untuk meningkatkan kenyamanan ibu. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi nyeri persalinan, tetapi juga untuk menciptakan pengalaman melahirkan yang positif dan bermakna bagi perempuan.

B. Faktor Psikologis, Sosial, dan Budaya dalam Persepsi Nyeri Persalinan

Persepsi nyeri persalinan merupakan pengalaman subjektif yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya faktor fisiologis tetapi juga faktor psikologis, sosial, dan budaya. Pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut sangat penting bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, karena dapat membantu dalam memberikan asuhan kebidanan yang lebih efektif dan berpusat pada kebutuhan perempuan.

Faktor psikologis merupakan salah satu determinan utama dalam pengalaman nyeri persalinan. Kondisi emosional ibu, seperti kecemasan, ketakutan, dan stres, dapat memengaruhi cara ibu merasakan dan mengekspresikan nyeri. Ketika seorang perempuan mengalami kecemasan yang tinggi, tubuh akan melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan katekolamin. Peningkatan hormon ini dapat menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah dan peningkatan ketegangan otot, yang pada akhirnya dapat memperkuat persepsi nyeri serta menghambat kemajuan persalinan.

Selain kecemasan, pengalaman persalinan sebelumnya juga dapat memengaruhi persepsi nyeri pada persalinan berikutnya. Perempuan yang memiliki pengalaman persalinan traumatis cenderung memiliki tingkat ketakutan yang lebih tinggi terhadap proses persalinan. Sebaliknya, perempuan yang memiliki pengalaman persalinan positif biasanya memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam menghadapi proses persalinan berikutnya. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan untuk memberikan dukungan emosional yang memadai serta membantu ibu membangun persepsi positif terhadap proses persalinan.

Faktor sosial juga memiliki peran penting dalam memengaruhi pengalaman nyeri persalinan. Dukungan sosial yang berasal dari pasangan, keluarga, maupun tenaga kesehatan dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan rasa aman bagi ibu. Kehadiran pendamping persalinan, misalnya, dapat memberikan rasa nyaman serta membantu ibu menghadapi kontraksi dengan lebih tenang. Dukungan sosial juga dapat meningkatkan rasa percaya diri ibu serta membantu ibu merasa lebih dihargai selama proses persalinan.

Selain itu, hubungan interpersonal antara ibu dan tenaga kesehatan juga dapat memengaruhi persepsi nyeri persalinan. Komunikasi yang baik, empati, serta sikap menghargai pilihan ibu dapat membantu membangun hubungan saling percaya antara ibu dan bidan. Hubungan yang positif ini dapat membantu ibu merasa lebih aman dan nyaman selama proses persalinan, sehingga dapat mengurangi persepsi nyeri yang dirasakan.

Faktor budaya juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam cara perempuan memahami dan mengekspresikan nyeri persalinan. Setiap budaya memiliki nilai,

norma, dan kepercayaan yang berbeda mengenai proses melahirkan. Dalam beberapa budaya, ekspresi nyeri dianggap sebagai hal yang wajar dan dapat diekspresikan secara terbuka. Namun dalam budaya lain, perempuan mungkin diharapkan untuk menahan atau menyembunyikan rasa nyeri sebagai bentuk kekuatan atau ketahanan.

Selain itu, budaya juga memengaruhi praktik-praktik tradisional yang berkaitan dengan persalinan, seperti penggunaan ramuan herbal, teknik pijatan tradisional, atau ritual tertentu yang diyakini dapat membantu proses persalinan. Tenaga kesehatan perlu memahami dan menghargai praktik-praktik budaya tersebut selama tidak membahayakan kesehatan ibu dan bayi. Pendekatan yang sensitif terhadap budaya dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih baik antara tenaga kesehatan dan ibu, serta meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan.

Dengan memahami berbagai faktor psikologis, sosial, dan budaya yang memengaruhi persepsi nyeri persalinan, bidan dapat memberikan asuhan yang lebih holistik dan berpusat pada kebutuhan perempuan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi nyeri, tetapi juga untuk meningkatkan kenyamanan, rasa percaya diri, serta pengalaman persalinan yang positif bagi setiap perempuan.

C. Dukungan Emosional dalam Persalinan

Dukungan emosional merupakan salah satu komponen penting dalam asuhan kebidanan selama proses persalinan. Persalinan tidak hanya melibatkan proses fisiologis berupa kontraksi uterus, pembukaan serviks, dan kelahiran bayi, tetapi juga merupakan pengalaman psikologis dan emosional yang sangat bermakna bagi seorang perempuan. Oleh karena itu, pendekatan asuhan kebidanan modern menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan emosional ibu sebagai bagian integral dari pelayanan yang berpusat pada perempuan (*woman-centered care*).

Selama proses persalinan, perempuan sering mengalami berbagai perubahan emosional yang dipengaruhi oleh rasa nyeri, kecemasan, ketakutan, serta ketidakpastian terhadap hasil persalinan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi cara ibu menghadapi kontraksi serta kemampuan ibu dalam mempertahankan kontrol diri. Jika kebutuhan emosional ibu tidak terpenuhi, kecemasan dapat meningkat dan memperburuk persepsi nyeri yang dirasakan. Sebaliknya, dukungan emosional yang adekuat dapat membantu ibu merasa lebih tenang, aman, dan percaya diri dalam menghadapi proses persalinan.

Dukungan emosional dalam persalinan dapat diberikan oleh berbagai pihak, termasuk bidan, tenaga kesehatan lainnya, serta pendamping persalinan seperti suami atau anggota keluarga. Kehadiran individu yang memberikan perhatian,

empati, dan dorongan positif dapat memberikan rasa nyaman serta meningkatkan kepercayaan diri ibu selama proses persalinan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang mendapatkan dukungan emosional secara kontinu selama persalinan cenderung memiliki pengalaman melahirkan yang lebih positif dibandingkan dengan mereka yang tidak mendapatkan dukungan tersebut.

Salah satu tujuan utama dari dukungan emosional adalah mengurangi tingkat kecemasan dan ketakutan yang dialami ibu. Kecemasan dapat memicu peningkatan hormon stres seperti katekolamin yang dapat menyebabkan ketegangan otot dan penurunan aliran darah ke uterus. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan persepsi nyeri tetapi juga dapat mempengaruhi kemajuan persalinan. Dengan adanya dukungan emosional yang memadai, ibu dapat merasa lebih rileks sehingga tubuh mampu merespons kontraksi secara lebih adaptif.

Bentuk dukungan emosional yang diberikan kepada ibu bersalin dapat berupa berbagai tindakan sederhana namun bermakna. Salah satunya adalah kehadiran yang penuh perhatian (*continuous presence*). Kehadiran bidan atau pendamping yang selalu berada di dekat ibu selama proses persalinan dapat memberikan rasa aman dan mengurangi perasaan kesepian yang mungkin dirasakan oleh ibu. Dalam situasi persalinan, perasaan tidak sendirian sering kali memberikan kekuatan psikologis yang besar bagi ibu.

Bentuk dukungan emosional lainnya adalah pemberian penguatan positif (*positive reinforcement*). Penguatan positif dapat diberikan melalui kata-kata motivasi yang mendorong ibu untuk tetap tenang dan fokus selama menghadapi kontraksi. Kalimat sederhana seperti "Ibu sudah melakukan dengan sangat baik", "Tarik napas perlahan, kontraksi ini akan segera berlalu", atau "Tubuh ibu sedang bekerja dengan baik untuk melahirkan bayi" dapat memberikan dampak psikologis yang signifikan bagi ibu. Penguatan positif membantu ibu merasa dihargai serta meningkatkan semangat dalam menghadapi proses persalinan.

Memberikan informasi yang jelas mengenai kemajuan persalinan juga merupakan bagian penting dari dukungan emosional. Ketidakpastian sering kali menjadi sumber kecemasan bagi ibu bersalin. Dengan memberikan penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami mengenai apa yang sedang terjadi selama persalinan, bidan dapat membantu ibu merasa lebih tenang dan mampu mempersiapkan diri menghadapi tahapan berikutnya. Informasi yang jelas juga membantu ibu merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan selama persalinan.

Lingkungan persalinan juga berperan dalam mendukung kenyamanan emosional ibu. Ruang bersalin yang tenang, pencahayaan yang nyaman, serta suasana yang mendukung privasi dapat membantu ibu merasa lebih rileks. Bidan

perlu berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung kenyamanan ibu, misalnya dengan membatasi gangguan yang tidak perlu, memberikan kesempatan kepada ibu untuk memilih posisi yang nyaman, serta menghargai kebutuhan privasi selama persalinan.

Penelitian menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan oleh pendamping persalinan dapat memberikan berbagai manfaat, seperti menurunkan tingkat kecemasan ibu, memperpendek durasi persalinan, serta mengurangi kebutuhan intervensi medis seperti analgesia atau tindakan operatif. Selain itu, pengalaman melahirkan yang didampingi oleh pasangan sering kali memberikan kesan yang lebih positif bagi ibu maupun keluarga.

Dalam praktik kebidanan, bidan memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi keterlibatan pendamping persalinan secara optimal. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan edukasi kepada pendamping mengenai cara memberikan dukungan kepada ibu, seperti membantu ibu melakukan teknik relaksasi, memberikan pijatan ringan, atau memberikan dorongan emosional selama kontraksi. Dengan melibatkan pendamping secara aktif, proses persalinan dapat menjadi pengalaman yang lebih bermakna bagi ibu dan keluarga.

Dukungan emosional yang efektif memerlukan keterampilan interpersonal yang baik dari tenaga kesehatan. Bidan perlu memiliki kemampuan untuk mendengarkan secara aktif, menunjukkan empati, serta menghargai perasaan dan kebutuhan ibu. Pendekatan yang humanistik dan penuh empati akan membantu menciptakan hubungan yang positif antara bidan dan ibu, sehingga ibu merasa lebih nyaman dalam mengungkapkan perasaan maupun kekhawatirannya selama persalinan.

D. Komunikasi terapeutik dalam asuhan persalinan

Komunikasi terapeutik merupakan salah satu keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien, termasuk dalam asuhan kebidanan selama proses persalinan. Dalam konteks persalinan, komunikasi terapeutik berfungsi sebagai sarana untuk membangun hubungan saling percaya antara bidan dan ibu bersalin, membantu ibu mengatasi kecemasan, serta memberikan dukungan emosional yang diperlukan selama proses melahirkan. Melalui komunikasi yang efektif dan empatik, bidan dapat membantu ibu merasa lebih tenang, aman, serta mampu menghadapi proses persalinan dengan lebih percaya diri.

Persalinan sering kali menjadi pengalaman yang penuh dengan ketidakpastian bagi seorang perempuan, terutama bagi ibu yang pertama kali melahirkan. Rasa

takut terhadap nyeri kontraksi, kekhawatiran terhadap keselamatan bayi, serta lingkungan yang baru dapat meningkatkan kecemasan ibu selama persalinan. Dalam situasi ini, komunikasi terapeutik berperan penting dalam membantu ibu memahami proses yang sedang terjadi serta memberikan dukungan psikologis yang dapat mengurangi ketegangan emosional. Komunikasi yang baik tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menunjukkan empati, perhatian, dan penghargaan terhadap perasaan ibu.

Komunikasi terapeutik dalam praktik kebidanan memiliki tujuan untuk membantu ibu mengekspresikan perasaan, meningkatkan rasa percaya diri, serta memperkuat kemampuan ibu dalam menghadapi proses persalinan. Selain itu, komunikasi yang efektif juga dapat meningkatkan kualitas hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien, sehingga proses asuhan kebidanan dapat berlangsung secara lebih optimal. Dalam pelayanan persalinan yang berpusat pada perempuan (*woman-centered care*), komunikasi terapeutik menjadi salah satu elemen penting yang mendukung terciptanya pengalaman persalinan yang positif.

Kejujuran dan keterbukaan juga merupakan prinsip penting dalam komunikasi terapeutik. Ibu bersalin berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai kondisi dirinya maupun kondisi janin. Informasi tersebut dapat mencakup kemajuan persalinan, prosedur pemeriksaan yang dilakukan, serta kemungkinan intervensi yang diperlukan. Penyampaian informasi yang jelas dan jujur dapat membantu ibu memahami situasi yang sedang terjadi sehingga mengurangi rasa cemas yang disebabkan oleh ketidakpastian.

Komunikasi terapeutik juga harus menghargai pilihan dan keputusan ibu selama proses persalinan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *informed choice* dalam pelayanan kebidanan, di mana ibu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perawatan dirinya. Bidan perlu memberikan informasi mengenai berbagai pilihan yang tersedia serta menjelaskan manfaat dan risiko dari setiap pilihan tersebut. Dengan demikian, ibu dapat membuat keputusan yang sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan preferensinya.

Dalam praktik kebidanan, komunikasi terapeutik biasanya berlangsung melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah tahap orientasi, yaitu tahap awal ketika bidan pertama kali berinteraksi dengan ibu. Pada tahap ini, bidan memperkenalkan diri, menjelaskan perannya, serta membangun hubungan saling percaya dengan ibu dan keluarganya. Pendekatan yang ramah dan penuh perhatian pada tahap ini sangat penting untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi ibu selama proses persalinan.

Tahap berikutnya adalah tahap kerja, yaitu tahap di mana bidan dan ibu bekerja sama untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul selama persalinan.

Pada tahap ini, komunikasi terapeutik digunakan untuk memberikan dukungan emosional, membantu ibu mengelola nyeri kontraksi, serta memberikan informasi mengenai perkembangan persalinan. Bidan dapat menggunakan berbagai teknik komunikasi, seperti memberikan penguatan positif, memberikan instruksi mengenai teknik pernapasan, atau membantu ibu menemukan posisi yang nyaman selama kontraksi.

Tahap terakhir adalah tahap terminasi, yaitu tahap ketika proses persalinan telah selesai atau ketika interaksi antara bidan dan ibu akan berakhir. Pada tahap ini, bidan dapat memberikan dukungan emosional kepada ibu setelah kelahiran bayi, memberikan apresiasi atas usaha yang telah dilakukan oleh ibu selama proses persalinan, serta memberikan informasi mengenai perawatan pascapersalinan. Tahap ini juga penting untuk membantu ibu memproses pengalaman persalinan yang baru saja dialaminya.

Selain komunikasi verbal, komunikasi nonverbal juga memiliki peran penting dalam asuhan persalinan. Bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, serta sentuhan dapat menyampaikan pesan yang kuat kepada ibu. Misalnya, sentuhan lembut pada bahu atau tangan ibu dapat memberikan rasa nyaman dan menunjukkan bahwa bidan hadir untuk mendukungnya. Demikian pula, kontak mata yang hangat dapat memperkuat hubungan emosional antara bidan dan ibu.

E. Informed choice dalam pelayanan kebidanan

Informed choice merupakan konsep penting dalam pelayanan kesehatan modern yang menekankan hak pasien untuk memperoleh informasi yang lengkap dan jelas sebelum membuat keputusan terkait perawatan yang akan diterima. Dalam praktik kebidanan, konsep ini memiliki peran yang sangat penting karena pelayanan kebidanan tidak hanya berfokus pada keselamatan ibu dan bayi, tetapi juga menghargai hak perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan tubuh dan proses reproduksinya. Oleh karena itu, penerapan informed choice menjadi bagian integral dari pelayanan kebidanan yang berpusat pada perempuan (*woman-centered care*).

Pada dasarnya, informed choice adalah proses di mana seorang perempuan menerima informasi yang memadai mengenai kondisi kesehatannya, pilihan tindakan yang tersedia, manfaat dan risiko dari setiap pilihan, serta konsekuensi yang mungkin terjadi. Setelah memperoleh informasi tersebut, perempuan diberikan kesempatan untuk mempertimbangkan berbagai pilihan dan membuat keputusan yang paling sesuai dengan nilai, kebutuhan, serta preferensinya. Proses ini menempatkan perempuan sebagai individu yang memiliki otonomi terhadap

tubuhnya sendiri dan berhak menentukan pilihan terkait pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Dalam konteks persalinan, informed choice sangat penting karena proses melahirkan sering kali melibatkan berbagai keputusan klinis yang perlu dipertimbangkan secara matang. Misalnya, keputusan mengenai metode manajemen nyeri, posisi persalinan, penggunaan intervensi medis tertentu, atau kehadiran pendamping persalinan. Tanpa informasi yang memadai, ibu mungkin merasa tidak memiliki kendali atas proses persalinan yang dialaminya. Sebaliknya, ketika ibu diberikan informasi yang jelas dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, ia cenderung merasa lebih percaya diri dan memiliki pengalaman persalinan yang lebih positif.

Penerapan informed choice dalam pelayanan kebidanan juga berkaitan erat dengan prinsip etika dalam praktik kesehatan, khususnya prinsip otonomi (*autonomy*). Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan pilihan terkait kesehatan dirinya sendiri tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Dalam praktik kebidanan, bidan memiliki tanggung jawab untuk menghormati keputusan yang diambil oleh ibu, selama keputusan tersebut tidak membahayakan keselamatan ibu dan bayi.

Agar informed choice dapat diterapkan secara efektif, tenaga kesehatan perlu memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada ibu bersalin disampaikan secara jelas, jujur, dan mudah dipahami. Informasi tersebut harus mencakup beberapa aspek penting, seperti penjelasan mengenai kondisi kesehatan ibu dan janin, tujuan dari tindakan atau prosedur yang akan dilakukan, manfaat yang diharapkan, serta risiko atau efek samping yang mungkin terjadi. Selain itu, ibu juga perlu diberi penjelasan mengenai alternatif tindakan yang tersedia, termasuk kemungkinan jika tindakan tersebut tidak dilakukan.

Penyampaian informasi dalam proses informed choice harus dilakukan melalui komunikasi yang efektif dan empatik. Bidan perlu menggunakan bahasa yang sederhana serta menghindari penggunaan istilah medis yang sulit dipahami oleh ibu. Selain itu, bidan juga perlu memberikan kesempatan kepada ibu untuk mengajukan pertanyaan serta mengekspresikan kekhawatiran atau keraguan yang mungkin dimilikinya. Dengan demikian, proses komunikasi menjadi lebih interaktif dan memungkinkan ibu untuk benar-benar memahami informasi yang diberikan.

Dalam praktiknya, informed choice tidak hanya sebatas pemberian informasi, tetapi juga melibatkan proses pengambilan keputusan bersama antara tenaga kesehatan dan ibu. Pendekatan ini sering disebut sebagai *shared decision making*, yaitu proses kolaboratif di mana tenaga kesehatan memberikan rekomendasi berdasarkan pengetahuan klinis, sementara ibu mempertimbangkan pilihan

tersebut berdasarkan nilai dan preferensinya. Pendekatan ini membantu menciptakan hubungan kemitraan antara bidan dan ibu dalam proses pelayanan kebidanan.

Penerapan informed choice dalam persalinan juga memiliki berbagai manfaat bagi ibu maupun tenaga kesehatan. Bagi ibu, informed choice dapat meningkatkan rasa percaya diri, mengurangi kecemasan, serta memberikan rasa kontrol terhadap proses persalinan yang dialaminya. Ketika ibu merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan, ia cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap pengalaman melahirkan. Selain itu, pemahaman yang baik mengenai proses persalinan juga dapat membantu ibu mempersiapkan diri secara mental dan emosional.

Latar belakang budaya juga dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam persalinan. Dalam beberapa budaya, keputusan terkait pelayanan kesehatan sering kali melibatkan anggota keluarga, terutama suami atau orang tua. Dalam situasi seperti ini, bidan perlu menghargai nilai budaya yang berlaku sekaligus memastikan bahwa ibu tetap memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan preferensinya. Pendekatan yang sensitif terhadap budaya dapat membantu menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan menghargai nilai-nilai yang dimiliki oleh keluarga.

Dalam praktik kebidanan di fasilitas kesehatan, penerapan informed choice juga perlu didukung oleh sistem dokumentasi yang baik. Setiap informasi yang diberikan kepada ibu serta keputusan yang diambil perlu dicatat secara jelas dalam rekam medis. Dokumentasi ini tidak hanya penting untuk memastikan kesinambungan pelayanan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan apabila terjadi perbedaan persepsi di kemudian hari.

F. Peran Pendamping Persalinan

Pendamping persalinan merupakan individu yang memberikan dukungan kepada ibu selama proses persalinan berlangsung. Pendamping dapat berupa suami, anggota keluarga, sahabat, atau tenaga pendukung persalinan yang dipercaya oleh ibu. Kehadiran pendamping selama persalinan menjadi salah satu bentuk dukungan sosial yang penting karena dapat memberikan rasa aman, nyaman, serta meningkatkan kepercayaan diri ibu dalam menghadapi proses melahirkan.

Persalinan sering kali menimbulkan berbagai reaksi emosional seperti kecemasan, ketakutan, atau perasaan tidak pasti terhadap proses yang akan dilalui. Dalam kondisi tersebut, keberadaan seseorang yang memberikan dukungan

emosional dapat membantu ibu merasa lebih tenang. Pendamping yang memberikan perhatian, empati, dan dorongan positif dapat membantu mengurangi stres serta meningkatkan kemampuan ibu dalam mengatasi nyeri kontraksi. Dukungan ini juga dapat membantu ibu mempertahankan kontrol diri selama proses persalinan.

Pendamping persalinan memiliki beberapa peran penting dalam mendukung kenyamanan ibu. Salah satu peran utama adalah memberikan dukungan emosional berupa motivasi dan penguatan positif. Kata-kata yang menenangkan dan memberikan semangat dapat membantu ibu tetap fokus selama menghadapi kontraksi. Dukungan emosional yang konsisten dapat meningkatkan rasa percaya diri ibu serta membantu ibu menghadapi persalinan dengan lebih tenang.

Penelitian menunjukkan bahwa kehadiran pendamping persalinan secara kontinu memiliki berbagai manfaat bagi ibu dan bayi. Beberapa manfaat tersebut antara lain menurunkan tingkat kecemasan ibu, memperpendek durasi persalinan, mengurangi kebutuhan intervensi medis, serta meningkatkan kepuasan ibu terhadap pengalaman melahirkan. Selain itu, kehadiran pendamping juga dapat memperkuat hubungan emosional antara ibu dan keluarga, khususnya antara ibu dan pasangan.

Dalam praktik kebidanan, bidan memiliki peran penting dalam memfasilitasi keterlibatan pendamping persalinan. Bidan dapat memberikan edukasi kepada pendamping mengenai cara memberikan dukungan yang efektif kepada ibu selama persalinan. Edukasi ini dapat mencakup teknik pernapasan, cara memberikan pijatan ringan, serta cara memberikan dukungan emosional yang tepat. Dengan pemahaman yang baik, pendamping dapat berperan secara optimal dalam membantu ibu menghadapi proses persalinan.

G. Strategi Relaksasi dan Coping dalam Persalinan

Strategi relaksasi dan coping merupakan pendekatan nonfarmakologis yang bertujuan membantu ibu mengelola nyeri dan ketidaknyamanan selama persalinan. Persalinan merupakan proses fisiologis yang sering disertai dengan nyeri akibat kontraksi uterus, dilatasi serviks, serta tekanan pada jaringan panggul. Meskipun nyeri merupakan bagian alami dari proses persalinan, kemampuan ibu dalam mengelola nyeri sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis serta strategi coping yang digunakan.

Relaksasi merupakan keadaan di mana tubuh dan pikiran berada dalam kondisi tenang dan bebas dari ketegangan. Teknik relaksasi dalam persalinan bertujuan untuk mengurangi ketegangan otot, menurunkan tingkat kecemasan, serta

membantu ibu mempertahankan kontrol diri selama menghadapi kontraksi. Ketika tubuh berada dalam keadaan rileks, respons terhadap nyeri dapat berkurang sehingga ibu mampu menghadapi kontraksi dengan lebih baik.

Salah satu teknik relaksasi yang sering digunakan dalam persalinan adalah teknik pernapasan. Teknik ini melibatkan pengaturan pola napas secara teratur dan ritmis selama kontraksi berlangsung. Pernapasan yang dalam dan terkontrol dapat membantu meningkatkan oksigenasi serta mengurangi ketegangan otot. Selain itu, fokus pada pola pernapasan juga dapat membantu mengalihkan perhatian ibu dari rasa nyeri yang dirasakan.

Teknik visualisasi juga dapat digunakan sebagai strategi coping dalam persalinan. Visualisasi melibatkan penggunaan imajinasi untuk membayangkan situasi atau tempat yang menenangkan, seperti pemandangan alam atau suasana yang memberikan rasa nyaman. Teknik ini dapat membantu ibu mengalihkan perhatian dari nyeri kontraksi serta menciptakan perasaan tenang selama persalinan.

Sentuhan terapeutik dan pijatan juga merupakan metode relaksasi yang sering digunakan dalam persalinan. Pijatan ringan pada punggung bawah atau daerah sakrum dapat membantu mengurangi rasa nyeri yang disebabkan oleh tekanan pada saraf selama kontraksi. Selain memberikan efek relaksasi fisik, sentuhan juga dapat meningkatkan perasaan diperhatikan dan didukung secara emosional.

Strategi coping dalam persalinan tidak hanya berkaitan dengan teknik relaksasi fisik, tetapi juga melibatkan dukungan emosional dan psikologis. Dukungan dari bidan maupun pendamping persalinan dapat membantu ibu merasa lebih percaya diri dalam menghadapi kontraksi. Penguatan positif, motivasi, serta komunikasi yang menenangkan dapat meningkatkan kemampuan ibu dalam mengelola nyeri persalinan.

H. Pendokumentasian Asuhan Nyeri Persalinan

Pendokumentasian merupakan bagian penting dalam praktik kebidanan karena berfungsi sebagai catatan resmi mengenai asuhan yang diberikan kepada pasien. Dalam konteks persalinan, pendokumentasian asuhan nyeri sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengkajian, intervensi, serta evaluasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tercatat secara sistematis dan dapat digunakan sebagai dasar pemantauan berkelanjutan.

Pendokumentasian asuhan nyeri persalinan dimulai dengan pencatatan hasil pengkajian nyeri yang dilakukan pada ibu. Informasi yang dicatat meliputi intensitas nyeri yang dirasakan ibu, lokasi nyeri, durasi kontraksi, serta respons ibu terhadap kontraksi. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara langsung dengan ibu

maupun melalui observasi terhadap tanda-tanda nonverbal yang menunjukkan ketidaknyamanan.

Pendokumentasian juga mencakup evaluasi terhadap respons ibu terhadap intervensi yang diberikan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas tindakan yang telah dilakukan serta menentukan apakah intervensi tersebut perlu dilanjutkan, dimodifikasi, atau diganti dengan pendekatan lain. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, tenaga kesehatan dapat memastikan bahwa kebutuhan kenyamanan ibu tetap terpenuhi selama proses persalinan.

Dalam praktik kebidanan, pendokumentasian asuhan persalinan sering dilakukan menggunakan partograf atau catatan asuhan kebidanan. Partograf merupakan alat pemantauan yang digunakan untuk mencatat kemajuan persalinan serta kondisi ibu dan janin secara sistematis. Informasi mengenai nyeri, respons ibu terhadap kontraksi, serta intervensi yang dilakukan dapat dicatat sebagai bagian dari pemantauan kondisi ibu selama persalinan.

Pendokumentasian yang lengkap dan akurat memiliki berbagai manfaat dalam pelayanan kebidanan. Selain membantu memastikan kesinambungan asuhan, dokumentasi juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar tenaga kesehatan yang terlibat dalam perawatan ibu. Catatan yang jelas memungkinkan tenaga kesehatan lain untuk memahami kondisi ibu serta tindakan yang telah dilakukan sebelumnya.

Selain itu, dokumentasi juga memiliki nilai penting dari aspek hukum dan profesional. Catatan yang lengkap dapat menjadi bukti bahwa tenaga kesehatan telah memberikan pelayanan sesuai dengan standar praktik yang berlaku. Oleh karena itu, bidan perlu memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan selama proses persalinan didokumentasikan secara jelas, akurat, dan tepat waktu.

Aktivitas 1 — *Knows How*
Mini-Case Tertulis (Diskusi Kelompok)

Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti aktivitas ini, mahasiswa mampu:
1. Menganalisis faktor psikologis, sosial, dan budaya yang memengaruhi persepsi nyeri persalinan.
2. Menerapkan komunikasi terapeutik dalam memberikan dukungan emosional.
3. Merancang strategi relaksasi dan coping yang sesuai dengan kondisi ibu.
4. Memfasilitasi peran pendamping persalinan secara optimal.

Kasus
Seorang perempuan usia 23 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke ruang bersalin dengan keluhan kontraksi sejak 8 jam yang lalu. Ibu tampak gelisah, sering menggenggam perut saat kontraksi, dan mengatakan "Saya takut tidak kuat menahan sakitnya."
Hasil pemeriksaan: tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 92 kali/menit, suhu 36,8°C, pernapasan 22 kali/menit. Kontraksi 3–4 kali dalam 10 menit dengan durasi 40–45 detik. Pembukaan serviks 5 cm.
Suami ibu berada di sampingnya, namun terlihat bingung dan hanya diam tanpa memberikan dukungan.

Pertanyaan Diskusi
1. Identifikasi faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi kondisi ibu pada kasus tersebut.
2. Bagaimana persepsi nyeri ibu dipengaruhi oleh kondisi emosionalnya?
3. Jelaskan langkah komunikasi terapeutik yang harus dilakukan bidan pada tahap awal.
4. Apa bentuk dukungan emosional yang dapat diberikan kepada ibu?
5. Teknik relaksasi apa yang paling sesuai untuk kondisi ibu saat ini? Jelaskan alasannya.
6. Bagaimana cara melibatkan suami sebagai pendamping persalinan secara efektif?

Aktivitas 2 — *Shows How*
Simulasi / Skill Lab Kala II Persalinan

Fokus: Urutan Tindakan + Komunikasi + Keselamatan
Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti kegiatan ini, mahasiswa mampu:
1. Menunjukkan keterampilan dalam memberikan dukungan emosional pada ibu kala II persalinan.
2. Menerapkan komunikasi terapeutik secara efektif selama proses persalinan.
3. Mendemonstrasikan teknik relaksasi dan coaching meneran yang tepat.
4. Menjamin keselamatan ibu dan bayi selama proses persalinan.
5. Melaksanakan asuhan kebidanan kala II secara sistematis dan terstandar.

Deskripsi Kegiatan
Mahasiswa melakukan simulasi praktik di laboratorium keterampilan (*skill lab*) menggunakan manekin atau role play. Mahasiswa berperan sebagai bidan yang memberikan asuhan pada ibu bersalin kala II dengan kondisi fisiologis.
Kegiatan ini menekankan bahwa mahasiswa tidak hanya mengetahui teori (*knows*), tetapi mampu menunjukkan keterampilan secara nyata (*shows how*), khususnya dalam integrasi antara tindakan klinis, komunikasi terapeutik, dan aspek keselamatan.

Skenario Simulasi
Seorang perempuan usia 25 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 40 minggu, berada dalam kala II persalinan. Ibu tampak kesakitan saat kontraksi dan mengatakan "Saya tidak kuat, saya takut."
Hasil pemeriksaan:
- TD: 120/80 mmHg
- Nadi: 90 x/menit
- Suhu: 36,7°C
- RR: 22 x/menit
- Pembukaan lengkap (10 cm)
- Kepala janin sudah di Hodge III-IV

Pendamping (suami) berada di samping ibu.

Langkah Simulasi (Urutan Tindakan)

1. Persiapan dan Keselamatan
   - Mencuci tangan sesuai prosedur
   - Menyiapkan alat dan lingkungan yang aman
   - Memastikan privasi ibu terjaga
   - Mengidentifikasi ibu dan menjelaskan tindakan
2. Komunikasi Terapeutik Awal
   - Menyapa ibu dengan empati
   - Menenangkan ibu ("Ibu, saya akan mendampingi, kita lakukan bersama ya")
   - Menjelaskan kondisi bahwa persalinan sudah memasuki tahap akhir
3. Dukungan Emosional
   - Memberikan penguatan positif
   - Menjaga kontak mata dan sentuhan suportif
   - Melibatkan suami sebagai pendamping
4. Coaching Meneran
   - Mengajarkan teknik meneran yang benar
   - Mengarahkan ibu untuk meneran saat kontraksi
   - Mengingatkan ibu untuk istirahat saat tidak kontraksi
5. Teknik Relaksasi
   - Mengatur pernapasan sebelum dan setelah kontraksi
   - Membantu ibu fokus dan mengurangi panik
6. Aspek Keselamatan
   - Memantau kondisi ibu dan janin
   - Menghindari tindakan yang tidak perlu
   - Menjaga kebersihan dan pencegahan infeksi
7. Evaluasi Respons Ibu
   - Menilai kemampuan ibu mengikuti instruksi
   - Mengamati tanda kelelahan atau distress
   - Memberikan intervensi sesuai kebutuhan

Peran Mahasiswa

- Bertindak sebagai bidan
- Menunjukkan komunikasi terapeutik
- Memberikan dukungan emosional
- Mengajarkan teknik relaksasi dan meneran
- Menjaga keselamatan ibu dan bayi

Peran Penguji / Instruktur

- Mengobservasi keterampilan mahasiswa
- Menilai berdasarkan checklist
- Memberikan umpan balik langsung (*feedback*)
- Menguatkan aspek yang sudah baik dan memperbaiki kekurangan

Poin Penilaian Utama

1. Urutan tindakan sistematis
2. Komunikasi terapeutik (empati, bahasa, sikap)
3. Dukungan emosional
4. Kemampuan coaching meneran
5. Penerapan teknik relaksasi
6. Keselamatan pasien (patient safety)

TEMPLATE OSCE KEBIDANAN

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Dukungan Emosional dan Pendampingan Persalinan Kala I
3	Kasus	Ibu inpartu kala I fase aktif dengan kecemasan dan nyeri persalinan, membutuhkan dukungan emosional, komunikasi terapeutik, dan teknik relaksasi
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik sederhana (observasi kenyamanan dan nyeri) 3. Perumusan masalah kebidanan (nyeri dan kecemasan) 4. Prosedur tindakan nonfarmakologi (dukungan emosional & relaksasi) 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi (jika diperlukan) 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	**SKENARIO KLINIK:** Seorang perempuan, usia 25 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke ruang bersalin dengan keluhan mulas sejak 6 jam yang lalu. Ibu tampak cemas, mengatakan "Saya takut tidak kuat menahan sakitnya." Suami berada di samping ibu tetapi tampak pasif.Hasil pemeriksaan: TD 110/70 mmHg, N 92 x/menit, P 22 x/menit, S 36,8°C, his 3–4 kali/10 menit durasi 40 detik, DJJ 144 x/menit, pembukaan serviks 5 cm. **TUGAS:** 1. Lakukan komunikasi terapeutik kepada ibu. 2. Lakukan pengkajian nyeri dan kenyamanan secara sederhana .3. Sampaikan masalah kebidanan yang terjadi. 4. Berikan dukungan emosional kepada ibu. 5. Ajarkan teknik relaksasi/pernapasan yang sesuai. 6. Libatkan suami sebagai pendamping persalinan. 7. Berikan KIE singkat terkait kondisi ibu.
7	Instruksi penguji	**INSTRUKSI UMUM** 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian.

		2. Penulisan nomor peserta mengikuti ketentuan institusi/nasional. 3. Amati peserta dan beri penilaian:- Actual mark (0/1/2/3)- Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi selain yang ditentukan. **INSTRUKSI KHUSUS** 1. Jika peserta melakukan komunikasi dengan benar, PS merespons sesuai dialog. 2. Jika peserta melakukan pengkajian nyeri, penguji memberikan data:- Skala nyeri 6–7/10- Ibu tampak tegang dan meringis saat kontraksi 3. Tindakan yang diharapkan: - Menenangkan ibu dengan komunikasi empatik - Memberikan penguatan positif- Mengajarkan teknik napas dalam - Membantu ibu posisi nyaman (miring/duduk) -Melibatkan suami (memegang tangan, memberi dukungan) - Menjelaskan proses persalinan secara sederhana 4. Penguji hanya memberikan data jika diminta peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	**Instruksi PS:** 1. PS berperan sebagai ibu inpartu kala I fase aktif. 2. Tampak cemas, meringis saat kontraksi, memegang perut. 3. Mengatakan takut dan tidak kuat menahan nyeri. 4. Jika diberikan dukungan, menjadi lebih tenang. 5. Jika suami dilibatkan, PS tampak lebih nyaman.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan mendampingi ibu. PS: Iya, Bu. Peserta: Apa yang ibu rasakan sekarang? PS: Saya sakit sekali, Bu, takut tidak kuat. Peserta: Tarik napas pelan ya, Bu. PS: (mengikuti, mulai tenang) Peserta: Kita lakukan bersama, ya Bu. PS: Iya, Bu, saya coba. Peserta: Suami bisa membantu ya. PS: (lebih tenang)Catatan: Jawaban lain normatif.

10	Kebutuhan manikin	- Tempat tidur pasien - Phantom sederhana (opsional) - Tidak wajib pemeriksaan dalam
11	Kebutuhan laboran	- Menyiapkan ruangan - Menjaga kesiapan alat - Reset station
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur 2. Tensimeter 3. Stetoskop 4. Doppler/Pinard 5. Jam/stopwatch 6. Handrub 7. Sarung tangan 8. Kain penutup 9. Tisu
13	Penulis	Bdn. Nova Avianti Rahayu, M.Keb
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Standar Profesi Bidan* 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Standar Kompetensi Bidan*. 3. World Health Organization. (2018). *WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience*. 4. Simkin, P., & Bolding, A. (2004). Nonpharmacologic pain relief during labor. 5. Fraser, D. M., & Cooper, M. A. (2020). *Myles Textbook for Midwives*.

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)
Dukungan Emosional dan Pendampingan Persalinan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Dukungan Emosional Persalinan
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan klinis mahasiswa saat berinteraksi dengan pasien nyata. Penilai mengamati tindakan secara utuh, mencakup komunikasi, keterampilan klinis sederhana, profesionalisme, dan keselamatan pasien, kemudian memberikan umpan balik segera setelah tindakan selesai.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa memberikan dukungan emosional kepada ibu inpartu, melakukan komunikasi terapeutik, mengajarkan teknik relaksasi, serta melibatkan pendamping selama persalinan.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam memberikan asuhan yang berpusat pada ibu (*woman-centred care*), khususnya dalam mengelola nyeri dan kecemasan secara nonfarmakologis melalui komunikasi, relaksasi, dan dukungan emosional.	Mahasiswa dinilai dari kemampuannya mengenali kecemasan ibu, memberikan komunikasi empatik, membantu ibu mengontrol nyeri melalui teknik relaksasi, serta meningkatkan kepercayaan diri ibu selama persalinan.
Kasus klinik	Kasus diambil dari situasi nyata di lahan praktik yang relevan dengan capaian pembelajaran, seperti ibu inpartu dengan nyeri dan kecemasan selama kala I atau kala II persalinan.	Seorang perempuan 25 tahun, G1P0A0, kala I fase aktif, tampak cemas, mengatakan takut tidak kuat menahan nyeri. Suami berada di samping tetapi pasif.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa diamati saat melakukan tindakan nyata, bukan sekadar menjelaskan. Aktivitas meliputi komunikasi terapeutik, pengkajian nyeri,	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menilai skala nyeri dan kondisi emosional, memberikan dukungan verbal, mengajarkan

	pemberian dukungan emosional, pengajaran teknik relaksasi, serta fasilitasi peran pendamping.	teknik napas dalam, membantu posisi nyaman, serta melibatkan suami untuk mendukung ibu.
Aspek yang dinilai	Meliputi kemampuan komunikasi, empati, pengkajian nyeri, teknik relaksasi, keselamatan pasien, profesionalisme, dan kemampuan mengevaluasi respons ibu.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu memahami kondisi emosional ibu, memilih teknik relaksasi yang tepat, serta memberikan dukungan yang efektif tanpa meningkatkan kecemasan ibu.
Fokus observasi pembimbing	Fokus pada performa nyata mahasiswa dalam memberikan asuhan secara holistik dan berpusat pada ibu.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menenangkan ibu, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menjaga kontak terapeutik, dan melibatkan pendamping secara efektif.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, mencakup kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan saran perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah empatik dan komunikatif, namun perlu meningkatkan kejelasan instruksi teknik napas atau lebih aktif melibatkan pendamping.
Keputusan penilaian	Hasil DOPS dikategorikan menjadi: kompeten, perlu supervisi, atau remedial, berdasarkan performa klinis mahasiswa.	Mahasiswa dinyatakan kompeten jika mampu memberikan dukungan emosional secara efektif dan sistematis. Perlu supervisi jika masih kurang percaya diri. Remedial jika tidak mampu berkomunikasi terapeutik atau gagal membantu ibu mengatasi kecemasan.

Makna dalam OBE	DOPS menunjukkan capaian pembelajaran pada level *does*, karena mahasiswa dinilai saat melakukan praktik nyata. Metode ini memberikan bukti autentik kompetensi klinis dan profesional.	Pada topik ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori komunikasi dan relaksasi, tetapi mampu menerapkannya secara langsung dalam praktik klinik untuk meningkatkan kenyamanan ibu bersalin.

Tabel 4. 1 Portofolio pada Dukungan Emosional dan Pendampingan Persalinan

Komponen	**Deskripsi**	**Contoh pada Kasus Dukungan Emosional Persalinan**
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya satu kali ujian.	Pada topik ini, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik, mengkaji nyeri dan kecemasan ibu, memberikan dukungan emosional, mengajarkan teknik relaksasi, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, serta tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah mendampingi ibu bersalin, tetapi juga bagaimana kemampuannya dalam komunikasi, empati, dan teknik relaksasi meningkat setelah mendapatkan masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS menjadi bagian penting portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium (*shows*	OSCE memuat hasil simulasi komunikasi terapeutik, dukungan emosional, dan teknik relaksasi. DOPS

	how) dan performa nyata di lahan praktik (*does*).	memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa mendampingi ibu bersalin, membantu mengelola nyeri, dan melibatkan pendamping.
Catatan kasus singkat	Berisi ringkasan kasus pasien yang ditangani mahasiswa, meliputi data penting, masalah kebidanan, intervensi, dan hasil.	Mahasiswa menuliskan kasus ibu G1P0A0 kala I fase aktif dengan kecemasan dan nyeri, intervensi berupa komunikasi terapeutik, teknik napas, pelibatan suami, serta respons ibu yang menjadi lebih tenang.
Refleksi patient safety	Menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, termasuk aspek psikologis, serta menyusun langkah pencegahan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya komunikasi yang menenangkan, menghindari kata-kata yang meningkatkan kecemasan, menjaga privasi ibu, serta memastikan ibu tidak panik yang dapat memperburuk persepsi nyeri.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari CI/dosen menunjukkan kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah empatik dan mampu membangun hubungan baik, tetapi perlu meningkatkan kejelasan instruksi teknik relaksasi dan konsistensi dalam melibatkan pendamping.
Karakteristik penilaian	Portofolio bersifat berkelanjutan dan menekankan konsistensi performa mahasiswa dalam berbagai situasi.	Mahasiswa dinilai dari beberapa pengalaman praktik, apakah konsisten mampu memberikan dukungan emosional, komunikasi terapeutik, dan teknik relaksasi secara efektif.

Bukti konsistensi kompetensi	Menunjukkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan dan waktu yang berbeda.	Dari OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan feedback terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu menenangkan ibu, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kontrol diri ibu selama persalinan.
Makna dalam OBE	Portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tercapai secara nyata, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada topik ini, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami teori komunikasi dan relaksasi, tetapi mampu menerapkannya secara konsisten dalam praktik kebidanan.

Tabel 4. 2 Case Report pada Dukungan Emosional dan Pendampingan Persalinan

Komponen	**Deskripsi**	**Contoh pada Kasus Dukungan Emosional Persalinan**
Hakikat case report	*Case report* merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, *case report* menjadi bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan tentang seorang ibu bersalin primigravida pada kala I fase aktif yang mengalami kecemasan tinggi dan nyeri persalinan, serta membutuhkan dukungan emosional dan teknik relaksasi.
Tujuan	Menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan secara komprehensif.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan kondisi ibu, tetapi juga menjelaskan tingkat kecemasan, persepsi nyeri, intervensi komunikasi terapeutik, teknik relaksasi yang diberikan, serta perubahan respons ibu setelah intervensi.

Isi laporan	Isi *case report* mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Mahasiswa menuliskan ibu mengeluh nyeri kuat dan takut tidak mampu melahirkan, tampak cemas, skala nyeri 7/10, kontraksi adekuat, kemudian dilakukan komunikasi terapeutik, teknik napas dalam, pelibatan suami, serta evaluasi menunjukkan ibu lebih tenang dan mampu mengontrol napas saat kontraksi.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, kedalaman analisis psikologis, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi nonfarmakologis, serta kemampuan mengevaluasi respons ibu.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan kecemasan ibu dengan peningkatan persepsi nyeri, serta memilih intervensi seperti relaksasi dan dukungan emosional yang tepat.
Nilai edukatif	*Case report* membantu mahasiswa mengembangkan *clinical reasoning*, keterampilan dokumentasi, serta kemampuan refleksi terhadap praktik kebidanan berbasis bukti.	Mahasiswa belajar bahwa komunikasi terapeutik, dukungan emosional, dan teknik relaksasi berperan penting dalam mengurangi kecemasan dan meningkatkan kontrol diri ibu selama persalinan.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, *case report* menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis, reflektif, dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep dukungan emosional, tetapi mampu mendokumentasikan asuhan secara utuh dan menunjukkan dampaknya terhadap kenyamanan ibu bersalin.

Tabel 4. 3 Refleksi Patient Safety pada Dukungan Emosional dan Pendampingan Persalinan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Dukungan Emosional Persalinan
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi *patient safety* merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengenali risiko keselamatan pasien, termasuk aspek fisik dan psikologis, menganalisis potensi masalah, serta merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus ibu bersalin dengan kecemasan tinggi, mahasiswa merefleksikan bahwa kurangnya dukungan emosional dapat meningkatkan nyeri, memperburuk kondisi psikologis, dan menghambat kemajuan persalinan.
Tujuan	Menumbuhkan kesadaran bahwa keselamatan pasien tidak hanya terkait tindakan klinis, tetapi juga komunikasi, kenyamanan, dan kondisi emosional ibu.	Mahasiswa memahami bahwa komunikasi yang tidak tepat, sikap yang kurang empatik, atau mengabaikan kecemasan ibu dapat berdampak pada peningkatan stres dan persepsi nyeri.
Fokus refleksi	Meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, serta pembelajaran dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa fokus utama adalah kecemasan ibu, kurangnya dukungan pendamping, serta teknik relaksasi yang belum optimal sebagai faktor yang memengaruhi kenyamanan ibu.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu mampu mengenali situasi yang berpotensi membahayakan keselamatan fisik maupun psikologis pasien.	Risiko yang diidentifikasi antara lain kecemasan berlebihan, peningkatan persepsi nyeri, kelelahan ibu, kurangnya dukungan pendamping, komunikasi yang tidak efektif, serta kehilangan kontrol diri selama persalinan.

Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret untuk meminimalkan risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya komunikasi terapeutik, penggunaan bahasa yang menenangkan, pengajaran teknik relaksasi, pelibatan pendamping, menjaga privasi, serta memberikan informasi yang jelas dan bertahap kepada ibu.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan pembelajaran yang diperoleh dan dampaknya terhadap praktik selanjutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa dukungan emosional yang baik dapat meningkatkan kepercayaan diri ibu, menurunkan kecemasan, dan membantu ibu mengontrol nyeri secara lebih efektif.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi *patient safety* menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi dampak komunikasi dan dukungan emosional terhadap keselamatan dan kenyamanan ibu secara berkelanjutan.

I. Ringkasan

Persalinan kala I fase aktif dimulai pada pembukaan serviks 5 cm hingga pembukaan lengkap. Dalam praktik kebidanan terkini, penilaian kemajuan persalinan tidak hanya berfokus pada kecepatan pembukaan serviks, tetapi harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi ibu, janin, kekuatan his, penurunan bagian terendah janin, serta respons psikologis ibu. Pendekatan ini menekankan bahwa persalinan merupakan proses fisiologis yang dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial secara simultan.

Nyeri persalinan merupakan pengalaman subjektif yang sangat dipengaruhi oleh kecemasan, ketakutan, dukungan sosial, dan pengalaman sebelumnya. Kecemasan yang tidak teratasi dapat meningkatkan persepsi nyeri, menyebabkan ketegangan otot, mengganggu koordinasi kontraksi, dan pada akhirnya berpotensi

memperlambat kemajuan persalinan. Oleh karena itu, dukungan emosional menjadi bagian integral dalam asuhan kebidanan, bukan sekadar pelengkap.

Komunikasi terapeutik merupakan kunci dalam memberikan dukungan emosional yang efektif. Bidan harus mampu membangun hubungan saling percaya, menggunakan bahasa yang sederhana dan empatik, serta memberikan informasi yang jelas dan bertahap. Sikap tenang, kontak mata, sentuhan suportif, serta validasi perasaan ibu dapat membantu menurunkan kecemasan dan meningkatkan rasa aman. Selain itu, penerapan *informed choice* memungkinkan ibu untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan kontrol diri dan kepuasan terhadap pengalaman persalinan.

Strategi nonfarmakologi seperti teknik relaksasi, pengaturan napas, perubahan posisi, dan pelibatan pendamping terbukti efektif dalam membantu ibu mengelola nyeri. Teknik pernapasan yang terarah membantu ibu mengontrol respons terhadap kontraksi, sedangkan posisi yang nyaman dapat meningkatkan efektivitas kontraksi dan mempercepat penurunan janin. Kehadiran pendamping, seperti suami atau keluarga, memberikan dukungan emosional tambahan yang dapat meningkatkan kepercayaan diri ibu.

Dalam praktik, bidan harus mampu mengintegrasikan aspek klinis dan psikologis secara seimbang. Dukungan emosional tidak boleh mengabaikan keselamatan ibu dan janin. Bila ditemukan tanda kemajuan persalinan yang tidak memuaskan atau kondisi yang mengarah pada komplikasi, bidan tetap harus melakukan penilaian cepat, stabilisasi awal, dan eskalasi sesuai kewenangan. Dukungan emosional tetap diberikan selama proses tersebut untuk menjaga ketenangan dan kerja sama ibu.

Alur Asuhan Singkat

Ibu inpartu kala I fase aktif → lakukan pengkajian nyeri, kenyamanan, dan kondisi emosional → bangun komunikasi terapeutik → berikan dukungan emosional dan *informed choice* → ajarkan teknik relaksasi dan fasilitasi pendamping → lakukan pemantauan berkelanjutan (ibu dan janin) → dokumentasi → evaluasi

Tabel 4. 4 Red Flags & Eskalasi

Red flags	Makna klinis/psikologis	Tindakan eskalasi
Ibu tampak sangat cemas, panik, atau kehilangan kontrol diri	Risiko peningkatan persepsi nyeri, hiperventilasi, dan gangguan kemajuan persalinan	Lakukan komunikasi terapeutik intensif, teknik relaksasi napas, libatkan pendamping, evaluasi ulang kondisi ibu
Ibu tidak mampu mengikuti instruksi (napas/meneran)	Kelelahan, kecemasan tinggi, atau kurang pemahaman	Ulangi instruksi dengan bahasa sederhana, demonstrasi langsung, berikan dukungan verbal dan nonverbal
Nyeri tidak terkontrol meskipun sudah diberikan teknik nonfarmakologi	Perlu evaluasi ulang efektivitas intervensi atau kemungkinan komplikasi	Evaluasi kondisi ibu dan janin, modifikasi teknik relaksasi, pertimbangkan kolaborasi
Pendamping tidak hadir atau tidak berperan	Dukungan sosial kurang → meningkatkan kecemasan ibu	Edukasi dan libatkan pendamping secara aktif, atau tenaga kesehatan sebagai pendamping
Komunikasi tidak efektif (ibu tidak memahami penjelasan)	Risiko kesalahan tindakan dan meningkatnya kecemasan	Gunakan bahasa sederhana, ulangi informasi, pastikan *informed choice*
Ibu menolak tindakan tanpa memahami kondisi	Risiko keterlambatan penanganan	Berikan edukasi ulang dengan empatik, jelaskan risiko-manfaat, libatkan keluarga
Ibu tampak kelelahan ekstrem	Risiko penurunan kemampuan coping dan kemajuan persalinan terhambat	Anjurkan istirahat, posisi nyaman, dukungan emosional, evaluasi kondisi klinis
Respons emosional negatif terhadap tenaga kesehatan	Hubungan terapeutik terganggu	Bangun ulang komunikasi, gunakan pendekatan empatik dan non-judgmental

Lingkungan tidak mendukung (bising, tidak privat)	Meningkatkan stres dan ketidaknyamanan ibu	Perbaiki lingkungan: privasi, pencahayaan, kenyamanan
Muncul tanda klinis abnormal (DJJ tidak normal, kemajuan tidak adekuat, dll.)	Indikasi kemungkinan komplikasi obstetri	Tetap lakukan dukungan emosional sambil melakukan penilaian cepat, stabilisasi awal, dan eskalasi sesuai kewenangan

Form Checklist

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan konsep nyeri persalinan dan faktor yang memengaruhinya (psikologis, sosial, budaya)	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menjelaskan pentingnya dukungan emosional dalam persalinan	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa melakukan komunikasi terapeutik pada ibu bersalin	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa membangun hubungan saling percaya dengan ibu (rapport)	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa mengkaji tingkat nyeri dan kondisi emosional ibu	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa mengidentifikasi kecemasan atau ketakutan ibu selama persalinan	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa memberikan dukungan emosional secara verbal dan nonverbal	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa menerapkan komunikasi yang empatik dan tidak menghakimi	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa menjelaskan kondisi ibu dan proses persalinan dengan bahasa sederhana (*informed choice*)	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa mengajarkan teknik relaksasi/pernapasan kepada ibu	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa membimbing ibu melakukan teknik relaksasi saat kontraksi	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa membantu ibu menemukan posisi yang nyaman	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa melibatkan pendamping dalam mendukung ibu	☐	☐	_____

14	Saya sudah bisa mengevaluasi respons ibu terhadap intervensi yang diberikan	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa menjaga privasi, kenyamanan, dan keselamatan ibu	☐	☐	_____
16	Saya sudah bisa mendokumentasikan pengkajian dan intervensi secara sederhana	☐	☐	_____

Refleksi Singkat Mahasiswa:

Referensi

World Health Organization. (2018). *WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience*. Geneva: WHO.

World Health Organization. (2017). *Managing complications in pregnancy and childbirth: A guide for midwives and doctors (2nd ed.)*. Geneva: WHO.

International Confederation of Midwives. (2019). *Essential competencies for midwifery practice*. The Hague: ICM.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Standar Profesi Bidan: Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020*.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022*.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Revisi*. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pelayanan Antenatal, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI.

Simkin, Penny, & Bolding, Ann. (2004). *Update on nonpharmacologic approaches to relieve labor pain*. Journal of Midwifery & Women's Health.

Hodnett, Ellen D., et al. (2013). *Continuous support for women during childbirth*. Cochrane Database of Systematic Reviews.

Fraser, Diane M., & Cooper, Margaret A.. (2020). *Myles Textbook for Midwives* (16th ed.). Elsevier.

Cunningham, F. Gary, et al. (2018). *Williams Obstetrics* (25th ed.). McGraw-Hill.

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. (2015). *Care of women in labour*. London: RCOG.

Adams, E., & Bianchi, A. (2008). A practical approach to labor support. *Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing*, 37(1), 106–115.

Bobak, I. M., Lowdermilk, D. L., & Jensen, M. D. (2017). *Maternity Nursing* (10th ed.). St. Louis: Mosby Elsevier.

Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Spong, C. Y., & Dashe, J. S. (2018). *Williams Obstetrics* (25th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Fraser, D. M., & Cooper, M. A. (2020). *Myles Textbook for Midwives* (17th ed.). London: Elsevier.

Hodnett, E. D., Gates, S., Hofmeyr, G. J., Sakala, C., & Weston, J. (2013). Continuous support for women during childbirth. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 7.

Lothian, J. A. (2011). Lamaze breathing: What every pregnant woman needs to know. *Journal of Perinatal Education*, 20(2), 118–120.

Perry, S. E., Hockenberry, M. J., Lowdermilk, D. L., & Wilson, D. (2018). *Maternal Child Nursing Care* (6th ed.). St. Louis: Elsevier.

Simkin, P., & Bolding, A. (2004). Update on nonpharmacologic approaches to relieve labor pain and prevent suffering. *Journal of Midwifery & Women's Health*, 49(6), 489–504.

Smith, C. A., Levett, K. M., Collins, C. T., & Jones, L. (2018). Massage, reflexology and other manual methods for pain management in labour. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 3.

Varney, H., Kriebs, J. M., & Gegor, C. L. (2015). *Varney's Midwifery* (5th ed.). Burlington: Jones & Bartlett Learning.

Profil Penulis



Dr.Yeni Fitrianingsih.,SST.,MKes.

Lahir di Kuningan, 12 Desember 1969. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma 4 Pada Program Studi D4 Kebidanan Pendidik di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya lulus tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Magister Sain Terapan UNDIP lulus tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan S3 pada Program Studi DIKK (Doktoral Ilmu Kedokteran Kesehatan), Universitas Diponegoro (UNDIP) lulus tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1989 bekerja sebagai perawat di RS tahun 1990 – 2010 bekerja sebagai Bidan di Puskesmas Kab Sukabumi dan Kota Cirebon serta Paramedis Teladan TK Jawa Barat Tahun 1997. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya Kampus Cirebon mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan, Asuhan Kebidanan Neonatus dan bayi, Etika Hukum kesehatan dan Midwifery Entrepeneurship. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, Narasumber seminar dan sebagai Ketua IBI Kota Cirebon (Periode tahun 2018-2023)**,** Sebagai Surveyor KAKP Akreditasi Puskesmas dan Klinik, Reviuwer Penelitian Jurnal Internasional dan nasional versi SIMLITABKES , , Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yfitrianingsih44@gmail.com

Motto: **"Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts."** – Winston Churchill

Profil Penulis



Bdn. Dede Waslia, SST, MKM.

Lahir di Kadipaten, Tasikmalaya 16 Mei 1986. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D-IV Bidan Pendidik di Stikes Jend. Achmad Yani Cimahi dan lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Kesehatan Reproduksi, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Moch. Hamka, Jakarta tahun 2017. Pada tahun 2022 penulis menyelesaikan pendidikan Profesi Bidan di Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi. Selain pendidikan formal, penulis juga mengikuti berbagai pendidikan informal yang sesuai dengan bidang keilmuan. Saat ini penulis bekerja di Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi sebagai dosen pengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan & Bayi baru Lahir, Asuhan Kebidanan Kehamilan, dan Asuhan Kebidanan Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, melakukan publikasi dan mengikuti seminar serta pelatihan sesuai bidang keilmuan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dedewaslia@gmail.com Motto: “Kebahagiaan itu diciptakan, Masa Depan kita yang menentukan”

Profil Penulis



Ekta Puspita Sari, S.ST., M.Kes

Lahir di Pringsewu, Lampung, 30 April 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Kebidanan pada Program Studi Kebidanan, Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan D4 Kebidanan Pendidik pada Universitas Malahayati Bandar Lampung dan lulus tahun pada tahun 2013. Selanjutnya melanjutkan pendidikan S2 Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Mitra Indonesia dan lulus tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012 penulis bekerja di Akademi Kebidanan Alifa Pringsewu Lampung sampai dengan tahun 2017, setelah itu penulis bekerja di Akademi Kebidanan Wahana Husada Bandar Jaya dari tahun 2017 samapai dengan saat ini dengan mengampu mata kuliah Askeb Kehamilan, Askeb Persalinan dan BBL, Promosi Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, Kebutuhan Dasar Manusia, Etikolegal dalam Praktik Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar tentang penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ektapspascasarjanaumitra@gmail.com

Motto: "Mendidik dengan hati, menginspirasi dengan ilmu"



Bdn. Nova Avianti Rahayu, S.Tr.Keb., M.Keb.

Lahir di Ciamis, pada 5 September 1993. Menyelesaikan pendidikan Diploma III di Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kendal, Diploma IV Kebidanan di STIKES Ngudi Waluyo Ungaran dan S2 Kebidanan di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. Sampai saat ini penulis sebagai Dosen di Jurusan Kebidanan Universitas Muhammasiyah Riau.

Motto : "Mengajar dengan Hati, Berkarya Berbasis Bukti, Mengabdi untuk Kesehatan Ibu dan Bayi."

Sinopsis

Buku ajar *Manajemen Nyeri dan Kenyamanan Persalinan: Nonfarmakologi dan Farmakologi Dasar* disusun sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan, tenaga kesehatan, serta praktisi yang mempelajari asuhan persalinan secara komprehensif. Buku ini membahas konsep nyeri persalinan, respons fisiologis ibu dan janin, pengkajian nyeri, serta strategi pendampingan untuk meningkatkan kenyamanan ibu selama proses persalinan.

Nyeri persalinan merupakan pengalaman fisiologis yang kompleks dan dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, sosial, serta budaya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai manajemen nyeri tidak hanya berfokus pada pengurangan rasa nyeri, tetapi juga pada peningkatan rasa aman, nyaman, percaya diri, dan kemampuan ibu dalam menghadapi proses persalinan. Buku ini menekankan pentingnya pelayanan yang berpusat pada ibu, berbasis bukti, memperhatikan keselamatan, serta menghargai pilihan dan kebutuhan ibu bersalin.

Bab pertama membahas konsep dasar nyeri persalinan dan kenyamanan ibu, meliputi pengertian nyeri persalinan, prinsip manajemen nyeri, tujuan pemberian asuhan, serta aspek keselamatan ibu dan janin. Pada bagian ini, pembaca diarahkan untuk memahami bahwa kenyamanan ibu merupakan bagian penting dari kualitas pelayanan persalinan.

Bab kedua menguraikan fisiologi nyeri persalinan, termasuk sumber nyeri, jalur penghantaran nyeri, serta respons fisiologis yang terjadi pada ibu dan janin. Pembahasan ini menjadi dasar penting bagi tenaga kesehatan dalam memahami perubahan tubuh selama persalinan dan menentukan pendekatan asuhan yang tepat.

Bab ketiga membahas pengkajian nyeri dan kenyamanan ibu secara sistematis. Materi yang disajikan mencakup penggunaan skala nyeri, pengamatan tanda klinis, komunikasi dalam pengkajian, serta dokumentasi hasil pengkajian. Pengkajian yang tepat diperlukan agar intervensi yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan ibu.

Bab keempat membahas dukungan emosional dan pendampingan persalinan sebagai bagian dari manajemen nyeri nonfarmakologi. Topik yang diuraikan meliputi komunikasi terapeutik, teknik relaksasi, penguatan kontrol diri, serta peran pendamping dalam menciptakan suasana persalinan yang aman, nyaman, dan suportif.

Secara keseluruhan, buku ajar ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami dasar-dasar manajemen nyeri dan kenyamanan persalinan secara terarah, ilmiah, dan aplikatif. Materi yang disajikan dapat menjadi bekal dalam memberikan asuhan persalinan yang humanis, aman, efektif, serta berorientasi pada kebutuhan ibu dan keselamatan janin.

Buku ajar Manajemen Nyeri dan Kenyamanan Persalinan: Nonfarmakologi dan Farmakologi Dasar disusun sebagai sumber pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan, tenaga kesehatan, serta praktisi yang mempelajari asuhan persalinan secara komprehensif. Buku ini membahas konsep nyeri persalinan, respons fisiologis ibu dan janin, pengkajian nyeri, serta strategi pendampingan untuk meningkatkan kenyamanan ibu selama proses persalinan.

Nyeri persalinan merupakan pengalaman fisiologis yang kompleks dan dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, sosial, serta budaya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai manajemen nyeri tidak hanya berfokus pada pengurangan rasa nyeri, tetapi juga pada peningkatan rasa aman, nyaman, percaya diri, dan kemampuan ibu dalam menghadapi proses persalinan. Buku ini menekankan pentingnya pelayanan yang berpusat pada ibu, berbasis bukti, memperhatikan keselamatan, serta menghargai pilihan dan kebutuhan ibu bersalin.

Bab pertama membahas konsep dasar nyeri persalinan dan kenyamanan ibu, meliputi pengertian nyeri persalinan, prinsip manajemen nyeri, tujuan pemberian asuhan, serta aspek keselamatan ibu dan janin. Pada bagian ini, pembaca diarahkan untuk memahami bahwa kenyamanan ibu merupakan bagian penting dari kualitas pelayanan persalinan.

Bab kedua menguraikan fisiologi nyeri persalinan, termasuk sumber nyeri, jalur penghantaran nyeri, serta respons fisiologis yang terjadi pada ibu dan janin. Pembahasan ini menjadi dasar penting bagi tenaga kesehatan dalam memahami perubahan tubuh selama persalinan dan menentukan pendekatan asuhan yang tepat.

Bab ketiga membahas pengkajian nyeri dan kenyamanan ibu secara sistematis. Materi yang disajikan mencakup penggunaan skala nyeri, pengamatan tanda klinis, komunikasi dalam pengkajian, serta dokumentasi hasil pengkajian. Pengkajian yang tepat diperlukan agar intervensi yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan ibu.

Bab keempat membahas dukungan emosional dan pendampingan persalinan sebagai bagian dari manajemen nyeri nonfarmakologi. Topik yang diuraikan meliputi komunikasi terapeutik, teknik relaksasi, penguatan kontrol diri, serta peran pendamping dalam menciptakan suasana persalinan yang aman, nyaman, dan suportif.

Secara keseluruhan, buku ajar ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami dasar-dasar manajemen nyeri dan kenyamanan persalinan secara terarah, ilmiah, dan aplikatif. Materi yang disajikan dapat menjadi bekal dalam memberikan asuhan persalinan yang humanis, aman, efektif, serta berorientasi pada kebutuhan ibu dan keselamatan janin.

Penerbit:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-89-3 (PDF)
9 786347 756893